
Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie du post-partum entre 2023 et 2030



Organisation
mondiale de la Santé

human
reproduction
programme **hrp.**
research for impact
UNDP · UNFPA · UNICEF · WHO · WORLD BANK

Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie du post-partum entre 2023 et 2030



**Organisation
mondiale de la Santé**

human
reproduction
programme **hrp**
research for impact

UNDP · UNFPA · UNICEF · WHO · WORLD BANK

Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie du post-partum entre 2023 et 2030 [A Roadmap to combat postpartum haemorrhage between 2023 and 2030]

ISBN 978-92-4-009680-6 (version électronique)

ISBN 978-92-4-009681-3 (version imprimée)

© Organisation mondiale de la Santé 2024

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie du post-partum entre 2023 et 2030 [A Roadmap to combat postpartum haemorrhage between 2023 and 2030]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2024. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://iris.who.int/?locale-attribute=fr&>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <https://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Table des matières

Avant-propos	v
Remerciements	vii
Abréviations	ix
Résumé d'orientation	xi
1. Introduction et justification	1
1.1 L'hémorragie du post-partum : un problème de santé publique mondial	1
1.2 Pourquoi une Feuille de route est-elle nécessaire pour lutter contre l'HPP ?	1
1.3 Public cible	3
1.4 Objectif et champ d'application de la Feuille de route	3
2. Élaboration de la Feuille de route	5
2.1 Participants au Sommet sur l'hémorragie du post-partum et contributeurs à la Feuille de route	5
2.2 En amont du Sommet sur l'hémorragie du post-partum : identification des lacunes dans les différents domaines stratégiques	6
2.3 Au Sommet sur l'hémorragie du post-partum : obtention d'un consensus sur les lacunes à combler en priorité et les solutions à apporter	9
2.4 Résultats du Sommet sur l'hémorragie du post-partum : intégration des solutions à mettre en œuvre en priorité dans une Feuille de route et un appel à l'action	11
2.5 Déclaration d'intérêts des contributeurs externes	12
3. La Feuille de route	13
3.1 Domaine stratégique concernant la recherche	13
3.2 Domaine stratégique concernant les normes et les règles	15
3.3 Domaine stratégique concernant la mise en œuvre	19
3.4 Domaine stratégique concernant le plaidoyer	26
3.5 Interdépendances entre les quatre domaines stratégiques de la Feuille de route	32
4. Appel mondial à l'action	33
5. Mise en œuvre de la Feuille de route	37
5.1 Leadership et gouvernance au niveau mondial	37
5.2 Adaptation au contexte local	37
5.3 Impact attendu de la Feuille de route	38
6. Diffusion de la Feuille de route et l'appel à l'action	40
7. Suivi et évaluation de l'impact	41

8.	Planification des futures mises à jour	42
9.	Références bibliographiques	43

Annexes

Annexe 1	Liste des personnes ayant contribué à la rédaction du document	45
Annexe 2	Organigramme de l'établissement des priorités en matière de recherche sur l'hémorragie du post-partum	56
Annexe 3	Identification des lignes directrices déjà publiées pour aider à l'élaboration d'une cartographie des recommandations relatives à l'hémorragie du post-partum	57
Annexe 4	Carte thermique des résultats de l'enquête sur les obstacles à la mise en œuvre	58

Tableaux

Tableau 2.1	Catégories d'obstacles à la mise en œuvre	10
Tableau 3.1	Les 15 premières questions de recherche prioritaires, par domaine	16
Tableau 3.2	Principales catégories d'obstacles à la mise en œuvre et mesures prioritaires pour les lever	22
Tableau 4.1	Actions clés pour que les activités menées en vue d'éliminer les décès évitables dus à l'hémorragie du post-partum (HPP) soient efficaces et coordonnées	35

Figures

Figure 1.	Principaux jalons de la Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie post-partum (HPP) entre 2023 et 2030	xix
Figure 3.1	Activités clés et principaux jalons pour le premier domaine stratégique : la recherche	17
Figure 3.2	Activités clés et principaux jalons pour le deuxième domaine stratégique : les normes et les critères	21
Figure 3.3	Activités clés et principaux jalons pour le troisième domaine stratégique : la mise en œuvre	27
Figure 3.4	Activités clés et principaux jalons pour le quatrième domaine stratégique : le plaidoyer	29
Figure 3.5	Interdépendances entre les quatre domaines stratégiques de la Feuille de route	32

Avant-propos

Chaque année, des millions de femmes sont victimes d'une hémorragie du post-partum (HPP), généralement définie comme une perte de 500 ml ou plus de sang dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Cette pathologie, qu'il est possible de prévenir et de traiter, reste la principale cause de décès maternel dans le monde, malgré des dizaines d'années d'efforts et l'existence d'interventions efficaces permettant de sauver des vies.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a bien publié des orientations complètes sur la prévention et le traitement de l'HPP, mais, dans de nombreuses régions du monde, ces recommandations ne se sont pas traduites par une réduction significative de la morbidité et de la mortalité liées à cette pathologie. Le taux de mortalité maternelle au niveau mondial (estimé en 2020 à 223 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes) reste en effet bien supérieur à la cible 3.1 définie dans les objectifs de développement durable (ODD), à savoir un maximum de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes d'ici à 2030. Et les avancées obtenues marquent le pas depuis plusieurs années.

En mars 2023, l'OMS a organisé un Sommet mondial sur l'HPP dans le but de redynamiser les efforts déployés. Les participants, venant d'horizons très différents, étaient des représentants de gouvernements (ministères de la santé), de différents métiers de la santé, d'institutions de recherche et d'universités, d'associations professionnelles, d'organisations non gouvernementales nationales et internationales, d'organisations de la société civile, d'organismes donateurs, d'entités ayant contribué à des innovations dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que du secteur privé. Au cours des mois qui ont précédé et suivi ce Sommet, les participants ont travaillé ensemble à l'élaboration d'un programme commun visant à éliminer les décès évitables dus à l'HPP. Cette *Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie du post-partum entre 2023 et 2030* est le résultat de ce travail collectif.

La présente feuille de route s'articule autour de quatre domaines stratégiques qui reflètent une approche globale selon laquelle science et action stratégique agissent en synergie pour faire progresser sensiblement et durablement la lutte contre l'HPP. Pour commencer, elle aborde le sujet de la recherche, indispensable à l'établissement d'une base de données probantes sur laquelle devra s'appuyer toute nouvelle intervention. Elle traite ensuite des normes et des critères, qui constituent les orientations techniques permettant de recommander ou de déconseiller une intervention particulière ou les outils destinés à faciliter la mise en œuvre. Puis elle porte sur la mise en œuvre et la myriade de facteurs qui déterminent si une intervention recommandée sera transposée dans la pratique clinique et, le cas échéant, sur la manière de le faire. Enfin, elle donne des pistes pour intensifier le plaidoyer, aspect essentiel pour passer aisément et rapidement de la recherche à la pratique et ainsi permettre aux femmes et aux cliniciens d'accéder aux ressources nécessaires permettant de sauver des vies.

Cette Feuille de route vient soutenir les actions menées actuellement au niveau mondial pour améliorer la santé et le bien-être des mères, sous l'impulsion de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (2016-2030) ainsi que du Plan d'action « Chaque nouveau-né » et de la stratégie Mettre un terme aux décès maternels évitables mis en œuvre dans les pays. Des démarches sont en cours pour que les activités prévues dans la Feuille de route soient intégrées dans le travail en cours visant à aider les pays à avancer au plus vite vers l'instauration d'une couverture sanitaire universelle (CSU).

Il est important de souligner que cette Feuille de route ne relève pas d'une seule organisation. Il s'agit plutôt d'un plan concerté, élaboré et à exécuter de manière conjointe, en vue de construire un avenir permettant aux mères, aux familles et aux communautés de s'épanouir. Nous invitons l'ensemble des parties prenantes concernées à participer à la réalisation des activités qui y sont proposées.



Dr Jeremy Farrar

Scientifique en chef
Organisation mondiale de la Santé

Dr Bruce Aylward

Sous-Directeur général,
Couverture sanitaire universelle, Parcours de vie
Organisation mondiale de la Santé

Remerciements

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) remercie vivement les nombreuses personnes et organisations qui ont contribué à l'élaboration de cette Feuille de route.

Elle adresse notamment ses sincères remerciements à tous les membres du **comité d'orientation** : Hadiza Galadanci (coprésidente ; Bayero University, Nigéria), Suellen Miller [coprésidente ; University of California, San Francisco, États-Unis d'Amérique (USA)], Sabaratnam Arulkumaran [St. George's, University of London, Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni)], Jolly Beyeza-Kashesya [Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO), Royaume-Uni ; Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital, Ouganda], Michel Brun [Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), USA], Rizwana Chaudhri (Shifa Tameer-e-Millat University, Pakistan), Sue Fawcus (University of Cape Town, Afrique du Sud), Caroline Homer (Burnet Institute, Australie), Pete Lambert (Monash University, Australie), Cammie Lee [Results for Development (R4D), USA], Elliott Main (Stanford University School of Medicine, USA), Alison Morgan (Global Financing Facility, USA), Richard Mugahi (Ministry of Health, Ouganda), Angela Nguku (White Ribbon Alliance Kenya, Kenya), Hrishikesh Pai (Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India, Inde), Daisy Ruto (Jhpiego, Smiles for Mothers Project, Kenya), Patricia Titulaer [Confédération internationale des sages-femmes (ICM), Royaume des Pays-Bas (Pays-Bas) ; Laerdal Global Health, Pays-Bas] ; et Pauline Williams (consultante indépendante en médecine pharmaceutique, Royaume-Uni).

Des remerciements particuliers sont adressés aux personnes ayant contribué aux processus suivis pour établir des priorités avant et pendant le Sommet mondial sur l'hémorragie du post-partum (Sommet sur l'HPP) qui s'est tenu à Dubaï en mars 2023 dans le cadre du processus d'élaboration de la Feuille de route. Il s'agit des membres du personnel de l'OMS suivants : Allisyn Moran, Uzma Syed et Sachiyo Yoshida (Département Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, et vieillissement), Pascale Allotey, Fernando Althabe et Mariana Widmer (Département Santé sexuelle et reproductive, et recherche). Il s'agit également des membres du **Comité scientifique** : Edgardo Abalos [Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Argentine], Lester Chinery (Concept Foundation, Suisse), Arri Coomarasamy (University of Birmingham, Royaume-Uni), Adam Devall (University of Birmingham, Royaume-Uni), Virginia Diaz [Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP), Argentine], A. Metin Gülmezoglu (Concept Foundation, Suisse) et Dilys Walker (University of California, San Francisco, USA). Il s'agit enfin des contributeurs externes suivants : Sylvia Alford [Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), USA], Mónica Chamillard (CREP, Argentine), Cherrie Evans (Jhpiego, USA), Ryan Fitzgerald (Exemplars in Global Health, USA), Celina Gialdini (CREP, Argentine), Gloria Ikilezi (Exemplars in Global Health, USA), Julia Pasquale (CREP, Argentine), Jenny Ramson (Ampersand Health Science Writing Pty Ltd, Australie), Sara Rushwan (Concept Foundation, Suisse), Jordan-Tate Thomas (Exemplars in Global Health, USA), Hayfaa Wahabi (Université du Roi Saoud, Royaume d'Arabie saoudite) et Caitlin R. Williams [Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy (IECS-Argentine), Argentine].

L'OMS tient à remercier pour leurs commentaires les nombreuses parties prenantes au niveau international qui ont participé au Sommet sur l'HPP. Les institutions auxquelles sont rattachés les différents participants à ce Sommet sont indiquées à l'annexe 1 de ce document.

La préparation des documents d'information, le travail d'animation lors du Sommet sur l'HPP et la rédaction de la Feuille de route (avant que le document ne soit examiné par le comité d'orientation et l'équipe de coordination de l'OMS) ont été effectués par des membres du Boston Consulting Group (BCG) : Guervan Adnet, Johanna Benesty, Sarah Chamberlain, Louis-Victor Dorat, Raphaëlle Kemoun, Hachani Rim et Asher Steene. Le document final, élaboré à partir du projet de document préparé par ce groupe, a été rédigé et révisé (afin d'intégrer les contributions de l'ensemble des participants au Sommet sur l'HPP ainsi que d'autres parties prenantes) par Ioannis Gallos et Olufemi Oladapo (Département Santé sexuelle et reproductive, et recherche de l'OMS) et par Caitlin R. Williams (Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy). L'examen par des pairs a été assuré par Sylvia Alford (USAID), Cherrie Evans (Jhpiego) et Hayfaa Wahabi (Université du Roi Saoud). La révision technique du document a été effectuée par Jane Patten (Green Ink Publishing Services Ltd).

La coordination générale du processus d'élaboration de cette Feuille de route a été assurée par Ioannis Gallos et Olufemi Oladapo du Département Santé sexuelle et reproductive, et recherche de l'OMS. Natalie Bailey et Victoria Holdsworth, qui travaillent pour ce même Département, ont assuré le soutien en communication pour le Sommet sur l'HPP et la publication de la Feuille de route.

L'élaboration de cette Feuille de route a été financée par MSD for Mothers et la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les traductions de l'anglais vers les autres langues des Nations Unies ont été soutenues par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

Abréviations

CHNRI	Child Health and Nutrition Research Initiative
CSU	couverture sanitaire universelle
FIGO	Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique
FNUAP	Fonds des Nations Unies pour la population
GFF	Mécanisme mondial de financement de l'initiative Toutes les femmes, tous les enfants (en anglais, Global Financing Facility)
HPP	hémorragie du post-partum
HRP	Programme spécial PNUD/FNUAP/UNICEF/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (en anglais, UNDP-UNFPA-UNICEF-WHO-World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction) (appelé aussi le Human Reproduction Programme)
ICM	Confédération internationale des sages-femmes (en anglais, International Confederation of Midwives)
IM	par voie intramusculaire
IMNHC	Conférence internationale sur la santé maternelle et néonatale (en anglais, International Maternal Newborn Health Conference)
IV	par voie intraveineuse
Jhpiego	Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics
ODD	objectif de développement durable
OMS	Organisation mondiale de la Santé
ONG	organisation non gouvernementale
ONUSIDA	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
OSC	organisation de la société civile
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement (en anglais, United Nations Development Programme)
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance (en anglais, United Nations Development Programme)
USA	États-Unis d'Amérique (en anglais, United States of America)
USAID	Agence des États-Unis pour le développement international (en anglais, United States Agency for International Development)

Résumé d'orientation

Introduction et justification

L'hémorragie du post-partum (HPP), est généralement définie comme une perte de 500 ml ou plus de sang dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Elle concerne des millions de femmes chaque année, et elle est responsable de plus de 20 % de l'ensemble des décès maternels recensés dans le monde. Une grande partie des décès dus à l'HPP pourraient être évités, et ils ont été quasiment éliminés dans les pays à revenu élevé. Pourtant, les femmes des pays à revenu faible ou intermédiaire continuent à être affectées de manière disproportionnée. La plupart des décès maternels dus à une HPP se produisent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Le taux de mortalité maternelle au niveau mondial était estimé à 223 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2020, ce qui montre clairement que les pays ont pris un retard considérable dans l'atteinte de la cible 3.1 de l'objectif 3 de développement durable (ODD 3), à savoir la réduction de ce taux à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici à 2030. En outre, les progrès en matière de réduction de la mortalité maternelle ont stagné au cours des 5 à 10 dernières années, et les projections pour les années qui nous séparent de 2030 sont inquiétantes. Il est donc indispensable de prendre des mesures radicales pour modifier cette trajectoire.

En dépit de la nécessité évidente de s'attaquer à ce qui constitue la principale cause des décès maternels, les mesures prises à l'échelle mondiale pour lutter contre l'HPP restent insuffisantes. Des lacunes importantes sur la manière de prévenir, de détecter et de traiter efficacement l'HPP doivent encore être comblées. Les investissements dans la **recherche** visant à identifier des interventions efficaces pour lutter contre l'HPP et à déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre les interventions dont l'effet est avéré restent fragmentés. Cette fragmentation complique les efforts déployés pour unifier les recommandations à l'échelle mondiale et soutenir les politiques nationales visant à améliorer la prise en charge de l'HPP et les résultats en matière de lutte contre ce problème de santé. Les entités qui conçoivent des **normes** et des **critères** aux niveaux mondial, régional et national continuent à faire réaliser chacune de leur côté des synthèses de données coûteuses et laborieuses, ce qui entraîne des redondances dans les activités et un manque de concordance dans les documents d'orientation produits par les différents auteurs. Cette situation peut engendrer des incertitudes chez les utilisateurs finaux visés (les responsables de l'élaboration des politiques des ministères de la santé, les responsables de la santé et les agents de santé), qui ont parfois du mal à décider quelles orientations adopter ; cela est particulièrement le cas dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La **mise en œuvre** d'interventions efficaces est également rendue difficile du fait d'obstacles complexes allant au-delà de la simple adoption de normes mondiales. Ces obstacles sont encore mal connus, car ils sont souvent spécifiques au contexte et dépendent parfois de processus politiques qui ne relèvent pas des attributions habituelles de ceux qui pilotent les activités de lutte contre l'HPP. Comme cela a été constaté dans le cas d'autres maladies, les initiatives de **plaidoyer** menées par les organisations de la société civile (OSC) et les organisations non gouvernementales (ONG) peuvent jouer un important rôle de catalyseur au niveau mondial, mais elles sont généralement sous-utilisées dans le cadre de la lutte contre l'HPP. Le fait d'établir de manière concertée des programmes clairs pour chacun de ces quatre domaines stratégiques permettrait de mieux structurer et de rendre plus cohérent le travail sur le terrain.

Consciente de la nécessité croissante de mener une action à l'échelle mondiale pour améliorer la prévention et la prise en charge de l'HPP, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a travaillé de concert avec les principales parties prenantes pour élaborer cette « Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie du post-partum ». La Feuille de route décrit les objectifs à remplir, les activités à mener et les jalons à atteindre en ce qui concerne la recherche, le travail normatif (c'est-à-dire la définition de normes et de critères), la mise en œuvre et le plaidoyer au niveau mondial entre 2023 et 2030 afin de répondre aux principales priorités en matière d'HPP et d'accélérer les progrès pour parvenir à la cible 3.1 des ODD. Elle définit un cadre stratégique innovant, axé sur les solutions et adapté aux besoins, et centré sur les objectifs et les priorités en matière de santé maternelle des pays où l'HPP représente une charge importante ; elle appelle aussi à investir dans différents domaines cruciaux des systèmes de santé, en mettant tout particulièrement l'accent sur les pays à revenu faible ou intermédiaire. Elle vise à harmoniser les actions menées et à favoriser la coopération entre tous les partenaires travaillant dans le domaine de l'HPP en fixant des objectifs dans les secteurs de la technique, des investissements et des politiques qui permettront de répondre aux priorités fondamentales des initiatives mondiales en cours en faveur de la santé des mères et des nouveau-nés.

Élaboration de la Feuille de route

L'élaboration de cette Feuille de route s'est appuyée sur un examen détaillé de la situation sur le terrain en ce qui concerne les quatre domaines stratégiques identifiés (recherche, normes et critères, mise en œuvre et plaidoyer), ainsi que sur un grand nombre de contributions et autres apports, issus d'enquêtes en ligne et de discussions en personne, venant d'un large groupe de parties prenantes travaillant dans ces domaines au niveau international et national. Afin de garantir que l'examen de chacun des quatre domaines stratégiques soit rigoureux et conforme au consensus prévalant dans la communauté mondiale sur les priorités essentielles des actions à mener de manière concertée, le programme à suivre pour chacun de ces domaines a été défini de manière indépendante selon un processus systématique en plusieurs étapes. L'OMS a mis en place un comité d'orientation afin d'assurer la supervision et de fournir des orientations méthodologiques pour identifier et classer par ordre de priorité les lacunes en matière de recherche, de normes et de critères, de mise en œuvre et de plaidoyer. Elle a aussi invité un large éventail de parties prenantes [issues de gouvernements (ministères de la santé), appartenant à différents métiers de la santé, provenant d'institutions de recherche et d'universités, d'associations professionnelles, d'ONG nationales et internationales, d'OSC, d'organismes donateurs, d'entités ayant contribué à des innovations dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que du secteur privé] à prendre part à un processus participatif dont le point d'orgue a été la tenue d'une réunion mondiale dans le but de définir ce que doit être l'avenir de la lutte contre l'HPP.

Le processus suivi lors de la définition du programme de **recherche** a respecté l'approche systématique de l'OMS pour établir des priorités en matière de recherche. Pour identifier les lacunes existantes, une première liste détaillée de questions de recherche a été établie sur la base des contributions reçues du groupe des parties prenantes et des priorités de recherche qui se dégageaient des lignes directrices de l'OMS et d'autres lignes directrices internationales, d'exams systématiques, de l'analyse des médicaments et des dispositifs médicaux destinés à lutter contre l'HPP en cours d'élaboration, et des questions restées sans réponse au cours d'exercices déjà menés pour établir des priorités dans le domaine de la santé sexuelle, reproductive et maternelle. Après un processus de sélection et de regroupement, 72 questions de recherche ont été retenues et réparties en trois catégories (innovation, mise en œuvre et questions transversales) ; un score et un ordre de priorité ont ensuite été établis par ces mêmes parties prenantes pour chacune d'entre elles en fonction de cinq critères. Les 10 questions classées en tête dans chaque catégorie (30 questions au total) ont ensuite été choisies pour servir de base aux discussions et à l'établissement des priorités

lors d'une réunion organisée en présentiel, le Sommet mondial sur l'hémorragie du post-partum (le Sommet sur l'HPP).

Concernant le domaine stratégique des **normes et critères**, une revue systématique des lignes directrices internationales et nationales déjà publiées et remplissant des critères spécifiques a été effectuée afin d'identifier les lacunes éventuelles dans les recommandations existantes en matière d'HPP et d'évaluer la concordance des différents documents. Les données probantes ayant servi de base à chaque recommandation existante en matière d'HPP ont également été examinées, et de nouvelles recherches de données probantes ont été effectuées pour identifier les nouvelles données probantes susceptibles d'avoir un impact, et déterminer la nécessité de formuler de nouvelles recommandations de l'OMS ou d'actualiser les recommandations existantes.

Une stratégie en plusieurs volets a été adoptée en vue de mieux cerner les obstacles pouvant entraver la **mise en œuvre**. Pour mieux comprendre les difficultés liées au contexte expliquant la lenteur avec laquelle sont prises en compte les connaissances existantes et sont mises en application les recommandations fondées sur des données probantes en matière d'HPP et identifier quels sont les blocages qui peuvent exister au niveau des pays, l'OMS a sélectionné trois exemples de pays représentant des contextes différents : le Nigéria, le Pakistan et la République-Unie de Tanzanie. Une analyse concernant sept pays ayant réalisé des progrès notables en matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale a également été effectuée afin d'en tirer des enseignements et d'identifier les meilleures pratiques permettant d'éliminer les blocages à la mise en œuvre. Par ailleurs, un cadre de conditions préalables essentielles à remplir pour une mise en œuvre réussie des recommandations existantes en matière d'HPP a été élaboré. Une enquête en ligne a ensuite été menée auprès du groupe de parties prenantes pour déterminer dans quelle mesure ces conditions préalables étaient remplies pour les interventions recommandées. Et une triangulation a été effectuée entre les réponses obtenues lors de cette enquête et les données fournies par les établissements de soins indiquant dans quelle mesure les femmes bénéficiaient des différentes interventions recommandées dans chaque situation.

Pour parvenir à une vision commune sur les lacunes en matière de **plaidoyer** en faveur de la lutte contre l'HPP et établir des priorités, une vue d'ensemble de la situation mondiale actuelle sur le sujet a été établie afin d'identifier les principales organisations et initiatives actives dans le domaine et mettre en évidence les faiblesses et les principales lacunes existant dans l'écosystème actuel. Parallèlement, une vue d'ensemble similaire de la situation prévalant au niveau mondial dans d'autres écosystèmes du secteur de la santé (par exemple, en ce qui concerne la planification familiale et la lutte contre le VIH et le sida) a été réalisée afin d'identifier les initiatives en matière de plaidoyer ayant fait preuve d'efficacité et susceptibles d'être reproduites dans le domaine de la lutte contre l'HPP.

Les résultats des activités décrites ci-dessus ont servi de base aux discussions qui se sont tenues entre les 138 participants au Sommet sur l'HPP organisé par l'OMS du 7 au 10 mars 2023 à Dubaï (Émirats arabes unis). Ces résultats ont été présentés lors des séances plénières et des réunions en groupes restreints afin d'aider les différentes parties prenantes à prendre des décisions éclairées sur les lacunes à combler en première priorité ainsi que sur les ensembles de solutions correspondants, et de permettre l'élaboration d'un programme clair d'activités à mener collectivement et présenté sous la forme d'une feuille de route. La Feuille de route qui en a résulté est le fruit de la synthèse des données, des contributions des différentes parties prenantes et de la consolidation des solutions et des plans d'action proposés à l'issue du Sommet.

La Feuille de route

La Feuille de route définit un ensemble d'actions prioritaires clés et un calendrier de mise en œuvre afin de remédier à la charge que représente l'HPP et réduire la mortalité et la morbidité connexes, conformément à ce qui a été convenu par les différentes parties prenantes lors du Sommet sur l'HPP de 2023. Elle a été élaborée et structurée sur la base de quatre domaines stratégiques interdépendants (la recherche, les normes et les critères, la mise en œuvre et le plaidoyer) jouant un rôle crucial pour catalyser les activités et atteindre rapidement les objectifs des pays en matière de prévention des décès maternels. Pour chaque domaine stratégique, la Feuille de route présente les actions spécifiques à mener et les résultats attendus pour la période allant de 2023 à 2030 ; elle constitue ainsi un document de référence essentiel pour les sept années à venir. Une vue d'ensemble d'un certain nombre de ces actions et des résultats attendus est présentée à la Figure 1. Des informations sur chacun des domaines stratégiques sont résumées ci-dessous et détaillées au chapitre 3 avec une figure.

Domaine stratégique de la recherche

La recherche joue un rôle fondamental pour obtenir des avancées en vue de résoudre les problèmes de santé, et ce quel que soit le problème considéré. Toute situation stationnaire dans la recherche, y compris dans la recherche sur la mise en œuvre, risque de nuire aux initiatives visant à réduire les risques liés à l'HPP ainsi que la mortalité et la morbidité maternelles qui en découlent. Un alignement des différentes parties prenantes sur les lacunes à combler en priorité en matière de recherche concernant l'HPP doit permettre de mieux cibler les investissements, de réduire le gaspillage ainsi que les redondances en matière de financement et d'activités de recherche, et d'apporter des réponses plus rapides et plus efficaces aux besoins en matière de santé publique. Quinze questions de recherche relevant des trois domaines que sont l'innovation, la mise en œuvre et les questions transversales ont été jugées particulièrement importantes pour faire progresser les connaissances pouvant déboucher sur des mesures concrètes concernant la lutte contre l'HPP d'ici à 2030 (et au-delà de 2030 en ce qui concerne les priorités de recherche relevant du domaine de l'innovation, celle-ci mettant souvent plus de temps à se traduire par un impact tangible). La principale question pour chacun des différents domaines préconisait ce qui suit : concernant l'innovation, une recherche comparant l'efficacité et la sécurité de différentes voies d'administration alternatives (c'est-à-dire autres que la voie intraveineuse) de l'acide tranexamique dans le traitement de l'HPP ; concernant la mise en œuvre, l'identification des obstacles et des éléments pouvant faciliter l'adoption et l'utilisation des recommandations fondées sur des données probantes relatives à la prise en charge de l'HPP ; et concernant les questions transversales, la détermination de l'efficacité d'une stratégie de détection précoce de l'HPP et de traitement de première urgence faisant appel à un ensemble d'interventions recommandées pour améliorer les résultats en cas d'HPP. Les prochaines étapes consisteront pour l'OMS et ses partenaires à préciser la formulation des 15 premières questions de recherche prioritaires afin de les rendre plus claires, à faire un point rapide sur les travaux de recherche en cours, à formuler les questions de recherche les plus adaptées, à déterminer la structure la plus adaptée pour les études à mener, à élaborer des profils de politiques cibles indiquant les travaux de recherche encore nécessaires pour étayer les décisions politiques, à préciser les pistes à suivre en matière d'innovation et les types de données nécessaires, et à évaluer les lacunes concernant le financement du programme de recherche.

À l'issue de ce processus, les organismes donateurs pourront s'appuyer sur les informations pour lancer des appels à propositions de recherche au cours du premier trimestre 2024 afin que les bénéficiaires puissent commencer leurs travaux au cours de l'année 2024. Les résultats du premier lot de propositions de recherche ayant bénéficié d'un financement devraient être publiés et diffusés

d'ici à 2027, possiblement plus tôt, et l'OMS et les autres entités qui conçoivent des lignes directrices mettront à jour leurs orientations en matière d'HPP afin de tenir compte de ces nouvelles données probantes. Les avancées obtenues dans le secteur de la recherche et du développement dans le contexte de ces priorités de recherche feront l'objet d'un suivi, et un examen des lacunes persistantes ou nouvelles en matière de recherche sera effectué d'ici à 2030. Ce domaine stratégique est étroitement lié à celui qui consiste à combler les lacunes en matière de normes et de règles relatives à l'HPP, car les résultats des travaux de recherche prioritaires seront intégrés dans les lignes directrices et les politiques mondiales et nationales afin d'adapter régulièrement les pratiques en usage.

Domaine stratégique des normes et des règles

Pour combler les lacunes et le manque de concordance pouvant exister dans les orientations émises par les organismes internationaux à l'intention des utilisateurs finaux, il est important de renforcer la collaboration entre les principales entités qui conçoivent des lignes directrices sur l'HPP, en particulier celles qui travaillent à l'échelon international : l'OMS, la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) et la Confédération internationale des sages-femmes (ICM). Pour ce faire, l'OMS mettra en place un groupe directeur chargé d'explorer les mécanismes internes de ces organisations afin de déterminer la faisabilité d'une publication conjointe de lignes directrices unifiées sur l'HPP ; ces lignes directrices devront également prendre en compte les sujets et les données négligés dans le passé, se placer du point de vue des femmes et intégrer les réalités propres aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Ce groupe directeur examinera et validera le champ d'application des lignes directrices, et proposera des noms pour constituer un groupe d'élaboration des lignes directrices avant le dernier trimestre 2023. En 2024, les organisations participantes devront mettre en commun les ressources dont elles disposent pour faire réaliser des synthèses de données probantes et préparer les profils de ces données, avec l'objectif ambitieux de publier des lignes directrices unifiées sur l'HPP au début de l'année 2025.

En attendant la publication de ces lignes directrices unifiées, l'OMS et ses partenaires continueront à tenir compte des nouvelles données probantes susceptibles d'avoir un impact sur l'HPP afin de publier des recommandations spécifiques en suivant leurs procédures internes actuelles (par exemple, l'approche des « lignes directrices évolutives » de l'OMS). Une fois publiées, ces lignes directrices unifiées et leurs produits dérivés seront traduits et diffusés largement, puis suivront l'approche des lignes directrices évolutives qui permettra d'intégrer les données issues des travaux de recherche prioritaires décrits plus haut. Pour éviter tout retard dans la mise en pratique des connaissances existantes, en particulier dans les pays où ce phénomène représente un obstacle majeur aux progrès, l'OMS et les principales parties prenantes [par exemple, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Concept Foundation et MSD for Mothers] examineront les contextes dans lesquels s'inscrivent les politiques en matière d'HPP dans les pays où la charge de cette pathologie et la mortalité maternelle connexe sont élevées, et elles fourniront le soutien technique et financier nécessaire à la mise à jour des politiques en matière d'HPP et à leur adaptation au contexte local. En outre, un objectif ambitieux a été fixé pour que des politiques actualisées en matière d'HPP soient mises en place dans au moins 20 pays à forte charge de morbidité d'ici le dernier trimestre de l'année 2024. Cette initiative servira ensuite de modèle pour la mobilisation des différentes parties prenantes, et pourra être étendue, selon les besoins, à d'autres pays à revenu faible ou intermédiaire entre 2025 et 2030.

Domaine stratégique de la mise en œuvre

Il a été largement reconnu que la mise en œuvre d'interventions et de stratégies éprouvées constitue le principal défi à relever pour améliorer les résultats obtenus dans la lutte contre l'HPP. Pourtant,

il a été aussi admis que, sur les quatre domaines stratégiques identifiés, l'élimination des obstacles à cette mise en œuvre pourrait être celui qui a le plus de chances d'avoir un impact important. Le fait que nombre de ces obstacles soient fortement liés au contexte signifie qu'ils ne pourront pas toujours être levés facilement par des campagnes menées au niveau mondial, mais qu'ils nécessiteront souvent la mise en place de solutions adaptées à la situation locale. Bien conscientes que les obstacles à la mise en œuvre sont nombreux, les différentes parties prenantes au sommet sur l'HPP ont accordé une priorité à cinq d'entre eux, et ont procédé de même pour les obstacles nécessitant de mener de manière urgente des actions à l'échelon mondial. Elles ont également défini les actions prioritaires que la communauté mondiale peut mener pour lever chaque catégorie d'obstacles à la mise en œuvre. Les cinq catégories d'obstacles identifiées sont les suivantes :

- ▶ Le manque de politique nationale claire et de leadership (notamment l'absence d'objectifs nationaux, de collecte systématique de données pour mesurer les avancées obtenues, et de mécanismes permettant de convertir les lignes directrices mondiales en recommandations applicables au niveau national) ;
- ▶ Les défaillances des systèmes d'achat et des chaînes d'approvisionnement (les produits utilisés pour la lutte contre l'HPP et son traitement sont fréquemment en rupture de stock et de qualité insuffisante) ;
- ▶ Le manque de personnel, et son manque de formation et de supervision (le personnel de santé n'est pas suffisamment bien formé, responsabilisé et motivé, et les structures accordant les autorisations ainsi que les structures de réglementation sont souvent obsolètes, ce qui rend difficile le partage des tâches pour les interventions en rapport avec la lutte contre l'HPP) ;
- ▶ Les inégalités et les difficultés rencontrées pour accéder à une prise en charge de qualité (disparités persistantes, manque d'accès pour les populations défavorisées) ; et
- ▶ Les droits et le statut social limités des femmes (normes juridiques, sociales et culturelles peu favorables et obstacles qui limitent les choix de vie des femmes et les options qu'elles peuvent avoir concernant leurs grossesses et leurs accouchements).

Les actions prioritaires à mener pour renforcer les politiques et le leadership au niveau national concernant l'HPP sont les suivantes : la création d'un cadre mondial pour la lutte contre l'HPP permettant de structurer des programmes complets de prévention et de prise en charge de l'HPP ; l'élaboration et le déploiement d'un système mondial de surveillance efficace et pérenne comprenant des indicateurs communs, une collecte systématique de données et une plateforme de mesure commune permettant de faire le suivi des avancées obtenues par les pays vis-à-vis de cibles définies ; et l'adaptation des lignes directrices nationales aux différentes situations rencontrées sur le terrain et leur diffusion à tous les niveaux du système de santé, depuis les niveaux nationaux et infranationaux jusqu'aux établissements de santé communautaires. Pour améliorer les systèmes d'achat et la chaîne d'approvisionnement, les actions proposées comprennent la collaboration au sein de la communauté internationale afin d'assurer une coordination étroite entre les partenaires, l'augmentation des investissements et le développement des initiatives d'achat existantes ou nouvelles, ainsi que l'identification de solutions possibles pour rendre plus efficaces les achats et les chaînes d'approvisionnement dans le but de lancer une initiative en 2026 (les mesures prises doivent concerner les dispositifs médicaux, les médicaments ainsi que les produits sanguins). Pour répondre aux problématiques concernant les ressources humaines, les actions clés comprennent le renforcement des programmes de formation initiale et de formation en cours d'emploi et le développement professionnel en rapport avec la prise en charge de l'HPP, ainsi que la mise en œuvre de stratégies plus larges en matière de ressources humaines afin de remédier aux pénuries chroniques de personnel de santé qualifié (sages-femmes, personnel infirmier, médecins).

Pour lutter contre les inégalités et remédier aux difficultés d'accès, il est important d'améliorer les infrastructures destinées à la prestation de services afin de renforcer les capacités des établissements, d'améliorer les systèmes de transport et d'orientation des patientes, et de soutenir l'élaboration de plans de financement gouvernementaux visant à supprimer les frais d'utilisation et à élargir la couverture de l'assurance maladie afin de réduire les frais à la charge des patientes concernant les principaux produits liés à la prise en charge de l'HPP (par exemple en élargissant la couverture du système de santé aux médicaments et aux dispositifs médicaux utilisés pour cette prise en charge). S'il a été reconnu que les stratégies visant à améliorer les droits et le statut social des femmes auront un impact majeur sur leur santé en général, et ce bien au-delà de l'HPP, il a également été constaté qu'il était peu probable que ces avancées soient obtenues à court ou moyen terme. Néanmoins, les actions prioritaires qui peuvent être menées à court terme comprennent un plaidoyer soutenu de la part de l'ensemble des parties prenantes pour que les femmes et leurs droits figurent au centre de l'agenda politique à tous les niveaux, la sensibilisation de la population générale à l'HPP pour aider à éliminer les retards dans le recours aux soins (par exemple par le biais de brochures d'information destinées aux patientes), et le fait de veiller à la continuité des financements en faveur de la santé maternelle.

Domaine stratégique du plaidoyer

À l'heure actuelle, il n'existe aucune force fédératrice qui permettrait de faire progresser le programme de prévention et de prise en charge de l'HPP et de mobiliser les fonds nécessaires. Il convient donc de renforcer fortement le plaidoyer à différents niveaux pour que la lutte contre l'HPP figure en bonne place dans les programmes politiques au niveau mondial. Cinq grands domaines ont été retenus comme cibles prioritaires pour les actions en faveur de cette cause : (i) les responsables de l'élaboration des politiques et les politiciens doivent favoriser l'élimination des obstacles juridiques et réglementaires qui limitent l'accès à des soins d'importance vitale ; (ii) les ministères de la santé et les agences nationales de santé concernées doivent mettre à jour les lignes directrices nationales ; (iii) le rôle des sages-femmes doit être valorisé, et une formation et un soutien adéquats doivent être assurés ; (iv) l'importance de la disponibilité, de l'accessibilité financière et de la qualité des produits et des technologies en rapport avec l'HPP doit être renforcée jusqu'au niveau du ministère ; et (v) des actions de sensibilisation doivent être menées à l'intention de la population générale. D'ici au quatrième trimestre de l'année 2024, une stratégie mondiale d'image de marque et un cadre mondial pour les activités de plaidoyer en faveur de la réduction de la mortalité maternelle liée à l'HPP doivent être élaborés afin de fédérer les campagnes de plaidoyer et d'uniformiser les messages. Cette stratégie et ce cadre comprendront un puissant mécanisme de responsabilisation, des messages fondés sur des données probantes et des documents qui pourront être adaptés en fonction des besoins. Au cours des années 2024 et 2025, les différentes parties prenantes élaboreront également des cadres pour les activités de plaidoyer au niveau régional et national, ainsi que les supports correspondants. Enfin, une Journée mondiale de lutte contre l'HPP sera instaurée et une date appropriée sera identifiée afin d'organiser la première de ces journées en 2025 ; cette première journée servira également de point de départ à la mise en œuvre de la stratégie d'image de marque pour la lutte contre l'HPP. Pour être en mesure de mener à bien cet ambitieux programme de plaidoyer, l'ensemble des parties prenantes concernées devra se mobiliser et travailler en synergie. Un engagement au niveau ministériel sera indispensable pour que l'HPP soit considérée comme une priorité et que les ressources nécessaires soient allouées aux programmes concernés. Les femmes doivent avoir une place centrale. Les activités de lutte contre l'HPP ne doivent pas être mises en œuvre de manière isolée, mais au contraire servir de point d'entrée à un programme plus large en faveur de la santé maternelle afin de réduire la charge que représentent la mortalité et la morbidité maternelles.

Un appel mondial à l'action

Afin de donner davantage d'ampleur aux actions prioritaires présentées succinctement ci-dessus et détaillées dans le reste de ce document, un appel mondial à l'action issu d'un consensus a été rédigé. Il expose de manière claire et convaincante les attentes concrètes d'un large éventail de parties prenantes et souligne l'urgence d'agir pour mettre en œuvre la Feuille de route. Il a pour but d'exposer au public les éléments justifiant la nécessité d'un changement, de montrer que ce changement est possible et de présenter clairement ce qui, pour atteindre les objectifs fixés, est attendu de la part des différents groupes de parties prenantes, à savoir la communauté internationale dans son ensemble, les femmes et les groupes de femmes, les ministères de la santé, les responsables de la mise en œuvre (notamment les ONG et les OSC), les associations professionnelles, les entités qui conçoivent des lignes directrices, la communauté des chercheurs, l'industrie et les organismes travaillant sur des innovations ainsi que les organismes donateurs. Il présente enfin les principaux enseignements tirés du Sommet sur l'HPP et appelle à prendre immédiatement des mesures pour que les efforts déployés en vue d'éliminer les décès évitables dus à l'HPP soient efficaces et coordonnés, comme prévu dans la Feuille de route.

Mise en œuvre et suivi de la Feuille de route

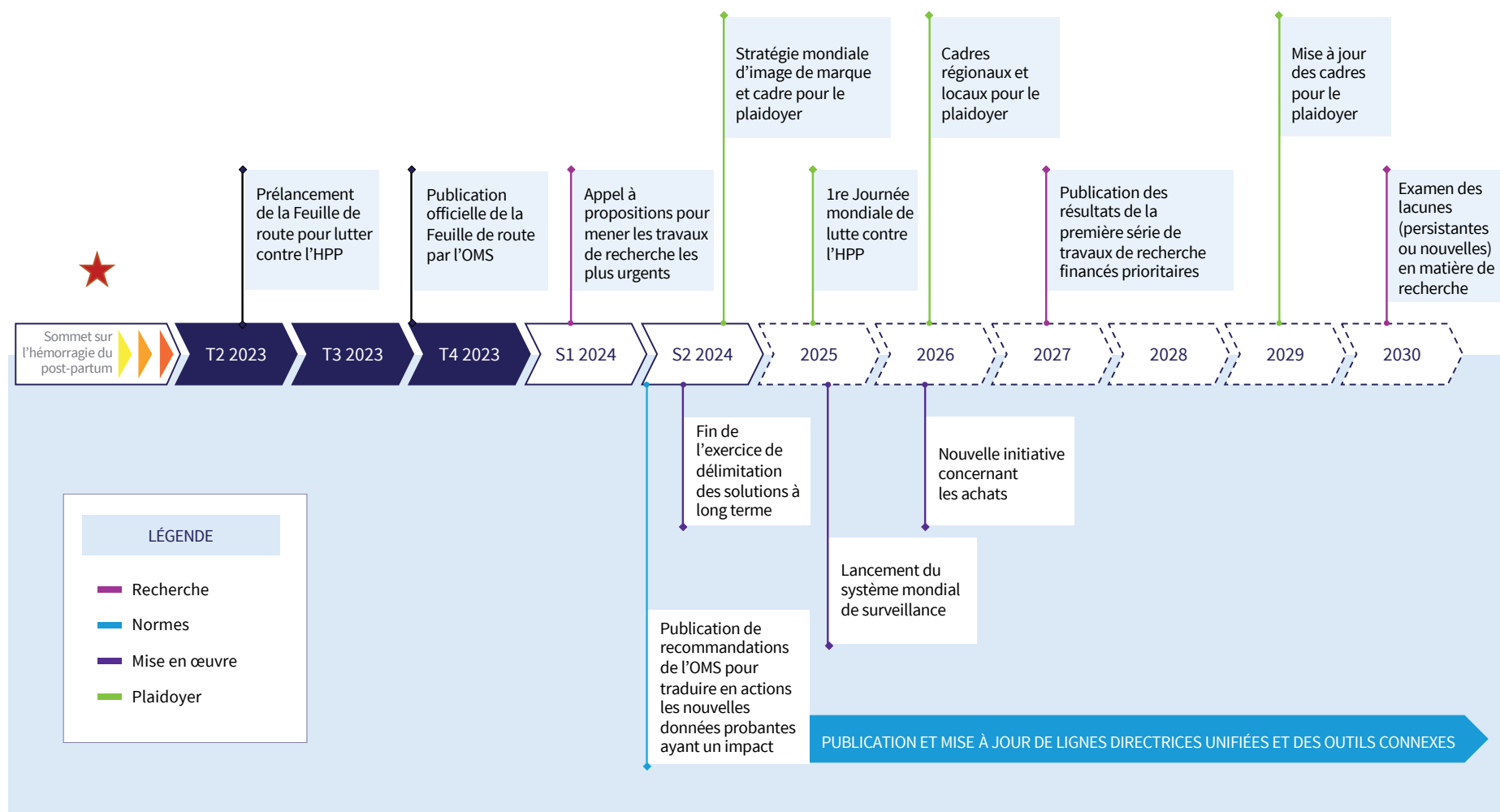
La réussite de la mise en œuvre de la Feuille de route nécessitera que les actions de l'ensemble des parties prenantes aux niveaux international, national et infranational soient menées de manière concertée et que l'engagement de la part des donateurs reste constant. L'OMS jouera un rôle de catalyseur pour les activités clés à court terme, notamment en contribuant à la mise en place d'une structure assurant le leadership et la gouvernance à l'échelle mondiale de cette Feuille de route. Elle travaillera également en étroite collaboration avec les ministères de la santé, les agences compétentes et les associations professionnelles au niveau national afin d'élaborer des documents normatifs adaptés aux contextes locaux pour amorcer la mise en œuvre. Les actions à plus long terme nécessiteront toutefois un engagement de la part d'autres groupes de parties prenantes.

Pour obtenir un premier retour, les principaux objectifs et les jalons fixés dans cette Feuille de route ont été présentés lors de la conférence internationale sur la santé de la mère et du nouveau-né qui s'est tenue du 8 au 11 mars 2023 au Cap (Afrique du Sud). Après sa publication, la Feuille de route (le présent document) et les outils connexes destinés à faciliter son adaptation locale seront **diffusés lors de conférences et de webinaires, notamment** par les bureaux régionaux et nationaux de l'OMS, les ministères de la santé, des organisations professionnelles, des centres collaborateurs de l'OMS, d'autres organismes des Nations Unies, des OSC et des ONG. La Feuille de route sera traduite dans les six langues des Nations Unies et des articles présentant chaque domaine stratégique ainsi que les principaux éléments à prendre en compte pour sa mise en œuvre seront préparés en vue d'être publiés dans des revues à comité de lecture. Ces activités de diffusion contribueront à faire connaître cette Feuille de route à tous les groupes de parties prenantes concernés.

Un suivi de la mise en œuvre de la Feuille de route et des avancées obtenues par rapport aux principaux jalons fixés sera assuré par le biais d'une plateforme mondiale de responsabilisation qui sera ouverte et accessible au public. Sa mise en place constituera l'une des premières activités prévues par la Feuille de route.

Si rien ne change, environ 500 000 femmes supplémentaires vont mourir des suites d'une HPP d'ici la fin de la période couverte par les ODD, et des millions d'autres souffriront des conséquences à long terme d'un accouchement traumatique. La Feuille de route propose une vision pour un avenir différent, dans lequel les femmes ne mourront plus des suites d'un problème de santé qu'il est possible de prévenir et de traiter. Ce futur peut devenir une réalité. Et cette Feuille de route nous montre comment y parvenir.

Figure 1. Principaux jalons de la Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie post-partum (HPP) entre 2023 et 2030



1. Introduction et justification

1.1 L'hémorragie du post-partum : un problème de santé publique mondial

L'hémorragie du post-partum (HPP), généralement définie comme une perte de 500 ml ou plus de sang dans les 24 heures suivant l'accouchement, est la principale cause de mortalité maternelle dans le monde. Chaque année, des millions de femmes sont victimes d'HPP, avec pour conséquence environ 70 000 décès maternels dans le monde, ce qui représente plus de 20 % de l'ensemble des décès maternels (1). Les femmes qui ont survécu à une HPP potentiellement mortelle auront souvent dû être opérées en urgence pour juguler cette hémorragie et peuvent en garder des séquelles à long terme, tant sur le plan physique (par exemple, une incapacité permanente à procréer, des lésions de la vessie, une infection du post-partum ou une anémie) que psychologique (par exemple, un état de stress post-traumatique différé). Le risque de souffrir d'une HPP ainsi que la morbidité et la mortalité liées à l'HPP affectent de manière disproportionnée les femmes des pays à revenu faible ou intermédiaire, particulièrement celles qui n'ont pas accès à des soins de qualité. Environ 80 % des décès dus à une HPP surviennent dans ces pays, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, alors même que ce type de décès a été pratiquement éliminé dans les pays à revenu élevé (2). Et les cas encore observés dans ces pays s'expliquent souvent par des disparités et des inégalités persistantes en ce qui concerne les soins de maternité (3, 4).

1.2 Pourquoi une Feuille de route est-elle nécessaire pour lutter contre l'HPP ?

Du train où vont les choses, et malgré l'objectif ambitieux de mettre fin aux décès maternels

évitables d'ici 2030, de nombreux pays ne seront pas en mesure d'atteindre leurs cibles en matière de mortalité maternelle, lesquels font partie de l'objectif 3 de développement durable (ODD 3). En 2020, le taux de mortalité maternelle au niveau mondial était estimé à 223 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ce chiffre reste très largement supérieur à la cible 3.1 de l'ODD 3 qui prévoit de ne pas dépasser 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici à 2030, et il est alarmant de constater que les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité maternelle ont stagné au cours des 5 à 10 dernières années (5). Compte tenu de la stagnation qui prévaut, il est clair que cette cible fixée concernant la mortalité maternelle pour l'année 2030 ne pourra être atteinte qu'en parvenant à repenser l'avenir et en prenant les mesures qui s'imposent au niveau mondial et au niveau des pays.

Seuls des progrès limités ont été réalisés dans le domaine de la prise en charge de l'HPP au cours de la dernière décennie. Il est donc impératif de mener des travaux de recherche pour mieux comprendre cette pathologie et mettre au point de nouvelles stratégies et de nouvelles interventions pour sa prévention, son diagnostic et son traitement. Si les différents partenaires du développement au niveau international ont généralement des objectifs similaires en ce qui concerne l'HPP, leurs activités manquent souvent de cohérence en raison d'une coordination insuffisante que ce soit au niveau mondial, au niveau national ou entre ces deux niveaux. Les chercheurs universitaires et les organismes travaillant sur des innovations dans l'industrie des produits pharmaceutiques et des dispositifs à usage médical ignorent souvent le type de recherche qu'il est nécessaire de mener et la manière de faire le lien entre les

données probantes et la prise de décision ou l'élaboration des politiques, ce qui conduit à la réalisation de travaux de recherche inutiles et/ou à des retards trop importants pour que les idées et les données probantes issues de la recherche se traduisent par un impact (une amélioration des résultats en matière de santé). Les profils de produits cibles (6) et les profils de politiques cibles (7) sont supposés fournir des orientations aux chercheurs, à ceux qui conçoivent des produits et aux responsables de l'élaboration des politiques. Pourtant, les profils de produits cibles sont rarement décrits en amont de la réalisation des travaux de recherche et du développement des interventions de lutte contre l'HPP, et le concept de profils de politiques cibles est relativement nouveau pour ceux qui sont chargés de prendre les décisions en matière de financement de la recherche. En résumé, il n'existe pas de vision commune sur ce que devraient être les futurs produits ou interventions les plus adaptés pour lutter contre l'HPP, ni sur les données probantes dont l'OMS et les autres entités qui conçoivent des lignes directrices au niveau mondial auraient besoin concernant les nouveaux produits pour élaborer de nouvelles recommandations mondiales ou mettre à jour les recommandations existantes.

Des documents normatifs (c'est-à-dire proposant des normes ou des critères) reconnus sont disponibles pour établir des normes de soins et fournir des orientations sur l'utilisation d'interventions fondées sur des données probantes. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) actualise régulièrement son ensemble de lignes directrices sur l'HPP (8-14) en utilisant une approche de « lignes directrices évolutives » depuis 2017. Elle apporte également un soutien à l'inclusion de nouveaux médicaments contre l'HPP dans la Liste des médicaments essentiels de l'OMS (15). Plusieurs autres organisations internationales et plusieurs pays ont également élaboré de manière indépendante leurs propres lignes directrices relatives à l'HPP. Les entités qui conçoivent des lignes directrices utilisent souvent des bases de données et des méthodologies différentes, ce qui entraîne des manques de concordance entre les lignes directrices et des différences dans les pratiques

cliniques recommandées. En conséquence, les utilisateurs finaux hésitent souvent sur les lignes directrices à adopter. Et l'adoption tardive ou incohérente de ces lignes directrices nuit à la capacité des agents de santé à dispenser des soins de qualité fondés sur des données probantes.

Les interventions susceptibles de réduire de manière significative la morbidité et les décès liés à l'HPP se sont avérées difficiles à intégrer et à généraliser dans les systèmes de santé des pays à revenu faible ou intermédiaire. Par exemple, alors que la forme thermostable de la carbétocine et l'acide tranexamique sont des médicaments prometteurs pour réduire la morbidité et la mortalité en cas d'HPP dans ces pays, leur utilisation au niveau national reste jusqu'à présent limitée. La mise en œuvre d'interventions efficaces est également rendue difficile du fait d'obstacles complexes allant au-delà de la simple adoption de lignes directrices. Des licences et des autorisations réglementaires dépassées empêchent parfois la mise en œuvre de recommandations fondées sur des données probantes (notamment en ce qui concerne le partage approprié des tâches entre les différentes catégories d'agents de santé en cas de pénurie de ressources humaines). Les agents de santé manquent souvent des ressources et des outils nécessaires, d'un soutien continu et d'un retour d'information pour mettre en œuvre les lignes directrices dans leur pratique. Les obstacles financiers continuent de limiter la fourniture de soins de maternité capables de sauver des vies ainsi que l'accès à ces soins. Il est rare que des mesures efficaces soient prises pour impliquer les communautés dans le processus, alors que cela contribuerait à les sensibiliser. Pour répondre de manière efficace à ces défis, il serait souvent nécessaire d'adopter des approches intersectorielles et multisectorielles.

Le plaidoyer joue un rôle crucial dans la sensibilisation à l'HPP et dans la création d'une dynamique d'action. La sensibilisation de la communauté aux dangers que représente l'HPP et à la nécessité d'intervenir rapidement peut galvaniser les actions locales visant à améliorer les infrastructures de transport, à abolir les

frais à la charge des patientes liés aux soins de maternité et à mettre en place des systèmes de banques du sang distribuant des produits sûrs. Le plaidoyer inclut également la mobilisation en faveur de politiques et de ressources destinées à soutenir la recherche, de l'adoption des lignes directrices et d'une mise en œuvre efficace des interventions recommandées. Cependant, les activités menées par les organisations de la société civile (OSC) et les organisations non gouvernementales (ONG) sont souvent dispersées en raison d'un manque de clarté sur les priorités en matière de lutte contre l'HPP.

Globalement, les activités de recherche, de définition de normes, de mise en œuvre et de plaidoyer constituent toutes des éléments indispensables pour atténuer la charge que représente l'HPP, mais il n'existait jusqu'à présent aucun programme dédié à chacun de ces domaines stratégiques. Conscient de la nécessité croissante de mener une action au niveau mondial pour améliorer la qualité de la prise en charge de l'HPP, le Programme spécial PNUD/FNUAP/UNICEF/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP) du Département Santé sexuelle et reproductive, et recherche de l'OMS a collaboré avec un grand nombre de parties prenantes au niveau international afin d'élaborer une Feuille de route pour lutter contre l'hémorragie du post-partum (appelée ci-après « Feuille de route ») dans laquelle sont décrits les objectifs à remplir, les activités à mener et les jalons à atteindre en ce qui concerne la recherche, la définition de normes, la mise en œuvre et le plaidoyer au niveau mondial entre 2023 et 2030 afin de répondre aux principales priorités en matière d'HPP et d'accélérer les progrès pour parvenir à la cible 3.1 des ODD.

Cette feuille de route définit un cadre stratégique innovant, axé sur les solutions et adapté aux besoins, et centré sur les objectifs et les priorités en matière de santé maternelle des pays où l'HPP représente une charge importante ; elle appelle aussi à investir dans différents domaines cruciaux des systèmes de santé, en mettant tout particulièrement l'accent sur les pays à revenu faible ou intermédiaire. Elle vise

à harmoniser les actions menées et à favoriser la coopération entre tous les partenaires travaillant dans le domaine de l'HPP afin de faire aboutir les programmes relatifs à l'HPP en fixant des objectifs dans les secteurs de la technique, des investissements et des politiques qui permettront de répondre aux priorités fondamentales des initiatives mondiales en cours en faveur de la santé des mères et des nouveau-nés.

1.3 Public cible

Cette Feuille de route est destinée aux principaux acteurs du secteur de la santé publique et à toutes les parties prenantes travaillant dans l'écosystème de l'HPP : la communauté internationale, les bailleurs de fonds, les chercheurs, les organismes travaillant sur des innovations et l'industrie, les associations professionnelles et les entités qui conçoivent des lignes directrices, les responsables de la mise en œuvre (notamment les OSC et les ONG), les ministères de la santé, mais aussi le grand public, et en particulier les femmes. Elle devrait constituer un outil précieux pour les gouvernements, les ministères concernés, les autorités sanitaires aux niveaux national, régional et local, ainsi que pour les directeurs des instituts de santé publique, les associations œuvrant dans le domaine de la santé publique et les autres organisations et agences concernées, qui pourront l'adapter à leurs besoins dans leurs contextes respectifs.

1.4 Objectif et champ d'application de la Feuille de route

Cette feuille de route vise trois objectifs principaux :

- i. Aligner toutes les parties prenantes sur le terrain vis-à-vis des principales priorités et actions requises pour atteindre des buts et objectifs communs.
- ii. Concentrer les efforts sur les activités clés afin d'éviter toute duplication d'actions.
- iii. Inciter les parties prenantes à faire avancer d'urgence les travaux relatifs à l'HPP dans les différents pays.

La Feuille de route constitue un plan de haut niveau comprenant des jalons à atteindre pour obtenir l'impact nécessaire. Il ne s'agit pas d'un plan de projet détaillé décrivant chaque étape à suivre, mais plutôt d'un ensemble d'éléments clés à mettre en œuvre. Ces éléments clés doivent permettre un alignement sur les objectifs à atteindre, sur l'échéancier à respecter avec ses principaux jalons et la chronologie des activités à mener, sur l'attribution des rôles et des responsabilités, et sur une description claire des moyens qui permettront de mesurer les résultats obtenus.

Cette Feuille de route met l'accent sur un ensemble commun de priorités définies lors du Sommet mondial sur l'hémorragie du post-partum (Sommet sur l'HPP) organisé par l'OMS en mars 2023 (de plus amples informations figurent au chapitre 2). Ces priorités s'articulent autour de quatre domaines stratégiques : la recherche, les normes et les critères, la mise en œuvre et le plaidoyer. La Feuille de route identifie les solutions et les mesures facilitatrices qui seront nécessaires pour résoudre les problèmes persistants et réduire de manière radicale la mortalité et la morbidité sévère dues à l'HPP. Elle se fonde sur les initiatives en cours aux niveaux mondial, régional et national visant à améliorer la qualité des soins et les résultats en matière de santé en s'attaquant aux principales causes de la mortalité et de la morbidité maternelles, mais elle ne doit pas remplacer ces initiatives. Elle est également conçue comme un mécanisme destiné à favoriser la collaboration et établir des coalitions en vue d'améliorer la santé maternelle, non seulement pour ce qui concerne l'HPP, mais aussi dans le cadre d'un programme plus large en faveur de la santé de la mère et du nouveau-né.

2. Élaboration de la Feuille de route

La présente Feuille de route a été élaborée selon une démarche systématique articulée autour du Sommet sur l'HPP.

L'OMS a organisé ce Sommet sur l'HPP du 7 au 10 mars 2023 à Dubaï (Émirats arabes unis) dans les objectifs suivants :

- i. Examiner la situation du secteur recherche-développement concernant les innovations relatives à l'HPP en cours de mise au point et définir les besoins en matière de données probantes en vue d'une modification des politiques ;
- ii. Identifier les lacunes à combler en priorité dans le domaine de la recherche en rapport avec la lutte contre l'HPP et parvenir à un consensus sur ce sujet ;
- iii. Identifier les lacunes à combler en priorité dans le domaine des normes et des critères en rapport avec la lutte contre l'HPP, et parvenir à un consensus sur ce sujet ;
- iv. Identifier les lacunes à combler en priorité dans le domaine de la mise en œuvre en rapport avec la lutte contre l'HPP, parvenir à un consensus sur ce sujet, et identifier des stratégies pour assurer un accès équitable et pérenne à des interventions efficaces ;
- v. Identifier les lacunes à combler en priorité dans le domaine du plaidoyer en rapport avec la lutte contre l'HPP, parvenir à un consensus sur ce sujet, et identifier des stratégies pérennes pour combler ces lacunes ;
- vi. Synthétiser les défis à relever et élaborer une Feuille de route claire pour y parvenir ; et
- vii. Former des alliances solides et dynamiser les voies de financement en vue de faire face aux défis que pose la lutte contre l'HPP.

En résumé, la feuille de route a été élaborée en suivant les étapes suivantes : (i) sélection des participants et des contributeurs ; (ii) identification systématique des lacunes en matière de recherche, de normes, de mise en œuvre et de plaidoyer afin de faciliter le travail d'établissement des priorités ; (iii) organisation et tenue du Sommet sur l'HPP afin d'obtenir un consensus sur les lacunes à combler en priorité et parvenir à un consensus sur un ensemble commun de solutions pour combler ces lacunes ; et (iv) transposition de ces lacunes et de ces solutions par ordre de priorité en une Feuille de route et en un appel à l'action. Les quatre étapes qui ont été suivies sont présentées en détail dans les quatre sections de ce chapitre.

2.1 Participants au Sommet sur l'hémorragie du post-partum et contributeurs à la Feuille de route

L'OMS a mis en place un comité d'orientation afin d'assurer la supervision et de fournir des orientations méthodologiques avant, pendant et après le Sommet sur l'HPP. En parallèle, et en amont du Sommet, un comité scientifique a été créé pour identifier les lacunes en matière de recherche, passer en revue les médicaments et les dispositifs novateurs en cours de mise au point pour le traitement de l'HPP, établir une cartographie des recommandations existantes en matière de lutte contre l'HPP figurant dans des lignes directrices reconnues, et préparer des exemples tirés de pays comptant parmi les plus touchés. L'élaboration de cette Feuille de route s'est appuyée sur un examen détaillé de la situation sur le terrain en ce qui concerne les quatre domaines stratégiques identifiés (recherche, normes et critères, mise en œuvre et plaidoyer), ainsi que sur un grand nombre de contributions et autres apports issus d'enquêtes

en ligne et de discussions en personne entre les participants au Sommet, y compris les membres de ces deux comités. Le personnel de l'OMS a assuré la coordination et veillé à ce que les méthodes utilisées soient conformes aux procédures internes de l'OMS.

L'ensemble des 138 participants au sommet étaient des parties prenantes dont les activités sont en rapport avec les quatre domaines stratégiques aux niveaux international et national. Ils étaient des représentants de gouvernements (ministères de la santé), de différents métiers de la santé, d'institutions de recherche et d'universités, d'associations professionnelles, d'organisations non gouvernementales nationales et internationales, d'organisations de la société civile, d'organismes donateurs, d'entités ayant contribué à des innovations dans les secteurs des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que du secteur privé. Les participants ont assisté au Sommet à titre individuel et non en tant que délégués d'organisations. Les membres du comité d'orientation et du comité scientifique ont été choisis parmi l'ensemble des participants, en veillant à respecter une représentation équilibrée des différentes régions ainsi que la parité entre les femmes et les hommes. La liste des différents contributeurs figure à l'annexe 1.

2.2 En amont du Sommet sur l'hémorragie du post-partum: identification des lacunes dans les différents domaines stratégiques

Plusieurs activités ont été entreprises par le comité d'orientation et le comité scientifique en amont du Sommet sur l'HPP afin d'identifier les lacunes à combler dans chacun des quatre domaines stratégiques.

Recherche et développement

Le processus suivi lors de la définition du programme de recherche a respecté l'approche systématique de l'OMS pour établir des priorités en matière de recherche (16). Pour identifier les lacunes existantes, une première liste détaillée de 417 questions de recherche,

avec des questions tirées des priorités de recherche qui se dégagent des lignes directrices de l'OMS et d'autres lignes directrices internationales, d'examen systématiques, de l'analyse des médicaments et des dispositifs médicaux destinés à lutter contre l'HPP en cours d'élaboration, et des questions restées sans réponse au cours d'exercices déjà menés pour établir des priorités de recherche dans le domaine de la santé sexuelle, reproductive et maternelle (17). Chaque participant au sommet a été invité à proposer des questions supplémentaires. La liste complète a ensuite fait l'objet d'une sélection ayant abouti à une liste synthétique de 72 questions de recherche (un organigramme décrivant le processus suivi se trouve à l'annexe 2). Ces 72 questions ont été réparties en trois catégories, à savoir l'innovation (26 questions), la mise en œuvre (24 questions) et les questions transversales (22 questions), en se basant sur des catégories reconnues qui ont été définies et utilisées dans la Child Health and Nutrition Research Initiative (CHNRI) (découverte, exécution, description, développement) (18) et qui ont été reformulées afin de les rendre plus claires. Un score a été attribué à chacune de ces questions qui ont ensuite été classées par ordre de priorité en suivant la méthodologie de la CHNRI (19). Dans un premier temps, les participants au sommet ont été invités à évaluer ces 72 questions de recherche en fonction de cinq critères : chances de donner lieu à une réponse, chances de déboucher sur une intervention, et possibilité que cette intervention soit mise en œuvre, ait un impact et soit équitable. Un score a été attribué à chaque question sur la base des évaluations faites par les participants via une enquête en ligne (sur les 126 personnes préinscrites, 120 participants au Sommet ont soumis leur évaluation). Les 10 questions les mieux classées dans chaque domaine (30 questions au total) ont ensuite été retenues pour être examinées de manière plus approfondie et classées par ordre de priorité au cours du Sommet.

Normes et critères

Dans un premier temps, l'OMS a fait réaliser un exercice de cartographie afin de déterminer le niveau de concordance des recommandations

relatives à l'HPP figurant dans différentes lignes directrices fondées sur des données probantes. Au terme d'une recherche systématique dans la littérature, neuf documents contenant des lignes directrices répondant à un certain nombre de critères préétablis et publiées après 2012 ont été retenues pour cette analyse (voir l'organigramme à l'annexe 3). Ces neuf documents contenant des lignes directrices retenus ont été élaborés par l'OMS, la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO), le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), l'American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG), la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), la Japan Society of Obstetrics and Gynecology (JSOG) et le Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG). Soixante-neuf recommandations concernant l'HPP ont été identifiées dans ces différents documents contenant des lignes directrices. Pour chaque recommandation, les neuf documents ont été examinés afin de déterminer si les lignes directrices (i) préconisaient l'intervention, (ii) déconseillaient l'intervention, (iii) estimaient que les données probantes n'étaient pas suffisantes pour formuler une recommandation ou (iv) ne formulaient pas de recommandation pour l'intervention en question.

Cet exercice de cartographie a permis d'identifier 11 recommandations concordantes (sur un total de 69) et quatre recommandations non concordantes dans les différentes lignes directrices. Les recommandations ont été considérées comme concordantes si au moins cinq des neuf documents contenant des lignes directrices formulaient des recommandations similaires sur l'intervention en question et comme non concordantes si au moins deux des documents contenant des lignes directrices formulaient des recommandations contradictoires. Plusieurs interventions ne font actuellement l'objet d'aucune recommandation dans la plupart des lignes directrices (ce qui correspond aux catégories iii et iv ci-dessus).

L'existence de ces disparités montre la nécessité de formuler un ensemble commun de recommandations mondiales afin de faciliter la mise en œuvre au niveau des pays.

La deuxième phase des travaux préparatoires avait deux objectifs : (i) examiner et mettre à jour la base de données probantes sur laquelle reposent les recommandations existantes de l'OMS en matière d'HPP et identifier les recommandations à mettre à jour en priorité suite à des modifications de la base de données probantes susceptibles d'avoir un impact sur les recommandations existantes ; et (ii) examiner les données probantes actualisées sur lesquelles reposent les recommandations d'autres entités qui conçoivent des lignes directrices afin de déterminer si l'OMS doit formuler de nouvelles recommandations.

Sur la base de ce travail, la mise à jour des recommandations suivantes a été jugée prioritaire :

- ▶ Administration de carbétocine [100 µg par voie intramusculaire (IM) ou intraveineuse (IV)] pour la prévention de l'HPP pour tous les accouchements dans les contextes où son coût est comparable à celui des autres utérotoniques efficaces ;
- ▶ Administration d'acide tranexamique (0,5 à 1,0 g IV), en plus de l'ocytocine, en cas de césarienne pour réduire la perte de sang chez les femmes présentant un risque élevé d'HPP ;
- ▶ Transfusion de 4 unités de globules rouges et de 12 à 15 ml/kg de plasma frais congelé en cas d'hémorragie persistante lorsque les résultats de tests sanguins ne sont pas disponibles ;
- ▶ Récupération cellulaire peropératoire (transfusion sanguine autologue) lorsqu'une perte de sang importante est à craindre, par exemple en cas de placenta prævia ou de placenta accreta ; et
- ▶ Administration de fer par voie IV pour l'anémie du post-partum.

Mise en œuvre

Une stratégie en plusieurs volets a été adoptée pour mieux cerner les obstacles pouvant entraver la mise en œuvre. Pour mieux comprendre les difficultés liées au contexte expliquant la lenteur avec laquelle sont prises en compte les connaissances existantes et sont mises en application les recommandations fondées sur des données probantes en matière d'HPP et identifier quels sont les blocages qui peuvent exister au niveau des pays, l'OMS a fait appel à trois exemples de pays représentant des contextes différents : le Nigéria, le Pakistan et la République-Unie de Tanzanie. Ces pays ont été choisis dans les deux régions les plus lourdement touchées par l'HPP (l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud), en tenant compte du nombre absolu de décès maternels enregistrés chaque année, des dernières estimations du taux de mortalité maternelle et de la lenteur des progrès réalisés dans la réduction de ce taux au cours de la dernière décennie (5). Ces exemples de pays ont permis d'obtenir les informations nécessaires pour mieux appréhender les difficultés de mise en œuvre sur le terrain et de tirer des enseignements utiles des situations où ces difficultés ont pu être surmontées, que ce soit en ce qui concerne la mise en œuvre d'interventions anciennes ou d'interventions nouvellement introduites relatives à l'HPP dans différents contextes.

Une analyse concernant sept pays ayant réalisé des progrès notables en matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale [Bangladesh, Éthiopie, Inde, Maroc, Népal, Niger et Sénégal (5)] a également été effectuée afin d'en tirer des enseignements et d'identifier les meilleures pratiques permettant d'éliminer les blocages à la mise en œuvre. Les contributions des évolutions positives dans les politiques et programmes du système de santé, les financements, les ressources humaines, la couverture des interventions, la qualité des soins et les facteurs contextuels ont été examinées en détail afin de déterminer comment elles ont permis de faire reculer les taux de mortalité maternelle et néonatale observés. Parmi les principaux facteurs identifiés comme contribuant à la réduction des taux de mortalité

maternelle et néonatale figurent l'augmentation du nombre d'accouchements au sein d'un même établissement de santé, l'amélioration de l'accès à un personnel de santé qualifié pour prodiguer des soins pendant l'accouchement et l'augmentation de la disponibilité des utérotoniques.

En parallèle, un cadre de conditions préalables essentielles à remplir pour une mise en œuvre réussie des recommandations existantes en matière d'HPP a été élaboré. En se basant sur ce cadre, une enquête en ligne sur les obstacles à la mise en œuvre d'interventions fondées sur des données probantes a été menée afin de mieux comprendre dans quelle mesure les conditions préalables essentielles à une mise en œuvre réussie avaient été remplies pour les interventions recommandées. En amont du Sommet sur l'HPP, il a été demandé aux participants d'évaluer la mise en œuvre de 20 interventions cliniques recommandées par l'OMS en répondant à un ensemble de six questions pour chaque intervention, et à quatre questions supplémentaires si l'intervention comprenait l'utilisation d'un médicament ou d'un dispositif (voir l'annexe 4, où la liste complète des interventions est présentée dans les lignes du tableau et où les questions et les obstacles correspondants sont présentés dans les colonnes). Au total, 102 participants sur les 126 personnes préinscrites au Sommet ont envoyé des réponses. Un score a été attribué à chaque intervention recommandée en fonction des réponses des personnes interrogées. Ces scores (pour chaque question et chaque intervention) ont ensuite été additionnés pour l'ensemble des personnes interrogées et divisés par le nombre total de réponses afin d'obtenir un pourcentage, lequel a ensuite été utilisé pour créer une carte thermique (voir l'annexe 4) permettant de visualiser les lacunes à combler en priorité. Au cours du Sommet sur l'HPP, ces cartes ont été présentées aux participants, de même que des données recueillies auprès d'établissements de santé au Nigéria, au Pakistan et en République-Unie de Tanzanie. Ont aussi été données des indications sur la disponibilité et l'utilisation faite de chaque intervention recommandée dans chacun des contextes.

Plaidoyer

Pour parvenir à une vision commune sur les lacunes en matière de plaidoyer en faveur de la lutte contre l'HPP et établir des priorités, une vue d'ensemble de la situation mondiale actuelle sur le sujet a été dressée afin d'identifier les principales organisations et initiatives actives dans le domaine et mettre en évidence les faiblesses et les principales lacunes existant dans l'écosystème actuel. Parallèlement, une vue d'ensemble similaire de la situation prévalant au niveau mondial dans d'autres écosystèmes du secteur de la santé (par exemple, la planification familiale et la lutte contre le VIH et le sida) a été réalisée afin d'identifier les initiatives de plaidoyer réussies qui méritent d'être reproduites dans le domaine de la lutte contre l'HPP.

2.3 Au Sommet sur l'hémorragie du post-partum : obtention d'un consensus sur les lacunes à combler en priorité et les solutions à apporter

Les résultats des activités susmentionnées visant à identifier les lacunes à combler ont servi de base aux discussions entre les différentes parties prenantes participant au Sommet sur l'HPP. Ils ont été présentés lors des séances plénières et des réunions en groupes restreints afin d'aider les différentes parties prenantes à prendre des décisions éclairées sur les lacunes à résoudre en premières priorités ainsi que sur les ensembles de solutions correspondants, et de permettre l'élaboration d'un programme clair d'activités à mener collectivement et présenté sous la forme d'une feuille de route. Les discussions qui se sont tenues lors du Sommet ont été organisées autour de la chaîne de valeur régissant l'introduction de produits, en commençant par la recherche et le développement et en poursuivant avec les normes et les critères, la mise en œuvre et le plaidoyer.

Recherche et développement

La priorité à accorder aux 10 questions de recherche figurant en tête de liste dans chaque domaine (innovation, mise en œuvre, questions

transversales) a été redéfinie pour parvenir à une liste réduite de cinq questions prioritaires par domaine. Pour chaque domaine, chacune des 10 questions de recherche a été examinée sur la base d'une note explicative présentant sa justification et sa problématique, après quoi chaque participant a pu désigner et classer par ordre de 1 à 5 les cinq questions à qui, selon lui, il convient d'accorder la plus grande priorité. Une fois cette première sélection et ce premier classement réalisés par les participants, les résultats obtenus ont fait l'objet d'une discussion et des modifications ont été apportées dans certains cas afin de parvenir à un consensus sur la liste des cinq questions de recherche les plus urgentes pour chaque domaine et sur leur classement (un deuxième vote ou une deuxième sélection a été effectué après avoir clarifié certains points obscurs concernant leur formulation). L'ensemble des 15 questions retenues est présenté dans le Tableau 3.1 de la section 3.1 du chapitre suivant.

Normes et critères

Un panel de représentants d'associations professionnelles a débattu de l'alignement des priorités concernant les recommandations sur l'HPP. Une séance plénière comprenant un échange sous forme de questions-réponses a également permis aux participants de soulever d'autres points à envisager comme questions prioritaires ou comme sujet pour la rédaction de nouvelles recommandations ou la mise à jour de lignes directrices à réaliser par l'OMS et d'autres organismes internationaux (de plus amples informations sont présentées à la section 3.2 du chapitre suivant).

Mise en œuvre

Un panel de représentants des ministères de la santé a débattu des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des interventions d'importance vitale dans leurs pays respectifs. Les problèmes évoqués comprenaient la mauvaise gestion des approvisionnements (en particulier en ce qui concerne les utérotoniques), les déficiences des systèmes d'orientation des patientes et les problèmes de maintien en place et de formation des agents de santé. Ces

Tableau 2.1 Catégories d'obstacles à la mise en œuvre

Thème en rapport avec la mise en œuvre	Catégorie d'obstacles à la mise en œuvre
 Contexte national	▶ Droits et statut social des femmes (p. ex., niveau d'éducation insuffisant, statut social peu élevé, restrictions des choix en matière de grossesse et d'accouchement) ▶ Mesures législatives et mesures non liées à la santé (p. ex., absence de lois protégeant les femmes contre la violence fondée sur le genre et les mariages précoces, absence de pouvoir politique pour les femmes). ▶ Urgences sanitaires (p. ex., catastrophes naturelles, conflits armés, épidémies de maladies infectieuses) ▶ Politique de santé et leadership au niveau national (p. ex., gouvernance dans le secteur de la santé, compétences en leadership, politiques de santé, plaidoyer en faveur des politiques)
 Programme et investissements	▶ Lignes directrices techniques sur l'hémorragie du post-partum (HPP) (p. ex., lignes directrices obsolètes, insuffisamment étayées par des données locales, non adaptées à la mise en œuvre à l'échelon infranational). ▶ Mise à l'échelle des programmes pilotes (p. ex., absence de stratégie pour le transfert de l'autorité ou pour passer la main, verticalité des programmes) ▶ Équité et accès aux soins (p. ex., disparités persistantes, données limitées, accessibilité insuffisante des groupes vulnérables ou marginalisés, manque de collaboration avec le secteur privé) ▶ Investissements (p. ex., stagnation des dépenses publiques, manque de pérennité des programmes financés par des fonds extérieurs)
 Produits et dispositifs médicaux	▶ Réglementation (p. ex., défaut de surveillance après la mise sur le marché, manque d'harmonisation des voies de réglementation, voies de réglementation complexes ou inexistantes concernant les dispositifs médicaux) ▶ Achats et chaîne d'approvisionnement (p. ex., manque de disponibilité en sang ou en produits sanguins, systèmes de collecte peu performants dans les établissements du niveau secondaire, mauvaise communication entre la direction de l'hôpital et les agents de santé se traduisant par des ruptures de stock) ▶ Qualité (produits de qualité insuffisante, difficulté à maintenir la chaîne du froid, fabricants peu enclins à obtenir une préqualification de l'OMS ou une autorisation d'une autorité de réglementation rigoureuse) ▶ Accessibilité financière et dépenses de santé à la charge des patients (p. ex., absence de gratuité des soins de maternité, prestataires des services de santé appartenant uniquement au secteur privé pratiquant des tarifs inaccessibles, absence de fourniture de certains produits par le gouvernement).
 Prestation de services	▶ Guides pratiques pour la mise en œuvre des lignes directrices (p. ex., manque de compétences pour convertir des lignes directrices en protocoles cliniques et en guides pratiques ; protocoles cliniques non disponibles, non accessibles, non utilisables ou inadaptés) ▶ Cheminement entre les différents niveaux de soins et la communauté lors de l'orientation des patientes (p. ex., manque de clarté quant au moment et à l'endroit où les femmes doivent se rendre/où les prestataires doivent orienter les femmes pour un accouchement ou des soins d'urgence, problèmes de transport, patientes ne suivant pas toujours le cheminement prévu pour leur orientation vers d'autres services) ▶ Dotation en personnel, formation et supervision des agents de santé (p. ex., acquisition et maintien des compétences, rôle/statut des sages-femmes et du personnel infirmier, ressources humaines dans le domaine de la santé dans les régions reculées) ▶ Audit et retour d'information (p. ex., prestataires de services de santé du secteur privé non soumis à une réglementation ou non tenus de rendre des comptes, capacité locale limitée à utiliser les données pour la prise de décision)

discussions ont permis de définir quels obstacles à la mise en œuvre étaient à lever en priorité.

Après des discussions à partir d'une longue liste d'obstacles à la mise en œuvre répartis en quatre grands thèmes [contexte national, programme et investissements, produits et dispositifs médicaux, et prestation de services (Tableau 2.1)], les participants sont parvenus à un consensus sur cinq catégories d'obstacles à la mise en œuvre pouvant bénéficier de solutions et d'actions au niveau mondial, puis ont défini des mesures concrètes à adopter dans le futur. Celles-ci sont présentées dans le Tableau 3.2 de la section 3.3 du chapitre suivant.

Plaidoyer

Des ONG et des OSC ont été invitées à participer à une table ronde pour faire part de leur expérience sur le terrain. Leurs représentants ont présenté des exemples d'initiatives réussies mises en œuvre au niveau local ainsi que les enseignements tirés de leur expérience. Certaines contributions apportées par les participants au Sommet sur l'HPP ont été inspirées par les principaux enseignements présentés par les participants à cette table ronde et ont permis de dégager un consensus sur les futures actions à mener en priorité (de plus amples informations sont présentées dans la section 3.4 du chapitre suivant).

2.4 Résultats du Sommet sur l'hémorragie du post-partum : intégration des solutions à mettre en œuvre en priorité dans une Feuille de route et un appel à l'action

Au cours du Sommet sur l'HPP, le concept de la feuille de route, les éléments essentiels qui permettent sa mise en œuvre et les raisons pour lesquelles son établissement est nécessaire dans le cas de l'HPP ont été expliqués aux participants. Il leur a ensuite été demandé, sur base des travaux menés au cours des sessions précédentes, de concevoir des programmes de haut niveau pour chacun des quatre domaines stratégiques (recherche, normes et critères, mise en œuvre et plaidoyer) en réfléchissant

aux étapes à suivre ainsi qu'à la séquence avec laquelle elles devaient être agencées, et en précisant la répartition des rôles et des responsabilités.

Immédiatement après le Sommet, un travail supplémentaire a été réalisé afin d'affiner la **Feuille de route** pour chacun des quatre domaines stratégiques en exploitant les contributions des participants, les commentaires du comité d'orientation et du comité scientifique ainsi que les résultats d'entretiens ciblés, de réunions avec les donateurs et de recherches bibliographiques complémentaires. La Feuille de route qui en a résulté est le fruit de la synthèse des données, des contributions des différentes parties prenantes et de la consolidation des solutions et des plans d'action proposés à l'issue du Sommet. Ce travail est présenté au chapitre suivant de ce document.

L'autre résultat clé attendu du Sommet obtenu en complément de la Feuille de route a été la formulation consensuelle d'un **appel à l'action**. Cet appel a pour but d'exposer au public les éléments justifiant la nécessité d'un changement, de montrer que ce changement est possible et de présenter clairement ce qui est attendu de la part des différents groupes de parties prenantes. Les ingrédients ayant servi à la rédaction de cet appel ont été recueillis par voie électronique auprès de l'ensemble des participants au Sommet après une présentation-débat sur les arguments en faveur d'un changement, les éléments démontrant que celui-ci est possible, les propositions de demandes à adresser aux différents groupes de parties prenantes et les arguments indiquant que le moment est venu de passer à l'action. Le document contenant cet appel à l'action a été élaboré sur la base des nombreuses contributions des participants au Sommet et a ensuite été affiné grâce aux commentaires fournis par le comité d'orientation et le comité scientifique. Tous les participants au sommet ont accepté de signer la version finale de cet appel à l'action présentée au chapitre 4.

2.5 Déclaration d'intérêts des contributeurs externes

Conformément à la réglementation de l'OMS, il a été demandé à tous les contributeurs externes, en amont de leur participation aux processus et aux réunions qui ont conduit à l'élaboration de la Feuille de route, de déclarer par écrit leurs éventuels conflits d'intérêts. Tous ont rempli et signé un formulaire standard de déclaration d'intérêt de l'OMS et l'ont envoyé à l'administrateur technique responsable de l'OMS. Il a aussi été demandé à ces contributeurs de signaler à l'administrateur tout changement d'intérêt pertinent survenant au cours de leur mission afin que la situation puisse être examinée et les conflits d'intérêts réévalués en conséquence. L'équipe de coordination de l'OMS a examiné toutes ces déclarations afin de déterminer si les conflits d'intérêts déclarés étaient suffisamment graves pour faire peser un risque sur le processus d'élaboration de la Feuille de route ou s'ils pouvaient en entamer la crédibilité. Toutes les déclarations de conflits d'intérêts reçues ont été gérées au cas par cas conformément aux orientations de l'OMS. Des conflits d'intérêts en rapport avec des travaux de recherche universitaire, des activités normatives, des travaux de mise en œuvre, des activités de plaidoyer ou une participation à des activités dans le secteur privé dans le domaine de l'HPP ont été relevés, mais aucun n'a été considéré comme suffisamment grave pour empêcher une contribution à l'élaboration de la Feuille de route. Au cours des réunions, il a été demandé à tous les contributeurs externes de déclarer publiquement tout conflit d'intérêts à l'ensemble des participants. Un récapitulatif de ces déclarations de conflits d'intérêts est fourni à l'annexe 1.

3. La Feuille de route

Cette Feuille de route définit un ensemble d'actions prioritaires clés et un calendrier de mise en œuvre afin de remédier à la charge que représente l'HPP et réduire la mortalité et la morbidité connexes, conformément à ce qui a été convenu par les différentes parties prenantes lors du Sommet sur l'HPP de 2023. Elle a été élaborée et structurée sur la base de quatre domaines stratégiques interdépendants (la recherche, les normes et les critères, la mise en œuvre et le plaidoyer) jouant un rôle crucial pour catalyser les activités et atteindre rapidement les objectifs des pays en matière de prévention des décès maternels. Pour chaque domaine stratégique, la Feuille de route présente les actions spécifiques à mener et les résultats attendus pour la période allant de 2023 à 2030 ; elle constitue ainsi un document de référence essentiel pour les sept années à venir. Elle recense les priorités communes et les actions synergiques possibles aux niveaux national et régional qui auront un impact positif sur le taux de mortalité maternelle au niveau mondial, lequel a stagné au cours des 5 à 10 dernières années. Elle définit des activités indispensables axées sur les résultats qui devront être mises en œuvre par un large éventail d'acteurs, notamment les ministères de la santé, les responsables de la mise en œuvre, les instituts de recherche et les universités, les organisations professionnelles, les femmes et les groupes de femmes, les gouvernements et les acteurs non gouvernementaux.

Les actions prioritaires à mener dans chacun des quatre domaines stratégiques sont détaillées dans les sections 3.1 à 3.4 de ce chapitre. Et les interdépendances et les liens entre les quatre domaines stratégiques sont décrits à la section 3.5.

3.1 Domaine stratégique concernant la recherche

La recherche joue un rôle fondamental pour obtenir des avancées en vue de résoudre les problèmes de santé, et ce quel que soit le problème considéré. Toute situation stationnaire dans la recherche, y compris dans la recherche sur la mise en œuvre, risque de nuire aux initiatives visant à réduire les risques liés à l'HPP ainsi que la mortalité et la morbidité maternelles qui en découlent. Un alignement des différentes parties prenantes sur les lacunes à combler en priorité en matière de recherche concernant l'HPP doit permettre de mieux cibler les investissements et de réduire le gaspillage ainsi que les redondances en matière de financement et d'activités de recherche, et ainsi d'apporter des réponses plus rapides et plus efficaces aux besoins en matière de santé publique.

Quinze questions de recherche relevant des trois domaines que sont l'innovation, la mise en œuvre et les questions transversales ont été jugées par les parties prenantes au cours du sommet comme particulièrement importantes pour faire progresser les connaissances pouvant déboucher sur des mesures concrètes concernant la lutte contre l'HPP d'ici à 2030 (et au-delà de 2030 en ce qui concerne le domaine de l'innovation, ce type de recherche prenant souvent plus de temps). Pour répondre à ces 15 questions de recherche prioritaires, dont la liste est présentée dans le Tableau 3.1, il est indispensable de mettre en place un programme de recherche conjoint entièrement financé. Cela ne signifie pas que les questions de recherche qui n'ont pas été retenues parmi les 15 questions prioritaires ne doivent pas faire l'objet de travaux de recherche, mais que les 15 questions prioritaires demandent des réponses urgentes pour permettre des avancées sur le terrain.

Plusieurs éléments importants doivent être pris en compte à mesure que des travaux de recherche seront menés sur les questions les plus urgentes. Premièrement, la priorité à court terme doit être de se concentrer sur les moments dans le continuum de soins où sont observés la majorité des cas de mortalité liés à l'HPP, en mettant un accent particulier sur les mesures de temporisation et sur le renforcement des systèmes d'orientation des patientes. Deuxièmement, il convient d'évaluer la faisabilité et l'utilité de la mise en place d'un réseau de recherche sur l'HPP (par exemple, en créant des structures coordonnées par l'OMS pour mener des études multipays, comme cela a été fait pour la COVID-19). Troisièmement, les femmes ainsi que les ONG et les OSC doivent être incluses dans le processus de mise en œuvre du programme de recherche (par exemple, en contribuant à l'élaboration des protocoles de recherche et/ou en participant à l'interprétation des résultats des travaux de recherche). Enfin, il convient d'améliorer la transparence, en particulier en ce qui concerne les pistes à suivre en matière d'innovation, notamment en précisant les données probantes nécessaires pour influencer les orientations mondiales en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux, pour ainsi mieux définir ce qui est attendu de la part des entités travaillant sur les innovations.

3.1.1 Activités clés et principaux jalons

La mesure immédiate qui doit être prise par **l'OMS et ses partenaires** pour répondre à ces priorités consiste à lancer les travaux préparatoires qui permettront d'aboutir au premier trimestre 2024 à la publication d'appels à propositions de façon à mettre en œuvre le programme de recherche. Ces travaux préparatoires seront les suivants :

- ▶ **Pendant le deuxième trimestre 2023**, préciser la formulation des 15 questions de recherche considérées prioritaires afin de les rendre plus claires ;
- ▶ **Pendant le deuxième trimestre 2023**, faire un point rapide sur les travaux de recherche en cours pour déterminer s'il existe des études

en cours susceptibles de répondre à certaines questions de recherche prioritaires ;

- ▶ **Pendant le troisième trimestre 2023**, formuler les questions de recherche les plus adaptées pour chaque question prioritaire et fournir des orientations sur la structure la plus adaptée pour les études qui doivent être menées ;
- ▶ **Pendant le troisième trimestre 2023**, élaborer des profils de politiques cibles afin de donner des indications sur les travaux de recherche encore nécessaires pour étayer les futures décisions politiques et sur ce à quoi les orientations pourraient ressembler une fois obtenue la réponse à une question de recherche donnée ;
- ▶ **Pendant le dernier trimestre 2023**, réaliser une évaluation rapide des besoins en termes de financement afin de déterminer le budget nécessaire à haut niveau pour mettre en œuvre le programme de recherche, avec notamment une cartographie des promesses de financement existantes et la détermination des lacunes restant à combler ; et
- ▶ **Pendant le premier trimestre 2024**, préciser en quoi doivent consister les pistes à suivre en matière d'innovation et les types de données nécessaires pour étayer les recommandations de l'OMS ou constituer un dossier en vue d'une inscription sur la liste de préqualification de l'OMS, de manière à ce que les données et les éléments probants obtenus soient adaptés.

Au fur et à mesure de l'avancement de son élaboration, le programme de recherche détaillé sera présenté aux **organismes donateurs** afin d'obtenir leurs contributions et leurs commentaires. Ces organismes sont supposés :

- ▶ Préparer les appels à propositions pour mener les travaux de recherche prioritaires ;
- ▶ Coordonner leurs travaux au sein d'un forum de coordination des donateurs pour faire en sorte que l'ensemble du programme de recherche soit couvert par leurs appels à propositions et qu'il n'y ait pas de redondance ; et
- ▶ Lancer les appels à propositions au cours du premier trimestre 2024 de sorte que les

bénéficiaires des subventions de recherche puissent mettre en œuvre le programme de recherche en cours d'année.

Certains résultats seront disponibles plus rapidement que d'autres, mais la plupart des études devraient durer de 2 à 4 ans et l'essentiel des nouvelles données devrait être disponible d'ici à 2027. Au fur et à mesure de la publication des résultats de ces travaux, l'OMS et les autres entités qui conçoivent des lignes directrices sur l'HPP procéderont à des mises à jour itératives de leurs orientations afin de prendre en compte ces nouvelles données probantes. Les avancées obtenues dans la recherche et le développement dans le contexte de ces priorités de recherche feront l'objet d'un suivi, et un examen des lacunes persistantes ou nouvelles en matière de recherche sera effectué d'ici à 2030. Le domaine stratégique de la recherche est étroitement lié à celui qui consiste à combler les lacunes en matière de normes et de règles relatives à l'HPP (voir la section 3.2), car les résultats des travaux de recherche prioritaires seront intégrés dans les lignes directrices et les politiques mondiales et nationales afin d'adapter régulièrement les pratiques en usage.

3.2 Domaine stratégique concernant les normes et les règles

Trois niveaux d'orientations sont nécessaires à la mise en pratique optimale des données probantes. Le premier niveau est celui des **lignes directrices mondiales**, publiées par des entités qui conçoivent des lignes directrices, comme l'OMS, FIGO et l'ICM. Ce type de lignes directrices pourrait porter sur un ensemble commun de recommandations de haut niveau sur l'HPP, harmonisées entre toutes les entités qui rédigent des lignes directrices, et dont le contenu serait détaillé sous forme de remarques pour chaque recommandation. La collaboration entre ces différentes entités doit absolument être améliorée. Une première étape judicieuse consisterait à ce que chacune partage avec les autres les synthèses de données probantes réalisées. Cela permettrait d'éviter les duplications, avec comme objectif à plus long terme de publier conjointement des lignes directrices mondiales unifiées

(notamment entre l'OMS, FIGO et l'ICM). Le deuxième niveau d'orientation est constitué par les **lignes directrices nationales** qui adoptent, adaptent et contextualisent les lignes directrices mondiales en fonction de la situation propre à chaque pays. Le troisième niveau d'orientation est représenté par les **produits dérivés de ces lignes directrices** (par exemple, sous la forme de protocoles, de guides pratiques, d'ensemble d'outils ou de manuels), dans lesquels ces recommandations sont converties en pratiques cliniques. Il est important de noter que les perspectives des femmes et les réalités des pays à revenu faible ou moyen doivent être davantage prises en compte dans le processus d'élaboration des lignes directrices.

Le risque associé à l'HPP peut être diminué par des interventions préventives visant à atténuer les facteurs de risque de l'HPP pendant la période précédant la conception et pendant les soins prénatals, mais les lignes directrices actuelles relatives à l'HPP s'intéressent essentiellement à la période intrapartum et à la période du post-partum immédiat, et les mesures préventives y sont généralement absentes. Les recommandations préventives concernant des déterminants et des facteurs de risque plus généraux sont en revanche généralement présentées dans d'autres lignes directrices (portant par exemple sur l'anémie ou les soins prénatals). Pour aider à l'élaboration de programmes et de politiques globales en matière d'HPP, les recommandations pertinentes provenant de différentes lignes directrices pourraient être réunies au sein d'un seul document unifié sur l'HPP. En outre, certains sujets essentiels ne font l'objet d'aucune recommandation ou sont abordés uniquement sous la forme de recommandations restreintes dans les lignes directrices actuelles. Il s'agit notamment des stratégies de diagnostic de l'HPP, du recours à la transfusion sanguine pour le traitement de l'HPP (lorsqu'une perte de sang importante est prévisible, par exemple en cas de placenta prævia ou de placenta accreta), et de l'administration de fer par voie intraveineuse pour l'anémie du post-partum. Il existe également un grand besoin d'orientations supplémentaires sur les dispositifs permettant de créer une tamponnade au niveau de l'utérus

Tableau 3.1 Les 15 premières questions de recherche prioritaires, par domaine

Domaine	Ordre de priorité	Question de recherche
Innovation	1	Quelles sont l'efficacité et l'innocuité comparatives de différentes voies d'administration alternatives (c'est-à-dire autres que la voie intraveineuse) de l'acide tranexamique dans le traitement de l'hémorragie du post-partum (HPP) ?
	2	Quelles sont l'efficacité et l'innocuité de l'administration de carbétocine thermostable pour le traitement de l'HPP chez les femmes ayant reçu ce médicament pour la prévention de l'HPP ?
	3	Quelle est l'efficacité comparative des ballonnets conçus pour créer une tamponnade intra-utérine par rapport à d'autres interventions créant une tamponnade (p. ex., des dispositifs d'aspiration) dans la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles liées à l'HPP ?
	4	L'utilisation de critères cliniques permettant de détecter une instabilité hémodynamique peut-elle favoriser un diagnostic plus précoce de l'HPP et améliorer les résultats en cas d'HPP, par rapport à la seule mesure de la perte sanguine ?
	5	Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour impliquer le secteur privé dans la mise au point de nouveaux médicaments ou dispositifs médicaux pour le traitement de l'HPP et de nouvelles méthodes de diagnostic de l'HPP dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ?
Mise en œuvre	1	Quels sont les obstacles à la mise en œuvre et les éléments pouvant faciliter l'adoption et l'utilisation des recommandations fondées sur des données probantes relatives à la prise en charge ?
	2	Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour garantir un accès aux médicaments contre l'HPP dont la qualité est assurée [notamment dans le cadre de la couverture sanitaire universelle (CSU)/des ensembles essentiels de services de santé et des programmes de prestations de santé] dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ?
	3	Quelles sont les stratégies de plaidoyer les plus efficaces pour améliorer l'adoption et assurer la pérennité des interventions basées sur des données probantes pour la prise en charge de l'HPP au niveau des pays ?
	4	Quels sont l'efficacité et le coût des programmes de formation initiale et de formation en cours d'emploi destinés aux agents de santé de première ligne (auxiliaires médicaux, médecins généralistes, agents de santé communautaires, sages-femmes, personnel infirmier) afin de les former à une prise en charge compétente des femmes qui présentent une HPP ainsi qu'à l'orientation de ces femmes vers les services adaptés ?
	5	Quelles sont les stratégies de mise en œuvre les plus efficaces pour améliorer l'adoption et assurer la pérennité des interventions basées sur des données probantes pour la prise en charge de l'HPP, y compris dans les contextes de crise humanitaire ?
Questions transversales	1	Quelle est l'efficacité d'une stratégie de détection précoce de l'HPP et de traitement de première urgence faisant appel à un ensemble d'interventions recommandées pour améliorer les résultats en cas d'HPP ?
	2	Quelles sont l'efficacité et l'innocuité du recours à un algorithme de diagnostic (p. ex., l'indice de choc) et à des stratégies de détection précoce (p. ex., le score d'alerte obstétricale précoce modifié) pour améliorer la détection clinique et la prise en charge de l'HPP ?
	3	Quelle est l'efficacité des listes de contrôle pour améliorer la qualité de la prise en charge de l'HPP et les résultats connexes par rapport à la norme actuelle de prise en charge ?
	4	Quelle est l'efficacité des programmes de surveillance des décès maternels et périnataux et de riposte pour diminuer le nombre de décès maternels dus à l'HPP ?
	5	Quelles sont l'efficacité et l'innocuité de l'administration d'acide tranexamique pour prévenir la survenue d'une HPP dans la population obstétricale générale et chez les femmes présentant un risque élevé d'HPP (p. ex., les femmes qui présentent une anémie) ?

Figure 3.1 Activités clés et principaux jalons pour le premier domaine stratégique : la recherche



et sur les aspects liés au système de santé (notamment concernant les interventions d'urgence), ainsi que sur les questions relatives à la mise en œuvre.

La base de données probantes sur laquelle reposent les recommandations actuelles, en particulier celles qui concernent les pratiques courantes, comprend essentiellement des données provenant de pays à revenu élevé qui ne peuvent pas toujours être généralisées aux pays à revenu faible ou moyen. À l'avenir, la **communauté des chercheurs** doit s'efforcer de concevoir et de mener des essais dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en se concentrant sur les moments dans le continuum de soins où sont observés la majorité des décès et pour lesquels il existe un manque de données (c'est-à-dire concernant le niveau de la communauté, l'orientation des patientes et le transport d'urgence, ainsi que les césariennes pratiquées en urgence).

3.2.1 Activités clés et principaux jalons

Dans la perspective de l'éventuelle publication conjointe de lignes directrices unifiées sur l'HPP par l'OMS, FIGO et l'ICM, les activités présentées ci-dessous ont été prévues.

- ▶ **À partir du troisième trimestre 2023**, l'OMS mettra en place un groupe directeur composé de personnes nommées par les entités qui conçoivent des lignes directrices mondiales et qui sera chargé d'explorer les mécanismes internes de ces organisations afin de déterminer la faisabilité d'une publication conjointe de lignes directrices unifiées sur l'HPP, en tenant compte des différents modèles opérationnels, processus d'élaboration de lignes directrices et méthodologies relatives aux lignes directrices propres à chaque organisation.
- ▶ **D'ici la fin du troisième trimestre 2023**, s'il a été estimé que la publication conjointe de lignes directrices unifiées était possible, le groupe directeur examinera les recommandations existantes concernant l'HPP afin de convenir du champ d'application des recommandations à inclure dans ces lignes directrices. Celles-ci seront élaborées en suivant une procédure

standard d'élaboration de lignes directrices conforme aux procédures d'approbation internes de tous les organismes participants et respectant ces procédures. Un soutien financier sera apporté par USAID. D'ici le dernier trimestre de l'année 2023, le groupe directeur proposera la composition du groupe d'élaboration de ces lignes directrices unifiées ; il identifiera également d'autres contributeurs potentiels, notamment des spécialistes de la méthodologie des lignes directrices, des équipes d'examen systématique, des pairs qui pourront procéder à un examen externe ainsi que des observateurs.

- ▶ **À partir du dernier trimestre de l'année 2023 et au cours de l'année 2024**, les organisations participantes mettront en commun les ressources disponibles et feront réaliser des synthèses systématiques des données probantes sur les questions prioritaires ainsi que des profils de données probantes (notamment pour les domaines de données probantes concernant l'efficacité, l'importance des résultats prioritaires à l'origine des recommandations, l'acceptabilité, la faisabilité, l'impact sur l'équité, l'utilisation des ressources et le rapport coût/efficacité).
- ▶ **D'ici au quatrième trimestre de l'année 2024**, les profils de données probantes devront être prêts pour que le groupe chargé de l'élaboration des lignes directrices puisse formuler de nouvelles recommandations ou mettre à jour les recommandations existantes. Les recommandations feront ensuite l'objet d'un examen par des pairs et d'une consultation externe.
- ▶ **Le premier trimestre de l'année 2025** correspond à la date cible pour le lancement des lignes directrices unifiées mondiales sur l'HPP.

Une fois les directives unifiées publiées, elles devront être largement diffusées pour être mises en œuvre. Une campagne de lancement mondiale sera organisée en 2025 avec la tenue de webinaires et d'ateliers régionaux. Au cours de la même année, des documents dérivés de ces lignes directrices (par exemple, des notes d'orientation) seront élaborés par les

organisations participant au processus conjoint, en collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS. Ces bureaux assureront également la coordination de la traduction des lignes directrices dans chacune des langues officielles de l'OMS et répondront au cas par cas aux demandes de traduction dans d'autres langues.

En attendant la publication de ces lignes directrices unifiées, l'OMS et ses partenaires continueront à tenir compte des nouvelles données probantes susceptibles d'avoir un impact sur l'HPP afin de publier des recommandations spécifiques en suivant leurs procédures internes actuelles (par exemple, l'approche des « lignes directrices évolutives » de l'OMS). Pour éviter tout retard dans la mise en pratique des connaissances existantes, en particulier dans les pays où ce phénomène représente un obstacle majeur aux progrès, l'OMS et les principales parties prenantes (par exemple, USAID, Concept Foundation et MSD for Mothers) s'emploieront à :

- ▶ Examiner les contextes dans lesquels s'inscrivent les politiques en matière d'HPP dans les pays où la charge de cette pathologie et la mortalité maternelle connexe sont élevées ;
- ▶ Fournir le soutien technique et financier nécessaire à la mise à jour des politiques en matière d'HPP et à leur adaptation au contexte local ;
- ▶ Se donner pour objectif l'actualisation des politiques en matière d'HPP dans au moins 20 pays à forte charge de morbidité d'ici le dernier trimestre de l'année 2024 ;
- ▶ Utiliser cette initiative comme modèle pour la mobilisation des différentes parties prenantes, qui pourra être étendue, selon les besoins, à d'autres pays à revenu faible ou intermédiaire entre 2025 et 2030

3.3 Domaine stratégique concernant la mise en œuvre

Si, comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, il existe des lacunes importantes dans le domaine de la recherche et s'il est vrai que le processus d'élaboration des normes et

critères pourrait être amélioré, les obstacles les plus difficiles à lever parmi ceux constatés dans chacun des quatre domaines stratégiques identifiés sont probablement ceux qui concernent la mise en œuvre. Lors du Sommet sur l'HPP, il a été largement reconnu que l'incapacité à mettre en œuvre les interventions fondées sur des données probantes constituait l'obstacle le plus important à l'amélioration des résultats obtenus dans la lutte contre l'HPP. Mais il a aussi été admis que, sur les quatre domaines stratégiques identifiés, l'élimination des obstacles à cette mise en œuvre pourrait être celui qui a le plus de chances d'avoir un impact important.

Pour réussir, la mise en œuvre d'interventions éprouvées nécessite la contribution de plusieurs acteurs et une collaboration à différents niveaux. Par exemple, la mise en œuvre d'une pratique clinique efficace nécessite non seulement la formation des agents de santé, mais également une reconfiguration du déroulement des activités cliniques, l'intégration d'équipes pluridisciplinaires, un engagement de la direction des structures de soins, un élargissement des autorisations prévues par les législations concernant le champ des activités relevant de chaque catégorie de personnel et/ou des ajustements des budgets alloués au secteur de la santé. Le fait que nombre de ces obstacles soient fortement liés au contexte signifie qu'ils ne pourront pas toujours être levés facilement par des campagnes menées au niveau mondial, mais qu'ils nécessiteront souvent la mise en place de solutions adaptées à la situation locale.

Reconnaissant que les obstacles à la mise en œuvre devant être levés sont nombreux, les parties prenantes participant au Sommet sur l'HPP ont donné la priorité à cinq catégories de ces obstacles qui peuvent être traités et nécessitent impérativement des mesures au niveau mondial. Ils ont également défini les mesures prioritaires que la communauté mondiale peut prendre pour les lever. Un récapitulatif de ces obstacles et de ces mesures est présenté au Tableau 3.2.

3.3.1 Activités clés et principaux jalons

Mise en place d'une politique nationale de santé claire et d'un leadership

Création d'un cadre pour la lutte contre l'HPP.

D'ici au troisième trimestre 2023, l'OMS et les principales parties prenantes rédigeront une première version d'un cadre pour la lutte contre l'HPP. Contrairement à ce qui a été fait pour des maladies transmissibles à forte charge de morbidité telles que l'infection à VIH, la tuberculose et le paludisme, aucun cadre holistique n'a jamais été défini de manière formelle en ce qui concerne l'HPP. L'absence d'un tel cadre de coordination peut conduire à ce que les approches ou la riposte en matière de prévention ou de traitement soient fragmentées, au lieu de porter sur l'ensemble des déterminants et des facteurs de risque contribuant à cette pathologie (par exemple, en fournissant des orientations limitées en matière de prévention prénatale et en négligeant des facteurs de risque tels que l'anémie, le placenta prævia et le placenta accreta). Une cartographie des interventions efficaces devra être établie en fonction de ce nouveau cadre, ce qui mettra en évidence les domaines pour lesquels de nouvelles recommandations devront être élaborées. Ce cadre pour la lutte contre l'HPP pourra également être utilisé pour structurer la future série de lignes directrices de l'OMS et pour rendre compte des avancées obtenues en matière de résultats sanitaires tout au long du continuum de soins. Il pourra être affiné en fonction des retours d'information.

Conception d'un système mondial de surveillance. D'ici la fin du quatrième trimestre 2024, l'OMS, FIGO, l'ICM ainsi que les ministères de la santé et les associations professionnelles des pays travailleront conjointement à un **exercice de délimitation** afin de définir les contours de ce système mondial de surveillance qui permettra de suivre l'évolution des pratiques, des résultats sanitaires et des inégalités. Ce système sera assorti de plans de pérennisation à l'intention du leadership au niveau national. Cet exercice de délimitation pourra par exemple inclure une cartographie des indicateurs existants relatifs à l'HPP pour lesquels des données sont recueillies dans différents pays, dans le but de définir et de convenir d'une liste commune d'indicateurs relatifs à l'HPP. Pour accroître les chances que

ces indicateurs soient mesurés par le plus grand nombre de pays, il conviendra, dans la mesure du possible, de tirer parti des systèmes de mesure et des activités de collecte de données existants. Il sera également indispensable de définir des cibles concrètes concernant l'HPP afin de fournir aux pays un objectif et des cibles qu'ils pourront chercher à atteindre. À titre d'exemple, les objectifs de l'ONUSIDA en matière de traitement de l'infection à VIH (90-90-90) ont permis de sensibiliser les populations à ce qu'il faut considérer comme un bon résultat et de créer une dynamique pour doter les stratégies nationales de ressources suffisantes en vue d'atteindre ces objectifs ambitieux, mais atteignables. La phase de délimitation doit également s'attacher à définir la fréquence de communication des données, les paramètres de ventilation des données (par exemple, par strate de population ou par niveau de système de santé), ainsi que les rôles et responsabilités en ce qui concerne la gestion et l'analyse des données ainsi que la préparation de rapports réguliers sur l'état d'avancement des travaux et les résultats obtenus. Un budget couvrant les activités à haut niveau doit être défini, tant pour la mise en place de ce système mondial de surveillance que pour sa gestion.

La phase de délimitation sera suivie d'une **phase de conception et d'expérimentation**. Cette phase aura pour but de développer plus en détail les éléments conceptuels qui auront été examinés au cours de la phase de délimitation. C'est également au cours de cette phase que seront effectués les choix technologiques pour la plate-forme de mesure commune et que seront précisés les aspects relatifs à la gestion des données (par exemple, le stockage des données et les considérations relatives à la protection de la vie privée). Avant son lancement à grande échelle, cette plateforme de mesure commune sera expérimentée dans un nombre restreint de zones géographiques représentatives. Cette phase de conception et d'expérimentation se poursuivra probablement jusqu'au quatrième trimestre 2024, le lancement mondial étant prévu pour l'année 2025. Le système mondial de surveillance sera également un outil essentiel pour mesurer les avancées obtenues par rapport aux priorités énoncées dans cette Feuille de route.

Figure 3.2 Activités clés et principaux jalons pour le deuxième domaine stratégique : les normes et les critères

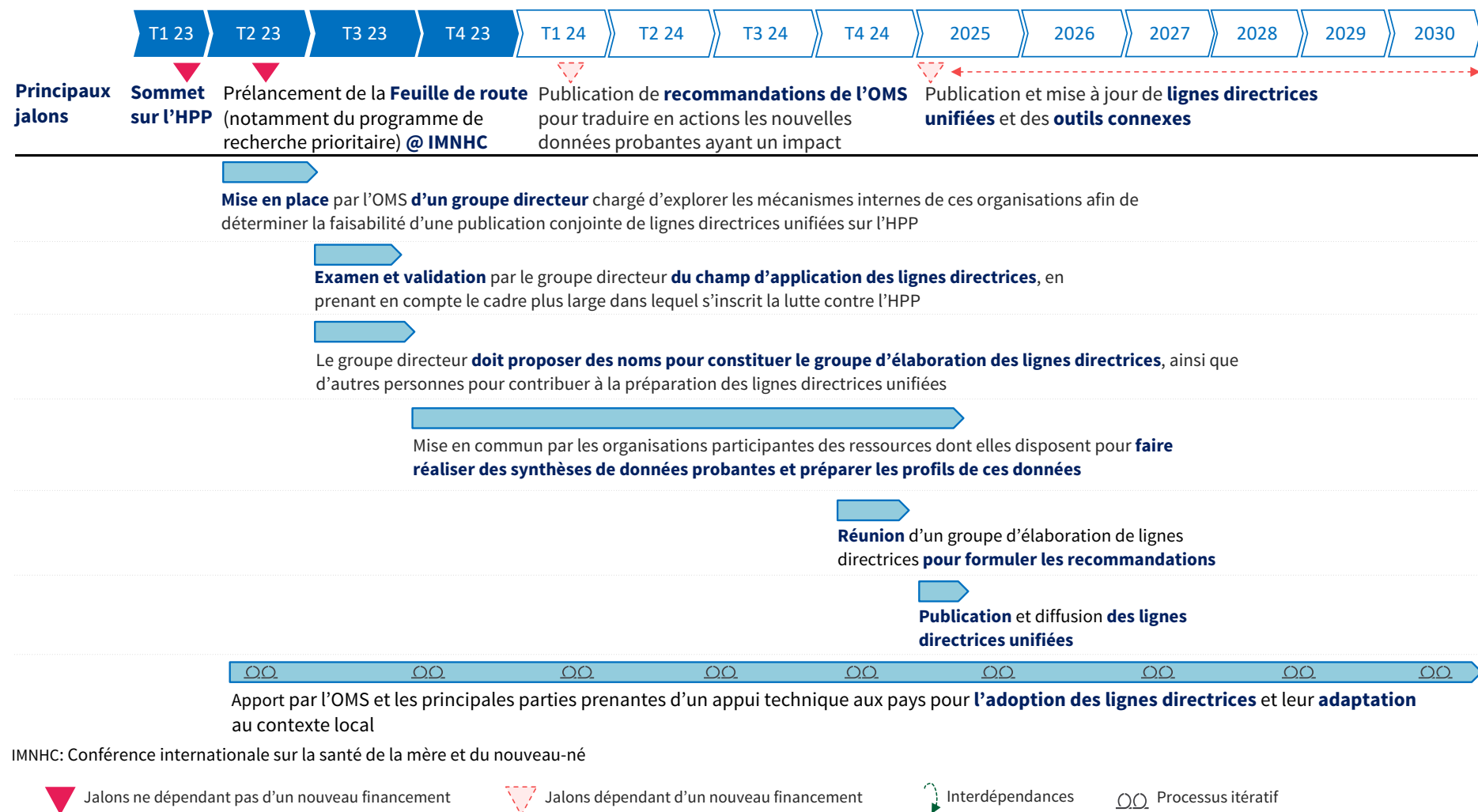


Tableau 3.2 Principales catégories d'obstacles à la mise en œuvre et mesures prioritaires pour les lever

Principales catégories d'obstacles à la mise en œuvre	Mesures prioritaires pour lever ces obstacles
Manque de politique nationale claire et de leadership : Dans la plupart des cas, il n'existe pas d'objectifs nationaux spécifiques en matière d'HPP ni de collecte systématique de données pour mesurer les avancées obtenues. Il existe également un décalage entre les lignes directrices mondiales et les lignes directrices nationales. Un renforcement de la politique nationale de santé et du leadership est indispensable si l'on veut que la lutte contre l'HPP soit incluse dans les programmes nationaux, qu'il existe un leadership clair et que des champions soient identifiés aux niveaux national et infranational.	Élaboration d'une politique nationale de santé claire et renforcement du leadership aux niveaux national et infranational : ▶ Premièrement, création d'un cadre mondial pour la lutte contre l'HPP permettant de structurer des programmes complets de prévention et de prise en charge de l'HPP afin d'aider à organiser et à coordonner les activités au niveau national. ▶ En parallèle, élaboration d'un système mondial de surveillance efficace et pérenne comprenant des indicateurs communs, une collecte systématique de données et une plateforme de mesure commune permettant de faire le suivi des avancées obtenues par les pays vis-à-vis de cibles définies. ▶ Pendant que l'OMS met à jour ses orientations normatives mondiales, adaptation des lignes directrices nationales aux différentes situations rencontrées sur le terrain et diffusion de ces orientations à tous les niveaux du système de santé, depuis les niveaux nationaux et infranationaux jusqu'aux établissements de santé communautaires. ▶ L'OMS et les principales autres parties prenantes piloteront un réseau permanent de champions de ministères de la santé qui montreront le chemin à suivre dans ce domaine.
Défaillances des systèmes d'achat et des chaînes d'approvisionnement : Les ruptures de stock fréquentes de médicaments et de dispositifs médicaux utilisés pour le traitement de l'HPP sont responsables d'orientations inutiles de femmes d'un établissement de santé vers un autre. La tendance est souvent de privilégier leur accessibilité financière au détriment de leur qualité. La question de la disponibilité en sang et en produits sanguins doit également être réglée.	Amélioration de la disponibilité et de l'accès à des médicaments et des dispositifs médicaux de qualité et abordables pour le traitement de l'HPP à tous les niveaux du système de santé : ▶ Alors qu'une infrastructure de leadership est mise en place au niveau des pays, les différents acteurs au sein de la communauté internationale doivent collaborer afin d'assurer une coordination étroite entre les partenaires, l'augmentation des investissements et le développement des initiatives d'achat existantes ou nouvelles. ▶ Les systèmes et les chaînes d'achat et d'approvisionnement doivent être renforcés aux niveaux national et infranational. Dans un premier temps, l'OMS et ses partenaires (par exemple, le FNUAP, le Mécanisme mondial de financement de l'initiative Toutes les femmes, tous les enfants et la Reproductive Health Supplies Coalition) devront identifier les solutions possibles (par l'introduction de mécanismes d'achats nouveaux ou l'amélioration des mécanismes existants) avec pour objectif de lancer une initiative ciblée pour les approvisionnements en 2026. Les mesures prises doivent concerner les dispositifs médicaux, les médicaments ainsi que les produits sanguins (par exemple en mettant en place des banques du sang adaptées).

Principales catégories d'obstacles à la mise en œuvre	Mesures prioritaires pour lever ces obstacles
Manque de personnel, et manque de formation et de supervision des agents de santé : De nombreux pays ne disposent pas d'un nombre suffisant d'agents de santé bien formés, responsabilisés et motivés, alors que ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la prestation de soins de qualité. La formation initiale ne couvre pas toujours de manière suffisante la détection, la prévention et la prise en charge de l'HPP, et les possibilités de formation en cours d'emploi sont souvent limitées à certains membres du personnel. L'insuffisance des effectifs, leur répartition inappropriée et la difficulté à maintenir en poste des agents de santé constituent également des problèmes récurrents, les zones reculées étant les plus durement touchées. Enfin, dans de nombreux endroits, les rôles et le statut social du personnel infirmier et des sages-femmes ou le statut que leur confère une réglementation inadaptée ne leur permettent pas de dispenser certains soins pouvant sauver des vies, car ceux-ci ne relèvent pas de leurs compétences et ne correspondent pas à leurs aptitudes.	Assurance de la disponibilité en agents de santé compétents pour fournir des services ainsi que pour dispenser des médicaments et des produits pertinents et de qualité : ▶ Renforcement des programmes existants de formation initiale et de formation en cours d'emploi, et élargissement de ces programmes par des activités de supervision et de mentorat et en offrant d'autres possibilités de développement professionnel en rapport avec la prise en charge de l'HPP. ▶ Élargissement de ces activités par la mise en œuvre de stratégies plus larges en matière de ressources humaines afin de remédier aux pénuries chroniques de personnel de santé qualifié (sages-femmes, personnel infirmier, médecins).
Inégalités et difficultés pour accéder à une prise en charge de qualité : Il existe des disparités persistantes et injustes dans l'accès aux soins, par exemple entre les populations rurales et urbaines, ou dans un cadre donné (p. ex., absence de prise en charge dans des bidonvilles en zone urbaine). Du point de vue des droits de l'homme, il est impératif de remédier à ces inégalités profondes qui fragilisent encore davantage les populations vulnérables ou marginalisées. Par exemple, dans certaines régions, les établissements de santé du secteur public sont trop éloignés et les femmes doivent se rendre dans des établissements du secteur privé où le coût des soins n'est pas pris en charge par les régimes d'assurance nationaux. De plus, dans de nombreux endroits, les systèmes de transport et d'orientation des patientes sont très peu développés.	Amélioration de l'équité en facilitant l'accès à des soins de qualité et en supprimant les frais d'utilisation : ▶ Amélioration des infrastructures de prestation de services pour renforcer les installations (p. ex., rénovations pour moderniser les structures vétustes ou ajouts de bâtiments pour répondre à une demande plus importante). ▶ Amélioration des systèmes de transport et d'orientation des patientes. ▶ Les gouvernements doivent également prendre des mesures fortes pour élaborer des plans de financement visant à supprimer les frais d'utilisation et à élargir la couverture de l'assurance maladie afin de réduire les frais à la charge des patientes concernant les principaux produits liés à la prise en charge de l'HPP (p. ex. en élargissant la couverture du système de santé aux médicaments et aux dispositifs médicaux utilisés pour cette prise en charge).
Droits et statut social limités des femmes : Un certain nombre d'obstacles et de normes juridiques, sociales et culturelles peu favorables limitent les choix de vie des femmes et les options qu'elles peuvent avoir concernant leurs grossesses et leurs accouchements. Parmi ces obstacles, on trouve le statut social inférieur des femmes, l'accès limité à l'éducation ou aux possibilités de bénéficier d'une éducation, ainsi que la possibilité limitée de faire partie de la population active dans certains endroits et, ailleurs, le soutien insuffisant de l'État en ce qui concerne les congés de maternité rémunérés. Certaines normes culturelles peuvent également limiter les choix des femmes en matière de grossesse et de procréation, par exemple en valorisant les grossesses répétées à intervalles rapprochés, en décourageant ou en retardant la recherche de soins et en ne permettant pas un temps de récupération suffisant après l'accouchement avant la reprise des tâches ménagères. Plusieurs facteurs de risque de l'HPP, tels que l'anémie et la grande multiparité, sont directement liés au fait que les femmes ne jouissent pas de droits suffisants et que leur statut social est inférieur à celui des hommes. En outre, de nombreux obstacles à la diminution des cas d'HPP persistent en raison d'une passivité bien ancrée en ce qui concerne la santé et le bien-être des femmes.	Plaidoyer en faveur de la santé et des droits des femmes : ▶ Positionnement des femmes au centre de l'agenda politique, que ce soit au niveau infranational, national ou international. ▶ Toutes les parties prenantes doivent s'unir pour défendre sans relâche les droits des femmes. ▶ Sensibilisation de la population générale à l'HPP pour aider à réduire les retards dans le recours aux soins (p. ex., par le biais de brochures d'information destinées aux patientes). ▶ Poursuite du travail de plaidoyer afin que la santé maternelle ne soit plus négligée et bénéficie d'un financement pérenne.

Adoption et adaptation des lignes directrices.

Pour soutenir la diffusion et la mise en œuvre des lignes directrices dans les pays, l'OMS et les principales parties prenantes animeront en permanence un réseau de champions du Sommet représentant différents ministères de la santé de différentes parties du monde. Ce réseau supervisera la collecte d'informations sur ce que les pays attendent de l'OMS et des autres entités qui conçoivent des lignes directrices pour les aider à adopter et à adapter les orientations mondiales. Lorsque les nouvelles lignes directrices seront publiées par l'OMS et ces autres entités, ce réseau organisera des ateliers régionaux et des webinaires afin de présenter aux pays ces nouvelles recommandations et de leur proposer un soutien personnalisé pour les aider à les adapter à leur contexte. Plus concrètement, l'OMS publiera des synthèses facilement utilisables de ses lignes directrices afin d'améliorer le respect des recommandations, notamment une mise à jour du manuel *Managing Complications in Pregnancy* (20) qui sera disponible en ligne. Le réseau s'appuiera sur les bureaux régionaux et les bureaux de pays de l'OMS pour aider à la traduction des documents mondiaux dans des langues autres que l'anglais et à l'élaboration de produits dérivés, par exemple des notes d'orientation fournissant des explications sur les interventions recommandées et leur fondement ou des manuels opérationnels qui serviront de guides pratiques de mise en œuvre à l'intention des agents de santé. Une attention particulière sera accordée aux pays où l'HPP représente une charge significative, et les bureaux de l'OMS dans les pays joueront un rôle important en aidant à l'organisation d'ateliers locaux et à l'élaboration de documents adaptés au contexte. En outre, les organisations Laerdal Global Health et Jhpiego s'associeront pour concevoir du matériel de formation et des guides pratiques afin de faciliter la mise en œuvre dans les pays.

Renforcement des systèmes d'achat et des chaînes d'approvisionnement

Achats groupés et interventions visant à influencer les marchés. L'OMS et ses partenaires mondiaux qui jouent actuellement un rôle dans les achats groupés, comme le Mécanisme mondial de financement de l'initiative Toutes les femmes, tous les enfants, Reproductive Health

Supplies Coalition et le FNUAP réaliseront d'ici au quatrième trimestre 2023 un exercice de délimitation afin d'évaluer les solutions possibles pour que dorénavant les médicaments et les produits utilisés qui sont achetés pour le traitement de l'HPP soient de meilleure qualité et pour accroître le financement international de ces produits. Même dans les initiatives existantes d'achats groupés, différents modèles sont utilisés. En ce qui concerne l'infection à VIH, la tuberculose et le paludisme, les pays qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'un financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont la possibilité d'utiliser cette subvention pour acheter des produits par le biais du mécanisme d'achat groupé du Fonds mondial. Les produits disponibles via ce mécanisme sont achetés par une équipe dédiée du Fonds mondial dont le rôle est d'optimiser les objectifs de structuration du marché, notamment en ce qui concerne les coûts, la disponibilité et la qualité. Il est important de noter que tous ces produits ont été approuvés par une autorité de réglementation rigoureuse au niveau mondial [par exemple, par le programme de préqualification de l'OMS ou la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d'Amérique]. Les pays peuvent également utiliser les subventions du Fonds mondial pour s'approvisionner en produits via leurs propres canaux d'approvisionnement nationaux. Enfin, les pays peuvent utiliser leurs fonds propres pour acheter des produits figurant sur la liste du Fonds mondial par le biais son mécanisme d'achat groupé et bénéficier ainsi des avantages commerciaux négociés par le Fonds mondial, ce qui leur permet de profiter de prix plus avantageux.

Plusieurs initiatives régionales d'achats groupés ont également été mises en place pendant la pandémie de COVID-19, en particulier en Afrique. Ces processus vont au-delà de la simple passation de marchés et contribuent de manière significative à la mise en place d'interventions visant à influencer les marchés, notamment par le biais d'activités telles que l'approvisionnement par appels d'offres pluriannuels, la gestion des relations avec les fournisseurs et la mise en application de normes en matière de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité. Tous ces mécanismes seront analysés lors de la phase

de délimitation. Les résultats de cet exercice serviront de base à un examen des avantages relatifs des différentes solutions possibles pour augmenter le financement international afin d'acheter des produits de qualité pour la prise en charge de l'HPP. À l'heure actuelle, la plupart des médicaments et des dispositifs médicaux utilisés pour la prise en charge de l'HPP sont achetés par les gouvernements en utilisant des fonds nationaux. Il conviendra donc d'évaluer soigneusement les compromis entre l'encouragement à un regroupement régional ou mondial de la demande ainsi que des achats et le renforcement des capacités d'achat des pays, en tenant compte d'aspects importants comme la prise en main par les pays. L'exercice peut s'avérer plus pertinent si l'on considère de manière générale les produits ou les médicaments essentiels en rapport avec la santé maternelle au lieu de se limiter aux seuls produits destinés à la prise en charge de l'HPP. Une fois terminée la phase de délimitation, et en fonction des solutions qui auront été retenues en priorité, l'OMS et ses partenaires mondiaux lanceront une phase de conception globale au cours de laquelle seront définis les différents éléments conceptuels précis en fonction de la solution privilégiée. Elle sera suivie d'une phase d'expérimentation au cours des années 2024 et 2025, avant un déploiement à grande échelle en 2026.

Assurance de la qualité des médicaments et des produits. L'OMS pilotera un processus visant à hiérarchiser les principaux médicaments et produits en rapport avec la santé de la mère et du nouveau-né, notamment ceux identifiés dans la Feuille de route pour lutter contre l'HPP, afin de faciliter la mise en œuvre et le passage à l'échelle des interventions nécessaires. Une réunion d'experts se tiendra en octobre 2023 pour finaliser une liste restreinte de produits recommandés par l'OMS ; cette réunion sera suivie par l'élaboration d'orientations de mise en œuvre qui proposeront des stratégies destinées à lever les freins à l'approvisionnement et à éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les agents de santé, les femmes et leur famille. D'ici à fin 2024, l'OMS et les principales parties prenantes, notamment les ministères de la santé, établiront des normes pour les organismes de réglementation nationaux afin d'accélérer le processus de certification des différents médicaments,

produits et dispositifs médicaux qui ont obtenu la certification d'une autorité de réglementation rigoureuse ou le statut de préqualification de l'OMS. L'OMS et ses partenaires aideront les ministères de la santé à élaborer des orientations relatives à la chaîne d'approvisionnement dans lesquelles sera rendu obligatoire l'achat de produits dont la qualité est garantie. Conscients que la réglementation relative aux dispositifs médicaux ainsi qu'au sang et aux produits sanguins peut être complexe et difficile à maîtriser, l'OMS et ses partenaires vont également établir une cartographie des orientations concernant les chaînes d'approvisionnement utilisées dans le monde pour se procurer des dispositifs médicaux et des produits sanguins de qualité, suggérer des améliorations de ces orientations et en combler les lacunes éventuelles afin de les rendre plus claires et de faire en sorte que l'ensemble de ces orientations aient un niveau de rigueur cohérent partout dans le monde.

Renforcement des effectifs ; amélioration de la formation et de la supervision des agents de santé

Élargissement du rôle des sages-femmes. D'ici à fin 2024, l'OMS, en collaboration avec FIGO, l'ICM, les ministères de la santé et les associations professionnelles nationales, appuiera une action en faveur d'un élargissement de la législation et de la réglementation régissant la profession de sage-femme et d'autres catégories d'agents de santé comme le personnel infirmier. L'ICM a publié un document précisant le champ des pratiques et des compétences des sages-femmes (comprenant par exemple la capacité à administrer des traitements par voie intraveineuse) (21), mais la législation et la réglementation tardent à évoluer. L'OMS et ses partenaires continueront de plaider en faveur de la nécessité de disposer d'un cadre réglementaire fondé sur des données probantes au niveau national pour le personnel de santé qualifié qui dispense des soins pendant l'accouchement, et pour que les pays mettent en œuvre un cadre national de compétences et de normes qui reconnaisse le rôle clé joué par les sages-femmes.

Soutien à la formation. L'OMS, en collaboration avec FIGO, l'ICM, Jhpiego, Laerdal Global Health, les ministères de la santé et les sociétés

professionnelles au niveau des pays œuvreront sans relâche au renforcement de la formation initiale et de la formation en cours d'emploi des agents de santé dans le cadre du développement professionnel continu. Cela se fera en élaborant et en tenant à jour un ensemble complet d'outils visant à favoriser l'amélioration de la qualité des soins et en recourant à des formations en personne ou à des outils numériques, selon les besoins. Cela supposera le développement de réseaux de mentorat, l'utilisation de la communauté de pratique mondiale en rapport avec l'HPP et la création de communautés de pratique locales pour partager les expériences et les enseignements, l'organisation régulière de webinaires, la promotion de l'accompagnement à distance, l'organisation de formations pratiques au travail d'équipe et d'exercices de simulation, en particulier pour les équipes qui interviennent en cas d'urgence obstétricale.

Promotion de l'équité et amélioration de l'accès aux soins

Réduction des frais à la charge des patientes.

D'ici la fin du quatrième trimestre 2023, l'OMS et les principales parties prenantes lanceront un exercice de délimitation afin de définir les solutions innovantes possibles qui permettraient de réduire les frais à la charge des patientes concernant la prise en charge de leur grossesse et de leur accouchement. Cet exercice comprendra une phase d'examen rapide de la situation en étudiant les modèles actuels qui ont fait leurs preuves dans certains pays exemplaires où les frais à la charge des patientes sont limités. Il permettra également de décrire en détail certains des principaux obstacles financiers qui freinent l'accès aux soins dans certains pays à forte charge de morbidité, comme les frais à la charge des usagers ou les régimes d'assurance restrictifs qui peuvent être localisés, limités dans le temps ou contributifs, ce qui exclut une grande partie des personnes sans emploi ou des populations marginalisées. Une évaluation des meilleures pratiques et des solutions possibles sera effectuée en fonction de la faisabilité de leur mise en œuvre et de leur impact escompté. En 2024, l'OMS et les principales parties prenantes procéderont à la codification de ces bonnes pratiques et de ces moyens innovants permettant de réduire les frais à la charge des patientes, et préciseront les circonstances dans lesquelles

chaque solution devra être déployée dans le cadre d'un programme plus large d'amélioration de la CSU. En 2025, l'OMS et ses partenaires expérimenteront certaines de ces initiatives, par exemple au niveau infranational dans certains endroits jugés prioritaires.

Promotion des droits et du statut social des femmes

Plaidoyer en faveur des droits des femmes et sensibilisation renforcée à la lutte contre l'HPP.

Pour que la santé des femmes devienne une priorité dans les programmes politiques, les activités de plaidoyer devront être coordonnées à tous les niveaux. L'OMS et les principales parties prenantes appuieront les actions en cours et s'associeront à de nouvelles initiatives visant à sensibiliser les décideurs à l'HPP, aux raisons de son importance, aux moyens permettant de réduire ses risques de survenue et à la manière de la prendre en charge de façon appropriée. Ces actions devront souligner la nécessité de disposer de lignes directrices nationales actualisées prenant en compte les dernières données disponibles, d'acheter des médicaments et des produits de qualité (par exemple, des utérotoniques et de l'acide tranexamique) et de renforcer les systèmes d'orientation des patientes. Dans la population générale, les activités de sensibilisation se concentreront sur une communication expliquant en quoi consiste l'HPP et pourquoi il est important de la prendre en charge rapidement afin de contribuer à la réduction des retards dans le recours aux soins. Des campagnes de sensibilisation permettront également de faire comprendre comment il est possible de réduire le risque de décès dû à l'HPP, par exemple en accouchant dans un établissement de santé. Dans cette optique, l'OMS et ses partenaires apporteront leur soutien aux campagnes mondiales, régionales et locales, et mettront au point des plans de sensibilisation des patientes qui pourront ensuite être adaptés aux besoins locaux.

3.4 Domaine stratégique concernant le plaidoyer

À l'heure actuelle, il n'existe aucune force fédératrice qui permettrait de faire progresser le programme de prévention et de prise en charge de l'HPP et de mobiliser les fonds nécessaires.

Figure 3.3 Activités clés et principaux jalons pour le troisième domaine stratégique : la mise en œuvre



CSU : couverture sanitaire universelle ; FIGO : Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique ; FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la population ; GFF : Mécanisme mondial de financement de l'initiative Toutes les femmes, tous les enfants ; ICM : Confédération internationale des sages-femmes ; IMNHC : Conférence internationale sur la santé de la mère et du nouveau-né ; HPP : hémorragie du post-partum.



Jalons ne dépendant pas d'un nouveau financement



Jalons dépendant d'un nouveau financement

Il convient donc de renforcer fortement le plaidoyer à différents niveaux pour que la lutte contre l'HPP figure en bonne place dans les programmes politiques au niveau mondial. Un travail de plaidoyer peut aider à sensibiliser à l'importance d'une prise en charge rapide et efficace de l'HPP et à mieux faire connaître l'existence d'interventions pouvant sauver des vies et l'accessibilité de ces interventions, par exemple l'administration d'utérotoniques ou de transfusions sanguines et les interventions chirurgicales. Les personnes impliquées dans le plaidoyer peuvent aussi veiller à ce que les agents de santé soient formés à la prévention et à la prise en charge de l'HPP, à ce que les établissements de santé disposent des fournitures et du matériel nécessaires et à ce que les politiques et la santé et la sécurité maternelles soient considérées comme des priorités dans les lignes directrices.

Plus spécifiquement, les activités de plaidoyer doivent porter sur cinq domaines principaux.

- i. Elles doivent cibler les responsables de l'élaboration des politiques et les politiciens pour qu'ils favorisent l'élimination des obstacles juridiques et réglementaires qui limitent l'accès à des soins d'importance vitale. Dans certains endroits, les agents de santé de première ligne comme les sages-femmes ne sont pas autorisés à administrer certains médicaments (par exemple l'ocytocine ou l'acide tranexamique par voie intraveineuse). Un effort de plaidoyer important est donc nécessaire pour que l'ensemble du personnel de santé qualifié qui dispense des soins pendant l'accouchement puisse participer à la prestation des soins dans toute la mesure de ses capacités.
- ii. Elles doivent se concentrer sur les ministères de la santé et les agences nationales de santé concernés pour promouvoir la nécessité de mettre à jour les orientations nationales afin que celles-ci tiennent compte des dernières orientations mondiales et des meilleures données probantes disponibles.
- iii. Elles doivent promouvoir le rôle de la sage-femme et garantir une formation et un soutien adéquats.

- iv. Elles doivent mettre en avant l'importance cruciale de la disponibilité, de l'accessibilité financière et de la qualité des médicaments, des fournitures et des technologies en rapport avec l'HPP, ce point devant être porté à l'échelon ministériel.
- v. Elles doivent cibler la population dans son ensemble, être associées à un effort de sensibilisation à la détection de l'HPP et à la prise en compte des facteurs de risque, et insister sur la nécessité d'un recours rapide aux soins.

Pour être en mesure de mener à bien cet ambitieux programme de plaidoyer, l'ensemble des parties prenantes doit se mobiliser et travailler en synergie pour obtenir des résultats. Il est essentiel de placer les femmes au centre du programme de plaidoyer. Les mouvements de femmes peuvent contribuer à mobiliser l'attention sur l'HPP et à rendre les gouvernements redevables de leurs actions. La société civile et les communautés peuvent sensibiliser l'opinion publique et appeler à ce que les dirigeants du gouvernement prennent des engagements politiques. Un engagement au niveau ministériel sera particulièrement important pour que l'HPP soit considérée comme une priorité et que les ressources nécessaires soient allouées aux programmes concernés. Le fait d'obtenir des éléments probants et des données pourra contribuer à catalyser l'action des pouvoirs publics ; les chercheurs ont donc eux aussi un rôle important à jouer. De telles actions menées conjointement et de manière coordonnée peuvent permettre d'obtenir des changements significatifs.

Pour être efficaces, les méthodes utilisées pour le plaidoyer devront être adaptées à chaque situation, en accordant la priorité aux personnes les plus durement touchées (par exemple, les populations marginalisées et les communautés rurales). Les activités de plaidoyer peuvent notamment inclure une « Journée mondiale de lutte contre l'HPP » ainsi que des conférences régionales (par exemple, un Sommet sur l'HPP en Afrique). Toutefois, ces activités doivent dépasser l'écosystème de l'HPP, cibler d'autres ministères (par exemple, les ministères des transports et des finances) et impliquer

Figure 3.4 Activités clés et principaux jalons pour le quatrième domaine stratégique : le plaidoyer



un ensemble plus large de parties prenantes œuvrant dans le secteur de la santé de la mère et du nouveau-né. La communauté engagée dans la lutte contre l'HPP doit également tirer parti des liens existant avec d'autres priorités sanitaires et des investissements faits au profit d'autres priorités programmatiques (par exemple, la capacité de la chaîne du froid utilisée pour les vaccins). La pérennité du financement des activités de plaidoyer en faveur de la lutte contre l'HPP sera essentielle pour que les résultats obtenus puissent perdurer.

3.4.1 Activités clés et principaux jalons

À court terme, trois grandes initiatives seront lancées. Premièrement, une stratégie mondiale d'image de marque pour la réduction de la mortalité maternelle liée à l'HPP sera élaborée, accompagnée d'un cadre mondial pour les activités de plaidoyer. Deuxièmement, un cadre pour le plaidoyer au niveau régional et national sera créé. Et troisièmement, une Journée mondiale de lutte contre l'HPP sera instaurée.

Stratégie mondiale d'image de marque et cadre mondial pour les activités de plaidoyer en faveur de la réduction de la mortalité maternelle liée à l'HPP

Une stratégie mondiale d'image de marque pour la lutte contre l'HPP menée conjointement et de manière coordonnée peut contribuer à uniformiser des activités de plaidoyer souvent fragmentées et à harmoniser les messages contradictoires ou pouvant prêter à confusion. Cette stratégie doit être envisagée comme une structure permettant d'amplifier les actions menées à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Elle fournira des orientations précieuses sur la manière de cibler les efforts de sensibilisation auprès des différents groupes de parties prenantes et mettra à profit les enseignements tirés des années d'efforts de plaidoyer menés avec succès dans d'autres domaines de la santé. Une première étape consistera, d'ici au troisième trimestre 2023, à mettre en place un groupe de travail sur le plaidoyer avec l'OMS, d'autres organisations multilatérales, des OSC, des ONG et la communauté de pratique concernant l'HPP. Au cours de l'année 2024, ce groupe de travail devra élaborer la stratégie mondiale d'image de marque et un cadre pour les activités de plai-

doyer. Cette stratégie et ce cadre comporteront plusieurs éléments constitutifs. Ils permettront de développer des messages convaincants et fondés sur des données probantes pour plaider en faveur de la mise à jour ainsi que de l'adaptation des lignes directrices nationales et de la mise en place de changements dans la législation et la réglementation en vue d'éliminer les obstacles à l'accès à des soins de qualité (par exemple en ce qui concerne le rôle des sages-femmes) et d'accélérer la mise en œuvre d'innovations dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cet ensemble d'outils complet comprendra également des messages spécifiques reprenant des témoignages percutants provenant des jeunes générations qui pourront être utilisés pour créer des messages ciblés à l'intention des populations clés. Pour faire en sorte que les résultats soient pérennes, le cadre des activités de plaidoyer définira les rôles et les responsabilités de chacun ainsi que des mécanismes de responsabilisation. Des champions au niveau mondial et au niveau local, par exemple des ambassadeurs de bonne volonté très en vue, seront sélectionnés pour contribuer aux efforts de plaidoyer. Fait important, le groupe de travail créera une image de marque spécifique à l'HPP qui pourra être utilisée pour marquer d'un repère visuel l'ensemble des activités de plaidoyer qui seront menées pour lutter contre l'HPP. Cette image de marque comprendra notamment un logo et une palette de couleurs facilement identifiables. Des documents destinés à soutenir les campagnes de sensibilisation, qu'elles soient menées par le biais d'ateliers, de webinaires ou de séances de formation, seront conçus sur mesure pour les différents publics et utiliseront la nouvelle image de marque spécifique à la lutte contre l'HPP.

Cadre pour le plaidoyer aux niveaux régional et national

La stratégie d'image de marque mondiale et le cadre de plaidoyer constitueront un ensemble complet de documents, de messages adaptés et de supports visuels convaincants conçus à l'avance et qui pourront être utilisés pour mener des activités de plaidoyer à tous les niveaux. Toutefois, les messages seront d'autant plus convaincants qu'ils seront adaptés aux situations et aux contextes locaux. Le cadre mondial

pour le plaidoyer proposera un contenu modulaire qui pourra être adapté en fonction des besoins. Au cours des années 2024 et 2025, le groupe de travail sur le plaidoyer et les autres parties prenantes intéressées travailleront à l'élaboration d'un contenu et de documents qui pourront être utilisés pour mener des activités de plaidoyer aux niveaux régional et national. Un processus itératif permettra aux acteurs régionaux et nationaux de fournir un retour d'information qui servira à ajuster et à préciser le cadre mondial des activités de plaidoyer.

Journée mondiale de lutte contre l'HPP

La Journée mondiale de lutte contre le paludisme et la Journée mondiale de la vaccination ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation à ces problèmes de santé publique. La communauté engagée dans la lutte contre l'HPP a fait part de son intérêt pour l'instauration d'une Journée mondiale de lutte contre l'HPP qui pourrait permettre de sensibiliser et communiquer sur le sujet, saluer les progrès accomplis, informer la population des nouvelles découvertes, partager les retours d'expérience et les témoignages, mobiliser la communauté en vue de résoudre les problèmes en suspens et appuyer les initiatives visant à mobiliser des ressources. Un tel événement peut également aider à rendre l'HPP plus visible et à la faire figurer en bonne place dans les agendas politiques. Au cours du troisième trimestre de l'année 2023, les agences et les partenariats des Nations Unies se concerteront avec les États membres qui leur apportent un soutien afin d'arrêter la date de la Journée et déposer une demande d'organisation de commémoration officielle. Cette démarche est prévue dans le courant de l'année 2024. Enfin, l'OMS et ses partenaires organiseront la première Journée mondiale de lutte contre l'HPP, en ciblant un lancement en 2025. Cette première Journée mondiale publique servira également de plateforme de lancement pour la stratégie d'image de marque de la lutte contre l'HPP. Cet événement et les activités préparatoires connexes seront ensuite répétés chaque année.

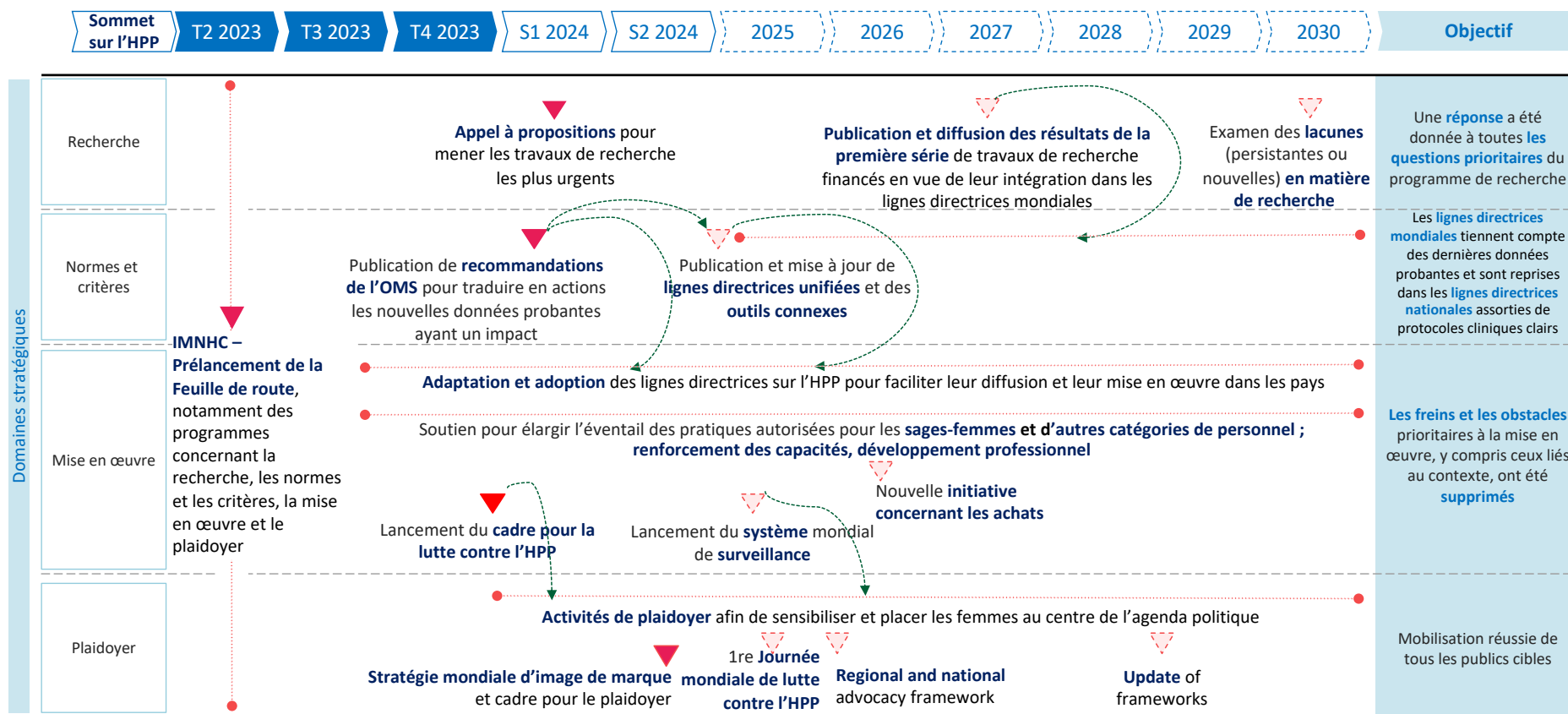
3.5 Interdépendances entre les quatre domaines stratégiques de la Feuille de route

Les activités clés et les jalons correspondant à chacun des quatre domaines stratégiques ont été décrits dans les sous-chapitres ci-dessus. Ces quatre domaines ne sont toutefois pas considérés comme des axes de travail distincts fonctionnant en parallèle. Ils sont au contraire interdépendants, les activités relevant de l'un des domaines stratégiques se répercutant dans d'autres domaines stratégiques, les faisant progresser. Ainsi, les nouvelles données issues des travaux de recherche contribuent à l'élaboration et à la publication de nouvelles normes et de nouveaux critères mondiaux, qui doivent à leur tour être adaptés aux contextes locaux avant d'être mis en œuvre. Le cadre mondial pour la lutte contre l'HPP et le système mondial de surveillance contribuent tous deux aux activités de plaidoyer fondées sur des données, lesquelles aideront à obtenir le soutien politique nécessaire à la poursuite du travail normatif et de mise en œuvre.

Une vue d'ensemble de certaines des interdépendances et des synergies attendues entre différentes activités relevant de chacun des quatre domaines stratégiques est présentée à la Figure 3.5. L'intention n'est pas ici de rendre compte de manière exhaustive des différentes manières dont les domaines stratégiques peuvent s'interconnecter et concourir les uns aux autres, mais de fournir des exemples illustrant la situation pour la période comprise entre 2023 et 2030.

Les activités clés et les jalons de la Feuille de route pour lutter contre l'HPP seront intégrés aux éléments qui contribuent actuellement à l'intensification des interventions et des pratiques visant à promouvoir la santé de la mère et du nouveau-né fondées sur des données probantes par le biais des plans d'accélération du Plan d'action « Chaque nouveau-né » et de la stratégie Mettre un terme aux décès maternels évitables qui ont été mis en place dans 30 pays (22).

Figure 3.5 | Interdépendances entre les quatre domaines stratégiques de la Feuille de route



IMNHC: International Maternal Newborn Health Conference; PPH: postpartum haemorrhage.

▼ Jalons ne dépendant pas d'un nouveau financement ▼ Jalons dépendant d'un financement → Interdépendances

4. Appel mondial à l'action

Seule une action concertée de l'ensemble des parties prenantes permettra la réalisation de l'ambitieux programme décrit dans la présente Feuille de route. Cet Appel à l'action mondial met en lumière les principaux constats faits lors du Sommet sur l'HPP et propose des activités concrètes à entreprendre par chaque groupe de parties prenantes, démontrant ainsi que chacune d'entre elles peut jouer un rôle.

Les principaux constats mis en évidence à l'issue de ce Sommet sont énoncés ci-dessous.

- ▶ **La voix des femmes et des communautés doit être prise en compte à toutes les étapes** – depuis la formulation du programme de recherche jusqu'à l'élaboration de lignes directrices, en passant par l'élimination des obstacles à la mise en œuvre et le soutien des activités de plaidoyer – si l'on veut que les services répondent mieux aux besoins de ces populations.
- ▶ **Les déterminants et les facteurs de risque de l'HPP sont bien connus et peuvent être prévenus** grâce à un large éventail d'interventions couvrant les périodes préconceptionnelle, prénatale, intrapartum et postnatale. S'il existe bien de nombreuses interventions connues et efficaces, la mise en œuvre des outils existants se heurte à de nombreux obstacles qui doivent être levés (par exemple, en assurant la présence d'un personnel formé et compétent et en réduisant les dépenses à la charge des patientes).
- ▶ Les solutions aux problèmes posés par l'HPP ne peuvent pas être trouvées de manière isolée, mais s'inscrivent **dans le cadre d'un programme plus large de santé de la mère et du nouveau-né**. D'autres secteurs doivent être impliqués, notamment les transports et le financement.
- ▶ **Une force fédératrice doit être créée autour de l'HPP pour faire progresser le programme de prévention et de prise en charge de l'HPP et mobiliser les fonds nécessaires.**
Les donateurs doivent s'engager à mieux coordonner leurs différents investissements dans ce domaine, par exemple en mettant en place un forum de coordination des donateurs. Certaines initiatives déjà en place, notamment du Plan d'action « Chaque nouveau-né » et de la stratégie Mettre un terme aux décès maternels évitables, pourraient être exploitées.
- ▶ **Un plaidoyer intense doit être mené à tous les niveaux pour rendre l'HPP plus visible,** améliorer sa prise en charge, renforcer la collaboration entre les établissements de santé, promouvoir l'accouchement dans un établissement de santé et faire en sorte que les femmes soient prises en charge au niveau de soins adapté. Cela nécessitera une collaboration efficace entre toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre l'HPP ainsi qu'un leadership politique fort.
- ▶ La communauté internationale doit travailler de manière coordonnée pour **améliorer la disponibilité de produits de qualité pour la prise en charge de l'HPP et rendre ces produits accessibles financièrement** (notamment les médicaments, les dispositifs médicaux et les produits sanguins). De nombreux obstacles à la mise en œuvre des outils existants doivent être levés, mais il s'agit là d'une condition préalable indispensable à l'amélioration de la qualité des soins à tous les niveaux du système de santé.
- ▶ **Un programme de recherche conjoint entièrement financé** doit être élaboré autour des 15 questions de recherche prioritaires qui ont été identifiées lors du Sommet sur l'HPP,

notamment la détermination de l'efficacité d'une approche groupée (c'est-à-dire d'un ensemble d'interventions recommandées) pour la détection et le traitement précoces de l'HPP, l'identification des obstacles à l'utilisation des données probantes (ainsi que l'évaluation des stratégies de mise en œuvre pour lever ces obstacles) et des facteurs qui facilitent leur utilisation, l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité de voies d'administration alternatives de l'acide tranexamique, et l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité de la forme thermostable de carbétocine pour le traitement de l'HPP chez les femmes qui ont déjà reçu ce médicament pour la prévention de l'HPP. Ce programme de recherche doit se concentrer sur les points les plus sensibles dans le continuum des soins, là où le risque de décès ou d'invalidité est le plus élevé. Dans la mesure du possible, les travaux de recherche doivent viser à produire des données quantitatives et qualitatives dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

- **Les concepteurs de lignes directrices mondiales sur l'HPP doivent s'aligner sur un ensemble de recommandations de base** qui devront être cohérentes d'une ligne directrice à l'autre et qui pourront être adaptées dans les lignes directrices des pays et transposées dans des outils pour la pratique clinique (par exemple, des protocoles et des guides pratiques). Une première étape consistera à limiter les redondances dans les activités par le partage des travaux de synthèse de données probantes devant servir de base à la création de nouvelles recommandations sur la lutte contre l'HPP ou à la mise à jour des recommandations existantes.
- **Les mises à jour de lignes directrices doivent combler les lacunes existantes**, notamment en ce qui concerne les recommandations relatives aux facteurs de risque de l'HPP au cours de la période prénatale et pendant l'accouchement [par exemple, la prévention et le traitement de l'anémie, le diagnostic d'une localisation anormale de l'insertion du placenta (placenta prævia) ou d'une adhérence pouvant être à l'origine d'une morbidité (placenta accreta)], la précision des méthodes

de détection de l'HPP (notamment la mesure de la quantité de sang perdue) ainsi que les aspects relatifs aux systèmes de santé, comme l'orientation des patientes et la question des transports et du partage des tâches.

- Pour que la riposte à l'HPP soit efficace et permette d'infléchir la trajectoire des issues défavorables qui en sont la conséquence d'ici à 2030, elle doit pouvoir s'appuyer sur un **système mondial de surveillance efficace et pérenne** (comprenant des indicateurs communs, une collecte systématique des données et une plateforme de mesure commune) pour faire le suivi des avancées obtenues par rapport aux cibles qui ont été fixées. Ce système de surveillance jouera un rôle déterminant dans la fourniture d'outils et de données qui permettront de suivre les progrès accomplis par rapport aux jalons prévus dans la Feuille de route.

Les participants au Sommet sur l'HPP appellent la communauté internationale à prendre acte du consensus dégagé lors de ce Sommet qui reflète une participation large et inclusive de toutes les parties prenantes. Ils appellent tout particulièrement à la mise en œuvre des différentes actions décrites dans le Tableau 4.1.

Tableau 4.1 Actions clés pour que les activités menées en vue d'éliminer les décès évitables dus à l'hémorragie du post-partum (HPP) soient efficaces et coordonnées

Partie prenante	Actions clés
 Communauté internationale	► Identification d'une organisation, d'un consortium ou d'un partenariat responsable de la mise en œuvre d'un programme unifié de lutte contre l'HPP et de l'obtention de financements dans le cadre d'un programme plus large concernant la santé de la mère et du nouveau-né. ► Mise en place d'initiatives coordonnées et harmonisées pour renforcer le plaidoyer et accroître la sensibilisation à l'HPP.
 Femmes et groupes de femmes	► Partage des enseignements tirés des données d'expérience, participation à des campagnes de plaidoyer. ► Participation à la conception de solutions, en particulier destinées aux femmes provenant de milieux à revenu faible. ► Dispositions pour faire en sorte que les accouchements se déroulent dans de bonnes conditions et obtenir une responsabilisation sociale en ce qui concerne les services destinés aux mères et aux nouveau-nés (par exemple, les services de soins prénatals, obstétricaux et postnatals dans des établissements de santé).
 Ministères de la santé	► Renforcement du leadership et de la responsabilisation dans les pays en ce qui concerne l'HPP, avec notamment des objectifs détaillés, un système de surveillance, un financement national et des activités de plaidoyer, et coordination des activités avec les partenaires. ► Attention particulière portée à l'actualisation des lignes directrices nationales, à leur adaptation aux contextes locaux et à leur bonne diffusion. ► Orientation des achats nationaux sur des médicaments et des dispositifs médicaux dont la qualité est garantie, mise à disposition de personnels, de formations et d'équipements appropriés dans les établissements de santé, et amélioration de la fiabilité et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
 Responsables de la mise en œuvre (y compris les ONG et les OSC)	► Élaboration de nouvelles approches pour remédier aux lacunes à combler en priorité. ► Intensification du plaidoyer en faveur de la lutte contre l'HPP en faisant en sorte que les intervenants s'expriment d'une seule voix ou en adoptant une plate-forme commune. ► Formation de coalitions avec les gouvernements et les associations professionnelles afin d'élaborer des plans d'action à mettre en œuvre aux niveaux national et infranational.
 Associations professionnelles	► Promotion du respect des interventions recommandées. ► Soutien à la collaboration, à la diffusion des connaissances et aux activités des communautés de pratique (au sein des pays et au niveau international), en jouant le rôle d'organe de coordination. ► Soutien à un renforcement des capacités des agents de santé réalisé de manière coordonnée, continue et au niveau local, en intégrant des mesures de responsabilisation.

Partie prenante	Actions clés
 Entités qui conçoivent des lignes directrices	► Obtention et maintien dans le temps d'un alignement entre les recommandations relatives à la lutte contre l'HPP par le renforcement de la collaboration entre les entités qui conçoivent des lignes directrices (en commençant par le partage des travaux de synthèse des données probantes et en construisant de manière conjointe l'écosystème des données probantes sur le sujet). ► Unification des recommandations relatives à la lutte contre l'HPP, et mise à jour continue des recommandations existantes ou élaboration de nouvelles recommandations au fur et à mesure de la publication de nouvelles données probantes à fort impact, en examinant l'ensemble des possibilités permettant de modifier le cours de « l'histoire naturelle » de l'HPP. ► Soutien à l'élaboration de lignes directrices nationales sur la lutte contre l'HPP, en conformité avec les recommandations mondiales.
 Communauté des chercheurs	► Mise en œuvre du programme de recherche sur l'HPP et concentration des activités sur les priorités de recherche visant à éliminer les obstacles et les freins à la mise en œuvre, et sur une amélioration de la coordination des travaux de recherche en matière d'innovation. ► Attention particulière portée à la contextualisation des travaux de recherche et à leur orientation en faveur des communautés les moins bien desservies, en impliquant les femmes et les agents de santé de première ligne, notamment les sages-femmes. ► Renforcement de la collaboration internationale entre les chercheurs, l'industrie et les organismes travaillant sur des innovations afin d'obtenir plus rapidement un impact.
 Industrie et organismes travaillant sur des innovations	► Concentration des activités de recherche et de développement concernant la lutte contre l'HPP sur des innovations pertinentes, répondant à une demande et permettant de résoudre des problèmes de santé publique non résolus en renforçant la participation des agents de santé, notamment des sages-femmes. ► Actions pour rendre les produits et les dispositifs médicaux plus abordables et plus accessibles, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, en faisant également en sorte que leur efficacité soit testée. ► Engagement à fournir les données probantes nécessaires pour éclairer les processus d'élaboration des politiques de santé aux niveaux mondial et national.
 Organismes donateurs	► Accroissement des engagements financiers, en orientant les investissements vers les lacunes identifiées comme devant être comblées en priorité (notamment la mise en œuvre et la généralisation de l'utilisation de produits ayant démontré leur efficacité pour le traitement de l'HPP, le renforcement des systèmes de collecte et de distribution du sang et les actions de plaidoyer). ► Renforcement de la coordination entre les donateurs afin d'éviter les redondances dans les activités et de maximiser l'impact obtenu. Création possible d'un consortium permettant d'établir un point de contact unique dans les pays. ► Renforcement de la mobilisation et de l'alignement avec les gouvernements afin de mieux répondre aux besoins locaux et de s'assurer de leur engagement à atteindre les cibles fixées.

Signataires : Participants au Sommet mondial sur l'HPP qui s'est tenu 7 au 10 mars 2023 à Dubaï (Émirats arabes unis)

5. Mise en œuvre de la Feuille de route

Les activités prévues dans la présente Feuille de route sont ambitieuses, ce qui illustre la nécessité urgente d'un changement transformationnel. La réussite de sa mise en œuvre nécessitera que les actions de l'ensemble des parties prenantes aux niveaux international, national et infranational soient menées de manière concertée. Elle nécessitera également que l'engagement de la part des donateurs reste constant, car bon nombre des activités prioritaires décrites dans la Feuille de route dépendent de la disponibilité d'un financement supplémentaire pour leur réalisation.

Dans le cadre du processus d'élaboration de la Feuille de route, différents éléments à prendre en compte pour la mise en œuvre ont été identifiés pour chaque domaine stratégique. On trouvera ci-dessous certains points clés qui peuvent aider les parties prenantes à se préparer à la mise en œuvre.

5.1 Leadership et gouvernance au niveau mondial

La Feuille de route comprend plusieurs facettes et nécessite des actions coordonnées de la part d'un large éventail de parties prenantes au cours des sept prochaines années, voire davantage. Il sera donc essentiel qu'un leadership et une gouvernance solides soient établis.

Au cours de l'élaboration de la Feuille de route, l'OMS a été désignée comme l'organisme responsable de nombreuses étapes à réaliser immédiatement. L'OMS jouera le rôle de catalyseur et pilotera le démarrage de ces activités initiales, mais d'autres organisations devront être identifiées pour conduire les travaux, faire en sorte que des progrès soient accomplis et mobiliser un soutien en faveur des principales actions prioritaires.

Il sera important de mettre en place une structure de gouvernance indiquant clairement quelles seront les parties prenantes qui mèneront les activités dans chacun des quatre domaines stratégiques de la Feuille de route. Les rôles et les responsabilités devront être définis avec plus de précision, tout comme les mécanismes concrets de responsabilisation.

La lutte contre l'HPP est un monde complexe impliquant tout un éventail de parties prenantes également tenues de faire progresser de nombreux programmes autres que celui de la lutte contre l'HPP et qui doivent rendre des comptes à des groupes variés. Le leadership et la gouvernance mis en place dans le cadre de la Feuille de route devront tenir compte de cette réalité.

5.2 Adaptation au contexte local

Pour une adoption réussie de la Feuille de route au niveau des pays, il est important que les processus de traduction et d'adaptation soient correctement planifiés, participatifs et consensuels. Les pays peuvent choisir, par exemple, de définir des versions locales des objectifs mondiaux et des jalons décrits dans la Feuille de route et de les intégrer dans des stratégies nationales et infranationales nouvelles ou existantes en recevant un soutien de la part de l'OMS. Pour ne pas alourdir la charge de travail que représente la préparation des rapports, toute adaptation apportée aux objectifs et aux jalons fixés pour les pays doit être répercutée sur la plateforme de surveillance et d'évaluation.

La Feuille de route définit les principales priorités de recherche à l'échelle mondiale. Cependant, dans certaines situations spécifiques, il peut exister d'autres questions de

recherche plus pressantes (par exemple, la prise en charge de l'HPP dans les situations de conflit et les crises humanitaires). Les organismes nationaux qui financent la recherche peuvent être amenés à adapter la liste des priorités de recherche pour répondre aux besoins locaux. La Feuille de route ne doit pas être considérée comme une liste de sujets de recherche validés à suivre impérativement, mais plutôt comme une vue synthétique des besoins actuels en matière de recherche à l'échelle mondiale.

De la même manière, les directives mondiales fournissent des normes et des critères généraux concernant la prévention et le traitement de l'HPP, sur la base des meilleures données disponibles issues de la recherche, alors que les lignes directrices, les protocoles cliniques et les guides pratiques élaborés au niveau national doivent être adaptés et ajustés au contexte local. L'OMS appuiera les initiatives visant à mettre à jour les normes et les critères nationaux, ainsi qu'à élaborer des protocoles et des guides pratiques adaptés. Les associations professionnelles et les responsables de la mise en œuvre au niveau national joueront un rôle clé dans ce travail et devront participer activement à l'élaboration de ces documents.

Les différentes parties prenantes au niveau local devront identifier les obstacles et les freins à la mise en œuvre à éliminer en priorité dans leur contexte et collaborer pour trouver des solutions efficaces. Les ministères de la santé seront souvent les mieux placés pour réunir les parties prenantes concernées. La structure du leadership et de la gouvernance au niveau mondial prévue par la Feuille de route constitue une option pour l'organisation des activités au niveau local, mais d'autres structures peuvent s'avérer plus adaptées compte tenu des normes et des institutions déjà en place.

Une certaine contextualisation des activités de plaidoyer est déjà prévue dans la Feuille de route avec le développement de cadres de plaidoyer régionaux et locaux. Cependant, ces cadres devront encore être adaptés au contexte national et aux différentes situations rencontrées au sein de chaque pays. Les personnes impliquées dans le plaidoyer devront également convertir ces cadres en messages

concrets qui auront un impact au niveau local et déterminer quelles seront les meilleures méthodes de diffusion. La segmentation du marché et la diffusion de messages ciblés peuvent contribuer à améliorer l'impact des activités de plaidoyer. Les personnes impliquées dans le plaidoyer devront enfin tenir compte de l'influence qu'aura la personne qui portera les messages et choisir le type de communicant et les lieux les plus adaptés pour faire en sorte que l'impact souhaité puisse être atteint.

5.3 Impact attendu de la Feuille de route

Selon les estimations, 70 000 femmes meurent chaque année des suites d'une HPP (1). Si rien ne change, environ 500 000 femmes supplémentaires vont mourir des suites d'une HPP d'ici la fin de la période couverte par les ODD. Toutes ces femmes laisseront derrière elles des familles et des communautés fragilisées par leur absence. En outre, des millions d'autres femmes souffriront des conséquences à long terme d'un accouchement traumatique et pâtiront de l'incapacité de leur système de santé à apporter une réponse efficace. Et il est alarmant de constater que les données de certains pays suggèrent que les taux d'HPP sont en augmentation, ce qui laisse augurer une situation encore plus sombre pour les années à venir.

La Feuille de route propose une vision pour un avenir différent, dans lequel les femmes ne mourront plus des suites d'un problème de santé qu'il est possible de prévenir et de traiter. Dans cette vision du futur, les pays auront adopté des mesures fortes pour lutter en amont contre les déterminants et les facteurs de risque de l'HPP et pour préparer les systèmes de santé à réagir rapidement et efficacement en cas de survenue d'une HPP. Les agents de santé de première ligne seront formés et dotés des compétences suffisantes pour détecter et traiter l'HPP ; ils pourront s'appuyer sur des systèmes d'orientation et de transport fiables qui permettront aux femmes d'accéder rapidement à des soins à un niveau plus élevé. Enfin, les femmes ne mourront plus parce qu'un médicament indispensable est en rupture de

stock ou de mauvaise qualité. Ce futur peut devenir une réalité. Et cette Feuille de route nous montre comment y parvenir.

Cette feuille de route ne permettra pas d'éliminer complètement l'HPP ; aucun plan ne peut y parvenir. Néanmoins, la mise en œuvre en temps opportun d'actions coordonnées dans chacun des domaines stratégiques définis dans cette Feuille de route peut contribuer à atténuer la charge de la mortalité et de la morbidité maternelles ainsi que l'impact de l'HPP sur la santé et le bien-être des femmes. Les femmes et les familles qui comptent actuellement parmi les plus marginalisées dans le monde seront les premières à bénéficier de sa mise en œuvre, ce qui aura des retombées importantes sur le développement et l'autonomisation de l'ensemble de la communauté.

6. Diffusion de la Feuille de route et l'appel à l'action

Afin d'obtenir un premier retour, les principaux objectifs et les jalons fixés dans cette Feuille de route ont été présentés lors de la Conférence internationale sur la santé de la mère et du nouveau-né qui s'est tenue du 8 au 11 mars 2023 au Cap (Afrique du Sud). Après sa publication, la Feuille de route (le présent document) sera diffusée lors de conférences et de webinaires organisés par l'OMS et d'autres parties prenantes, notamment les participants au Sommet sur l'HPP.

L'OMS élaborera également des outils pour faciliter l'adaptation de la Feuille de route aux contextes locaux, notamment un recueil de données factuelles sur sa mise en œuvre dans les régions et les pays les plus touchés. La Feuille de route et les outils connexes seront diffusés par les bureaux régionaux et nationaux de l'OMS, les ministères de la santé, des organisations professionnelles, des centres collaborateurs de l'OMS, d'autres organismes des Nations Unies, des OSC et des ONG. Elle sera publiée sur le site Web de l'OMS/HRP et son lancement sera annoncé dans le bulletin d'information WHO/HRP News qui paraît tous les mois. Ce bulletin d'information compte actuellement plus de 8000 abonnés, parmi lesquels des cliniciens, des responsables de programmes, des responsables de l'élaboration de politiques ainsi que des utilisateurs de services de santé du monde entier. Les documents de l'OMS sont également régulièrement diffusés lors de réunions et de conférences scientifiques auxquelles participe le personnel de l'OMS travaillant dans le secteur de la santé de la mère et du nouveau-né.

La Feuille de route sera traduite dans les six langues des Nations unies afin d'être diffusée via les bureaux régionaux et nationaux de l'OMS et lors de réunions qui seront organisées par

le personnel de l'OMS ou auxquelles celui-ci participera. Les bureaux régionaux de l'OMS qui souhaitent en traduire l'intégralité dans l'une de ces langues pourront bénéficier d'une assistance technique. En outre, des articles présentant chacun des domaines stratégiques (notamment l'élaboration et l'identification des priorités) ainsi que les principaux éléments à prendre en considération pour la mise en œuvre seront préparés en vue de leur publication dans des revues évaluées par des pairs, en respectant les politiques de l'OMS en matière d'accès libre et de droits d'auteur. Les groupes et les départements pertinents de l'OMS, ainsi que les partenariats, comme le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, participeront également au processus de diffusion.

Pour que la Feuille de route ait un impact sur la santé maternelle au niveau des pays, il sera essentiel que les agences internationales, les ministères de la santé et les principales parties prenantes de la santé maternelle et périnatale agissent de manière coordonnée. Le personnel de l'OMS au niveau du Siège ou des bureaux régionaux et nationaux ainsi que les agences internationales partenaires et les sociétés professionnelles internationales (par exemple FIGO, l'ICM et les associations professionnelles nationales) pourront aider les parties prenantes concernées aux niveaux nationaux à élaborer des lignes directrices ou des protocoles nationaux ou à réviser ceux qui existent et à optimiser leur mise en œuvre en fonction de la Feuille de route. En plus des outils standard, il pourra s'avérer nécessaire de disposer d'outils et d'ensembles d'outils adaptés au contexte afin d'aider les parties prenantes à mettre en œuvre les recommandations de la Feuille de route dans le contexte des crises humanitaires.

7. Suivi et évaluation de l'impact

En 2015, l'initiative multipartite mondiale Ending Preventable Maternal Mortality, qui a pour buts d'améliorer la santé et le bien-être des mères et de favoriser l'atteinte de la cible 3.1 de l'ODD, à savoir à ce que le taux de mortalité maternelle au niveau mondial soit inférieur à 70, a défini différentes stratégies générales destinées aux programmes de santé maternelle (22). Dans son cadre de suivi, cette initiative a fixé des objectifs de couverture ainsi que des jalons pour suivre les avancées obtenues d'ici à 2030. Les objectifs et les jalons définis dans ce cadre sont alignés sur ceux du Plan d'action « Chaque nouveau-né » lancé en septembre 2020. La Feuille de route présentée dans ce document vient en complément de ces initiatives en mettant l'accent sur les activités liées à la lutte contre l'HPP, cette pathologie constituant le facteur qui contribue le plus à la mortalité maternelle.

Cette Feuille de route pour lutter contre l'HPP expose un programme ambitieux visant à intensifier les actions menées dans ce domaine. Pour maintenir la dynamique, il sera essentiel de définir un ensemble d'indicateurs de base et de mettre en place un système mondial et global de surveillance permettant de suivre les avancées obtenues et d'évaluer l'impact des mesures qui auront été mises en œuvre.

L'élaboration d'un ensemble d'indicateurs de base est une opportunité que les professionnels du suivi et de l'évaluation doivent saisir. Ces indicateurs devront être à la fois suffisamment

précis pour permettre de suivre les avancées obtenues et suffisamment généraux pour que soient utilisés les systèmes de collecte de données existants et éviter ainsi d'alourdir la charge de travail liée à la surveillance et à la production de rapports. En outre, ils doivent être communs à tous les pays et constants dans le temps pour permettre une cohérence dans la surveillance et les comparaisons.

La mise en place d'un système mondial de surveillance ne sera pas une chose facile, notamment parce qu'il n'existe que peu d'indicateurs universels en rapport avec l'HPP. Il sera probablement utile de s'appuyer sur des données récentes concernant la validité et la faisabilité des indicateurs inclus dans le cadre de suivi de l'initiative Ending Preventable Maternal Mortality (23, 24). Compte tenu des difficultés et des opportunités qui viennent d'être évoquées, la mise en place d'un ensemble d'indicateurs de base et d'une plateforme de mesure commune constituera une étape clé dès le début de la mise en route de la Feuille de route. Dans l'immédiat, l'OMS, FIGO, l'ICM ainsi que les ministères de la santé et les sociétés professionnelles dans les pays devront se réunir pour examiner et évaluer les indicateurs susceptibles d'être intégrés dans une plateforme de mesure commune permettant de suivre l'évolution des pratiques, des résultats en matière de santé et des inégalités. Ces actions initiales devront dès le départ comprendre des plans clairs visant à assurer la pérennité du système.

8. Planification des futures mises à jour

Un examen de la Feuille de route et de sa mise en œuvre sera effectué à mi-parcours en 2026 ou en 2027. Il sera alors peut-être nécessaire de la mettre à jour pour tenir compte de l'engagement des différentes parties prenantes et préciser les principales activités à mener ainsi que les jalons clés à atteindre d'ici à 2030.

9. Références bibliographiques

1. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunçalp Ö, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *Lancet Glob Heal*, 2014; 2(6): 323–33. [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(14\)70227-x](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(14)70227-x)
2. GBD 2015 Maternal Mortality Collaborators. Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet*, 2016;388(10053): 1775–812. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(16\)31470-2](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31470-2)
3. Gyamfi-Bannerman C, Srinivas SK, Wright JD, Goffman D, Siddiq Z, D’Alton ME, et al. Postpartum hemorrhage outcomes and race. *Am J Obstet Gynecol*, 2018;219: 185.e1-185.e10. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.04.052>
4. Choe SA, Min HS, Cho SI. The income-based disparities in preeclampsia and postpartum hemorrhage: a study of the Korean National Health Insurance cohort data from 2002 to 2013. *Springerplus*, 2016 Jun 27; 5(1): 895. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-2620-8>
5. United Nations Maternal Mortality Estimation Inter-agency Group. Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. Geneva, World Health Organization, 2023 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/366225>).
6. Target product profiles. In: Global Observatory on Health R&D [website]. Geneva, World Health Organization, 2023 (<https://www.who.int/observatories/global-observatory-on-health-research-and-development/analyses-and-syntheses/target-product-profile/who-target-product-profiles>).
7. Dolley S, Hartman D, Norman T, Hudson I. DAC target policy profile (TPoP). In: DAC Trials [website]. The Global Health Network, 2021. (<https://dac-trials.tghn.org/resources/target-policy-profile-overview/tpop-doi-landing-page/>).
8. World Health Organization. WHO recommendation on umbilical vein injection of oxytocin for the treatment of retained placenta. Geneva: World Health Organization; 2020. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/336309>).
9. World Health Organization. WHO recommendation on routes of oxytocin administration for the prevention of postpartum haemorrhage after vaginal birth. Geneva, World Health Organization, 2020. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/336308>).
10. World Health Organization. WHO recommendation on advance misoprostol distribution to pregnant women for prevention of postpartum haemorrhage. Geneva, World Health Organization, 2020. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/336310>).
11. World Health Organization. WHO recommendations: Uterotonics for the prevention of postpartum haemorrhage. Geneva, World Health Organization, 2018. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/277276>).

12. World Health Organization. WHO recommendation on uterine balloon tamponade for the treatment of postpartum haemorrhage. Geneva, World Health Organization, 2021. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/340796>).
13. Organisation mondiale de la Santé. Recommandations de l'OMS pour la prévention et le traitement de l'hémorragie du post-partum. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. (<https://iris.who.int/handle/10665/141487>).
14. World Health Organization. WHO recommendation on tranexamic acid for the treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2017. (<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259379/WHO-RHR-17.21-eng.pdf>).
15. Web annex A. World Health Organization model list of essential medicines: 23rd list, 2023. In: The selection and use of essential medicines 2023: Executive summary of the report of the 24th WHO Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines, 24 – 28 April 2023. Geneva, World Health Organization, 2023 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/371090>).
16. Approche systématique pour la réalisation d'un exercice de définition des priorités en matière de recherche: orientations pour le personnel de l'OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/342028>).
17. Souza JP, Widmer M, Gülmezoglu AM, Lawrie TA, Adejuyigbe EA, Carroli G, et al. Maternal and perinatal health research priorities beyond 2015: an international survey and prioritization exercise. *Reprod Health*, 2014; 11(1): 61. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-11-61>
18. Rudan I, Gibson JL, Ameratunga S, El Arifeen S, Bhutta ZA, Black M, et al. Setting priorities in global child health research investments: guidelines for implementation of CHNRI method. *Croat Med J*, 2008; 49(6): 720–33. <https://doi.org/10.3325/cmj.2008.49.720>
19. Rudan I. Setting health research priorities using the CHNRI method: IV. Key conceptual advances. *J Glob Health*, 2016; 6(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.06.010501>
20. World Health Organization, United Nations Population Fund, United Nations Children's Fund (UNICEF). Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors, second edition. Geneva, World Health Organization, 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/255760>).
21. Compétences essentielles pour la pratique du métier de sage-femme : édition 2019. International Confederation of Midwives, 2019 (<https://internationalmidwives.org/fr/resources/les-competences-essentielles-pour-la-pratique-du-metier-de-sage-femme/>).
22. Chou D, Daelmans B, Jolivet RR, Kinney M, Say L; Every Newborn Action Plan (ENAP) and Ending Preventable Maternal Mortality (EPMM) working groups. Ending preventable maternal and newborn mortality and stillbirths. *BMJ*, 2015; 351: h4255. <https://doi.org/10.1136/bmj.h4255>
23. Jolivet RR, Gausman J, Adanu R, Bando D, Belizan M, Berrueta M, et al. Multisite, mixed methods study to validate 10 maternal health system and policy indicators in Argentina, Ghana and India: a research protocol. *BMJ Open*, 2022; 12(1): 1–13. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049685>
24. Jolivet RR, Gausman J, Langer A. Recommendations for refining key maternal health policy and finance indicators to strengthen a framework for monitoring the Strategies toward Ending Preventable Maternal Mortality (EPMM). *J Glob Heal*, 2021; 11: 02004. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.02004>

Annexe 1.

Liste des personnes ayant contribué à la rédaction du document

Participants at the Global PPH Summit

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Membres du Comité d'orientation	
Sabaratnam Arulkumaran St. George's, University of London Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	A donné des conférences en Inde dans le cadre de symposiums sur les « Avancées dans la prévention de l'HPP » financés par Abbott India. A reçu un soutien financier pour des déplacements ainsi que des honoraires de Ferring Pharmaceuticals (4000 livres sterling).
Jolly Beyeza-Kashesya Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) Royaume-Uni ; Mulago Specialised Women and Neonatal Hospital Ouganda	Aucun.
Michel Brun Fonds des Nations Unies pour la population États-Unis d'Amérique (USA)	Aucun.
Rizwana Chaudhri Shifa Tameer-e-Millat University Pakistan	Investigateur principal chargé de la coordination du projet de recherche international collaboratif LSHTM – WOMAN-2 trial (utilisation de l'acide tranexamique pour réduire les hémorragies du post-partum chez les femmes souffrant d'anémie : un essai international randomisé contre placebo en double aveugle).
Susan Fawcus University of Cape Town Afrique du Sud	Aucun.
Hadiza Galadanci (coprésidente) * Bayero University Nigéria	Aucun.
Caroline Homer * Burnet Institute Australie	Aucun.
Pete Lambert Monash University Australie	A reçu un soutien à la recherche de Johnson & Johnson pour un programme portant sur l'administration d'ocytocine par inhalation.
Cammie Lee Results for Development (R4D) USA	A reçu des financements de la Fondation Bill & Melinda Gates et de USAID.
Elliott Main Stanford University School of Medicine USA	A travaillé en tant que consultant pour réviser et piloter la mise en œuvre nationale des ensembles de mesures relatives à la sécurité qui incluaient des mesures concernant les hémorragies obstétricales.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Membres du Comité d'orientation	
Suellen Miller (coprésidente) University of California, San Francisco USA	L'institution est titulaire de la marque déposée « Lifewrap », une tenue non pneumatique à enfiler pour prévenir ou limiter les chocs. Il est possible que les délibérations au cours du Sommet sur l'HPP et les recommandations qui en découlent aient une incidence sur les redevances que l'institution percevra pour l'utilisation de cette marque.
Alison Morgan (excusée) Global Financing Facility USA	A reçu un financement de Saving Lives at Birth. Au cours d'un emploi antérieur à l'Université de Melbourne (Australie), a reçu un financement de 150 000 dollars des États-Unis (USD) pour la réalisation d'une analyse économique de l'administration d'ocytocine par inhalation.
Richard Mugahi Ministry of Health Uganda	Aucun.
Angela Nguku White Ribbon Alliance Kenya Kenya	Aucun.
Hrshikesh Pai Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India Inde	Aucun.
Daisy Ruto Jhpiego, Smiles for Mothers Project Kenya	Aucun.
Patricia Titulaer International Confederation of Midwives (ICM) Netherlands; Lancet Global Health Royaume des Pays-Bas	Aucun.
Pauline Williams Consultante indépendante en médecine pharmaceutique Royaume-Uni	Employée par le passé par GlaxoSmithKline (GSK). Durant cette période, elle a dirigé, entre 2013 et 2019, un groupe de recherche qui collaborait avec Monash University pour mettre au point une formulation d'ocytocine à administrer par inhalation, et était responsable des études de faisabilité clinique et des interactions avec l'organisme United Kingdom Regulatory Authority (MHRA) concernant les demandes d'autorisation pour les essais cliniques. Pour permettre à Monash University de poursuivre sa collaboration avec le laboratoire Janssen, GSK a mis fin à son accord avec cette université et lui a restitué tous ses droits de propriété intellectuelle en 2019. A quitté GSK en décembre 2021. GSK n'a actuellement aucun projet en rapport avec l'HPP.
Membres du comité scientifique	
Edgardo Abalos Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) Argentine	Aucun.
Lester Chiner Concept Foundation Suisse	A reçu des financements de Ferring Pharmaceuticals, Obstetrix et MSD for Mothers.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Membres du Comité d'orientation	
Arri Coomarasamy University of Birmingham Royaume-Uni	Aucun.
Adam Devall University of Birmingham Royaume-Uni	Aucun.
Virginie Diaz Centro Rosarino de Estudios Perinatales Argentine	Aucun.
A. Metin Gülmezoglu Concept Foundation Suisse	A reçu des financements de Ferring Pharmaceuticals, Obstetrix, MSD for Mothers, et travaille comme consultant pour Ferring Pharmaceuticals.
Dilys Walker University of California, San Francisco USA	A reçu un soutien financier de Ferring Pharmaceuticals pour un déplacement.
Autres participants au Sommet mondial sur l'HPP	
Adeniyi Aderoba * Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique Congo	Aucun.
Guer van Adnet Boston Consulting Group France	Aucun.
Wang Ai-Ling Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine Chine	Aucun.
Jennifer Akuamoah-Boateng Fondation Bill & Melinda Gates USA	Employée de la Fondation Bill & Melinda Gates.
Hadil Y. M. Ali Ministère de la santé Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est	Aucun.
Christine Al Kady Médecins Sans Frontières (MSF). Liban	Aucun.
Pascale Allotey Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Ishraq Al-Subaee Ministry of Public Health and Population Yémen	Aucun.
Fernando Althabe Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Fadhlun Alwy Al-Beity Muhimbili University of Health and Allied Sciences République-Unie de Tanzanie	Aucun.
Denitza Andjelic UNITAID Suisse	Aucun.
Deborah Armbruster Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) USA	Aucun.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Membres du Comité d'orientation	
Bouchra Assarag Ministère de la santé Maroc	Aucun.
Rachid Bezad Université Mohammed V de Rabat Maroc	Aucun.
Anderson Borovac-Pinheiro University of Campinas, CAISM-UNICAMP Brésil	Aucun.
Magda Botha Sinapi Biomedical Afrique du Sud	Employée de Sinapi.
Autres participants au Sommet mondial sur l'HPP	
Amanda Cafaro Fondation Bill & Melinda Gates USA	Employée de la Fondation Bill & Melinda Gates.
Patricia Carney Organon USA	Employée d'Organon.
Sarah Chamberlain Boston Consulting Group USA	Aucun.
Robyn Churchill USAID USA	Aucun.
Jeanne Conry FIGO Royaume-Uni ; Environmental Health Leadership Foundation USA	Aucun.
Edwina Conteh ICM Regional Office, Africa; Kingharman Maternal and Child Hospital Sierra Leone	Aucun.
Yoswa Dambisya East, Central and Southern Africa Health Community United Republic of Tanzania	Aucun.
Blami Dao Jhpiego Burkina Faso	Aucun.
Rodolfo de Carvalho Pacagnella Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP Brésil	Conseiller auprès d'Organon
Catherine Deneux-Tharoux Institut national de la santé et de la recherche médicale France	Aucun.
Chris de Villiers Sinapi Biomedical Afrique du Sud	Actionnaire de Sinapi Biomedical.
Farhana Dewan Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh Bangladesh ; IBN SINA Medical College Bangladesh	A occupé le poste de coordonnatrice nationale adjointe du PPH Bundle Project à partir de 2020. Ce projet a été mis en place par le Massachusetts General Hospital de l'université de Harvard.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Autres participants au Sommet mondial sur l'HPP	
Louis-Victor Dorat Boston Consulting Group France	Aucun.
Tim Draycott Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Royaume-Uni ; North Bristol NHS Trust Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	Intervenant rémunéré par Ferring Pharmaceuticals et Abbott. Consultant pour Organon et Limbs & Things.
Kamo Dumo Angau Hospital Papouasie-Nouvelle-Guinée	Aucun.
Nasser El Kholy Ain Shams University Hospitals Égypte	Aucun.
Dalya Eltayeb Federal Ministry of Health of Sudan Soudan	Aucun.
Maria Fernanda Escobar Vidarte Fundación Valle del Lili Colombie	Aucun.
Mary-Ann Etiebet MSD for Mothers USA	Employee of MSD.
Nousheen Farooq Ministry of National Health Services Regulations and Coordination Pakistan	Aucun.
Hani Fawzi FIGO Royaume-Uni	Employé de MSD.
Mario Festin College of Medicine, University of the Philippines Philippines	Aucun.
Ahmed Galal Alexandria University Egypt Égypte	Aucun.
Ioannis Gallos Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
tenesh Gebreyohannes Hailu Ministère de la santé Éthiopie	Aucun.
Karima Gholbzouri Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale Égypte	Aucun.
Shivaprasad Goudar KLE Academy of Higher Education and Research Inde	Aucun.
Dale Halliday UNITAID Suisse	Aucun.
Noha Hosny Hassanein Organon Égypte	Aucun.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Autres participants au Sommet mondial sur l'HPP	
Grethe Heitmann Ex AC Norvège	Fondatrice d'Ex AC.
Hoang Thi Diem Tuyet Association vietnamienne de gynécologie et d'obstétrique Viet Nam ; Hôpital Hung Vuong Viet Nam	Aucun.
Justus Hofmeyr University of the Witwatersrand Afrique du Sud	Conseiller technique auprès d'Equalize Health (a reçu entre 750 et 1000 USD par mois pendant 2 ans ; a cessé cette activité fin 2022 lorsque Equalize Health a fermé). Propriété intellectuelle antérieure liée à celle du Maternawell Tray transférée à Equalize Health (sans frais ; a cessé en 2021). La propriété intellectuelle peut être transférée à une autre société après la fermeture d'Equalize Health. Collaboration avec des collègues d'Umoya Health pour mettre au point un Maternawell tray. N'a pas reçu de revenu à ce jour, mais pourrait à l'avenir percevoir des revenus au titre de ce projet.
Iffath Hoskins American College of Obstetricians and Gynecologists USA ; Centre médical Montefiore et Collège de médecine Albert Einstein USA	Aucun.
Jeffrey Jacobs MSD for Mothers USA	Employé de MSD.
Farzee Johnson Ministère de la santé Libéria	Aucun.
Jill Jones Medical Research Council, UK Research and Innovation (UKRI) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	Employée du Medical Research Council, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Chandani Jayathilaka Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est Inde	Aucun.
Aparna Kamath Grand Challenges Canada Canada	Aucun.
Nihfadh Issa Kassim Ministry of Health Zanzibar République-Unie de Tanzanie	Aucun.
Anne Beatrice Kihara FIGO Royaume-Uni ; University of Nairobi Kenya	Aucun.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Autres participants au Sommet mondial sur l'HPP	
Ashok Kumar Indian College of Obstetricians and Gynaecologists Inde ; Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences Inde	Aucun.
Song Li Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine Chine	Aucun.
Pisake Lumbiganon The Asia & Oceania Federation of Obstetrics & Gynaecology; Faculty of Medicine, Khon Kaen University Thaïlande	Aucun.
Russ Mably Medtrade Products Ltd Royaume-Uni	Directeur et actionnaire de Medtrade.
Aseema Mahunta Behra Centre for Catalyzing Change White Ribbon Alliance Kenya Inde	Aucun.
Sadia Malik Khalifa University Émirats arabes unis	Aucun.
Sheela Mane Anugraha Nursing Home Inde	Aucun.
Hadeel Masri Ministère de la santé Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est	Aucun.
Elhadji Thierno Mbengue Ministère de la Santé et de l'Action Sociale Sénégal	Aucun.
Michelle McIntosh Monash University Australie	A reçu un soutien à la recherche de Johnson & Johnson pour un programme portant sur l'administration d'ocytocine par inhalation et détient un brevet pour la méthode d'inhalation et la formulation pour cette voie d'administration.
Allisyn Moran Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Hadijah Nakatudde ICM Regional Office, Africa ; International Institute of Health Sciences Ouganda	Consultante pour Ferring Pharmaceuticals.
Joyce Nganga WACI Santé Kenya	Aucun.
Norbert-Richard Ngbale Ministère de la santé et de la population République centrafricaine	Aucun.
David Ntirushwa Centre Hospitalier Universitaire de Kigali Rwanda	Aucun.
Pius Okong Health Service Commission Ouganda	Aucun.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Autres participants au Sommet mondial sur l'HPP	
Olufemi Oladapo Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Sam Ononge Makerere University Ouganda	Aucun.
Lawal Oyeneyin (excusé) UNIMED Teaching Hospital Nigéria	Collaborateur de recherche pour Africa Center of Excellence Population, Health & Policy, Bayero University, Kano (Nigéria) pour l'étude Early detection of PPH and treatment using the WHO first response bundle (E-MOTIVE Trial). A reçu des indemnités de fonctionnement pour la recherche d'environ 100 USD par mois, dont le versement a pris fin en janvier 2023.
Samuel Oyeniyi * Federal Ministry of Health Nigéria	Aucun.
Paul Oyere Moke Ministère de la santé Congo	Aucun.
Alongkone Phengsavanh Lao Association of Obstetrics and Gynecology République démocratique populaire lao ; Faculty of Medicine, University of Health Sciences République démocratique populaire lao	Aucun.
Henry Phiri Ministère de la santé Malawi	Aucun.
Anupama Prasad Ministry of Health and Family Welfare Inde	Aucun.
Zahida Qureshi University of Nairobi Kenya	Aucun.
Fifa Rahman Ministry of Health and Family Welfare Bangladesh	Aucun.
Neena Raina Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est Inde	Aucun.
May Raouf Dubai Health Authority Émirats arabes unis	Aucun.
Ian Roberts London School of Hygiene and Tropical Medicine Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.	A reçu des financements de la Fondation Bill & Melinda Gates, de Wellcome Trust, du UK Government of Health, du Medical Research Council, d'Unitaid au LSHTM (environ 10 à 20 millions d'USD).
Maria Rodriguez Center for Reproductive Health Equity Oregon Health & Science University USA	A reçu un financement d'Obstetrx.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Autres participants au Sommet mondial sur l'HPP	
Mariam Roumane Brahim Ministère de la Santé et de la Solidarité nationale Tchad	Aucun.
Sara Rushwan Concept Foundation Suisse	Employée de Concept Foundation. Concept Foundation reçoit un financement de Ferring Pharmaceuticals pour l'aider à déposer des demandes d'enregistrement de la forme thermostable de carbétocine dans les différents pays.
Habib Sadauki (excusé) Society of Gynaecology and Obstetrics of Nigeria Nigéria	Aucun.
Noha Salem Organon USA	Aucun.
Amy Schellpfeffer Fondation Bill & Melinda Gates USA	Aucun.
Elaine Scudder International Rescue Committee USA	Aucun.
Anders Seim Health and Development International Norvège	Fondateur et directeur exécutif de l'ONG Health and Development International (HDI). HDI a reçu des financements de la part d'organisations non commerciales et de personnes n'ayant aucun intérêt commercial dans le domaine de la santé maternelle.
Edouard Serem Ministère de la santé Kenya	Aucun.
Suzanne Serruya Bureau régional de l'OMS pour les Amériques/Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) Uruguay	Aucun.
Vishal Shah Ferring Pharmaceuticals Inde	Aucun.
Lumaan Sheikh Aga Khan University Pakistan	Aucun.
Katharine Shelley PATH USA	A reçu des financements de la Fondation Bill & Melinda Gates.
Jeffrey Smith Fondation Bill & Melinda Gates USA	Employé de la Fondation Bill et Melinda Gates.
Martyn Smith Reproductive Health Supplies Coalition USA	Aucun.
Rachel Smith Burnet Institute Australie	Aucun.

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Autres participants au Sommet mondial sur l'HPP	
Phineas Sospeter Ministère de la santé République-Unie de Tanzanie	Aucun.
João Paulo Souza Bureau régional de l'OMS pour les Amériques/Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) Brésil	Aucun.
Hema Srinivasan Medaccess Royaume-Uni	Aucun.
Andrew Storey Clinton Health Access Initiative USA	Aucun.
Andrew Sutcliffe Medtrade Products Ltd Royaume-Uni	Employé et actionnaire de Medtrade.
Uzma Syed Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Catharine Taylor MSD for Mothers USA	Consultante pour MSD.
Trude Thommesen ICM Royaume des Pays-Bas ; Harvard University Norvège	Aucun.
Bhavin Vaid Ferring Pharmaceuticals Suisse	Employé de Ferring Pharmaceuticals.
John Varallo Jhpiego USA	Aucun.
Peter Waiswa Makerere University School of Public Health Ouganda	Aucun.
Andrew Weeks University of Liverpool. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	Détient le brevet pour le dispositif PPH Butterfly.
Mariana Widmer Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Caitlin R. Williams Institute for Clinical Effectiveness and Health Policy (IECS-Argentina) Argentine	Aucun.

* Participation virtuelle

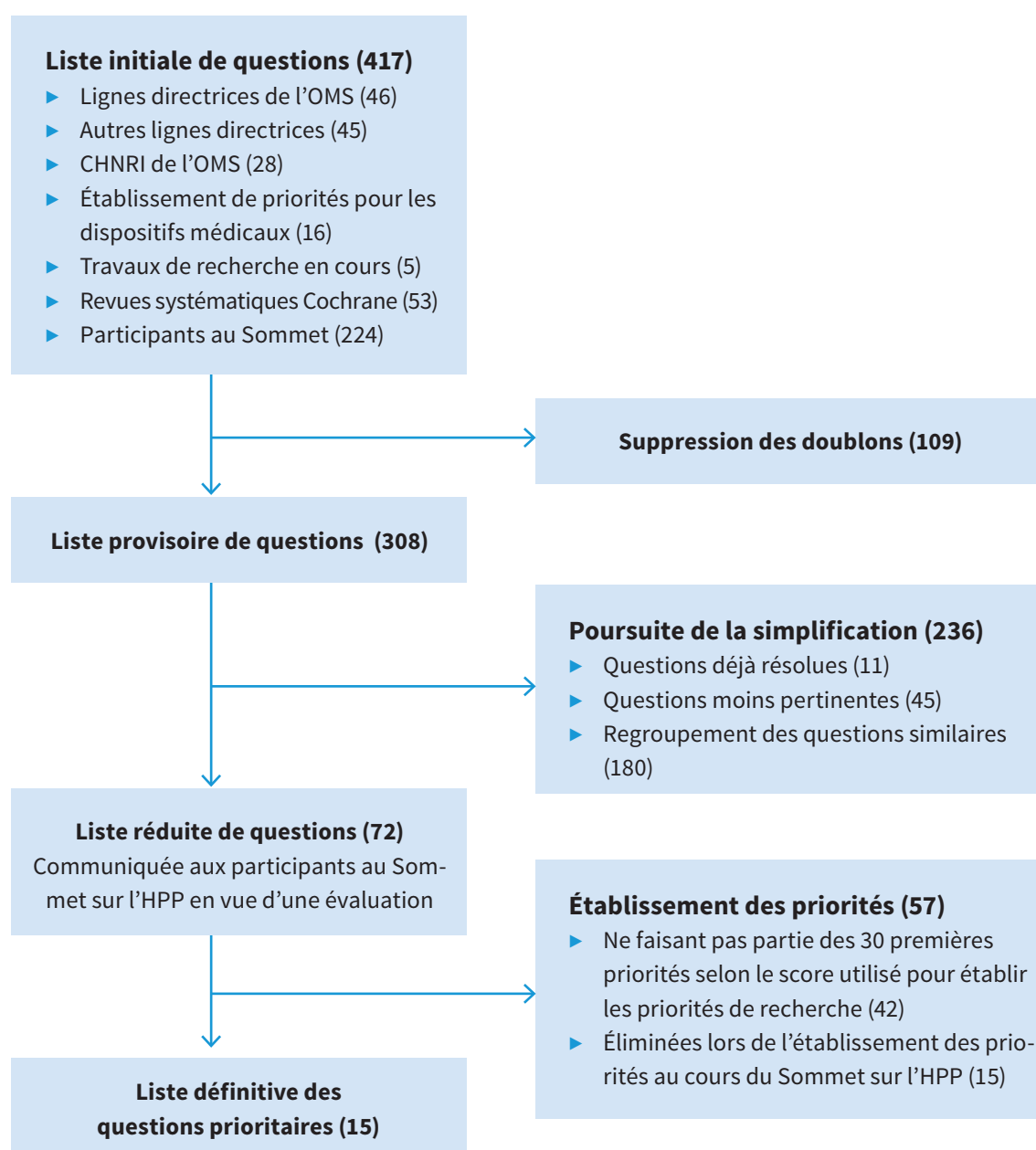
Autres contributeurs

Sylvia Alford USAID USA	Aucun.
-------------------------------	--------

Participant	Intérêt(s) déclaré(s)
Natalie Maurer Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Johanna Benesty Boston Consulting Group France	Aucun.
Mónica Chamillard Centro Rosarino de Estudios Perinatales Argentine	Aucun.
Cherrie Evans Jhpiego USA	A reçu un financement d'UNITAID.
Ryan Fitzgerald Exemplars in Global Health USA	Aucun.
Angelica Flores Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Celina Gialdini Centro Rosarino de Estudios Perinatales Argentine	Aucun.
Victoria Holdsworth Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Sachiyo Yoshida Organisation mondiale de la Santé Suisse	Aucun.
Raphaëlle Kemoun Boston Consulting Group France	Aucun.
Gloria Ikilezi Exemplars in Global Health USA	Aucun.
Julia Pasquale Centro Rosarino de Estudios Perinatales Argentine	Aucun.
Jenny Ramson Ampersand Health Science Writing Pty Ltd Australie	Aucun.
Hachani Rim Boston Consulting Group France	Aucun.
Sara Rushwan Concept Foundation Switzerland	Aucun.
Asher Steene Boston Consulting Group Royaume-Uni	Aucun.
Jordan-Tate Thomas Exemplars in Global Health USA	Aucun.
Hayfaa Wahhabite Université du Roi Saoud Royaume d'Arabie saoudite	Aucun.

Annex 2.

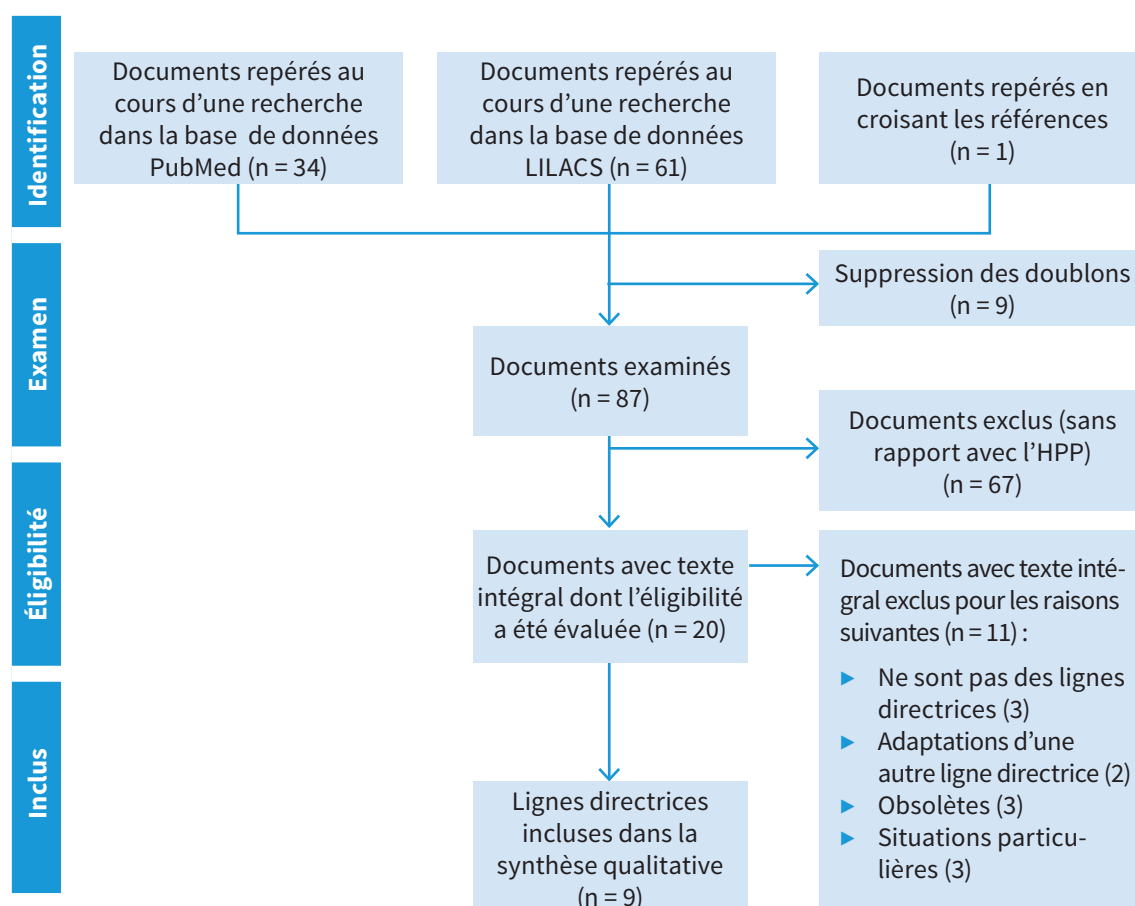
Organigramme de l'établissement des priorités en matière de recherche sur l'hémorragie du post-partum



CHNRI: Child Health and Nutrition Research Initiative ; HPP : hémorragie du post-partum.

Annex 3.

Identification des lignes directrices déjà publiées pour aider à l'élaboration d'une cartographie des recommandations relatives à l'hémorragie du post-partum



LILACS : Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Littérature des sciences de la santé en Amérique latine et dans les Caraïbes)

Annex 4. Carte thermique des résultats de l'enquête sur les obstacles à la mise en œuvre

Échelle du score | Faible <45% <65% <75% <85% +85% Élevé

		Inclusion dans les lignes directrices nationales	Présentes agissant en tant que champions	Registration and licence	Inclusion in national EMLs or equivalents?	Availability / Procurement	Job aids available at facility level	Healthcare workers awareness & trust in effectiveness	Affordability & quality	Training & experience of healthcare workers	Healthcare facilities staffing & equipment
Q01	Injection d'ocytocine pour la prévention et le traitement de l'HPP	89%	83%	91%	90%	72%	79%	88%	73%	82%	68%
Q02	Injection d'ergométrine pour la prévention et le traitement de l'HPP (si l'ocytocine n'est pas disponible)	63%	56%	67%	63%	44%	52%	59%	52%	55%	48%
Q03	Injection d'une combinaison en dose fixe d'ocytocine et d'ergométrine pour la prévention et le traitement de l'HPP (si l'ocytocine n'est pas disponible)	55%	52%	57%	56%	40%	48%	52%	45%	50%	44%
Q04	Injection de carbétocine thermostable pour la prévention de l'HPP (si l'ocytocine n'est pas disponible ou si sa qualité ne peut être garantie)	46%	49%	50%	47%	34%	39%	45%	43%	40%	38%
Q05	Misoprostol par voie orale pour la prévention et le traitement de l'HPP (si l'ocytocine n'est pas disponible ou n'a pas permis d'arrêter le saignement)	84%	80%	81%	82%	74%	77%	81%	77%	78%	72%
Q06	Cristalloïdes isotoniques pour le remplissage vasculaire chez les femmes qui présentent une HPP	84%	81%	83%	82%	75%	77%	82%	79%	79%	73%
Q07	Injection d'acide tranexamique et prise en charge standard pour le traitement de l'HPP	79%	79%	80%	78%	70%	72%	75%	75%	71%	71%
Q08	Ocytocine en combinaison avec traction contrôlée du cordon en cas de rétention placentaire	85%	82%	85%	85%	78%	78%	82%	78%	78%	73%
Q09	Tamponnade à l'aide d'un ballonnet intra-utérin pour le traitement de l'HPP réfractaire	62%	62%	60%	58%	49%	52%	57%	52%	49%	46%

Q10	Tenue non pneumatique à enfiler pour prévenir ou limiter les chocs comme mesure de temporisation pour une prise en charge définitive de l'HPP	55%	54%	54%	52%	39%	44%	48%	44%	42%	41%
Q11	Embolisation de l'artère utérine pour le traitement de l'HPP réfractaire	56%	52%				44%	52%		39%	38%
Q12	Compression utérine bimanuelle comme mesure de temporisation avant une prise en charge définitive de l'HPP	75%	72%				69%	71%		66%	62%
Q13	Compression externe de l'aorte comme mesure de temporisation pour une prise en charge définitive de l'HPP	61%	57%				52%	54%		47%	49%
Q14	Interventions chirurgicales (laparotomie, ou sutures compressives, ou hystérectomie) pour le traitement de l'HPP réfractaire	76%	74%				68%	75%		61%	57%
Q15	La surveillance de la tonicité utérine dans le post-partum pour l'identification précoce de l'atonie utérine est recommandée pour toutes les femmes.	80%	78%				76%	78%		77%	72%
Q16	La traction contrôlée du cordon est la méthode recommandée pour l'évacuation du placenta lors d'une césarienne	74%	75%				73%	75%		74%	70%
Q17	Massage utérin pour un traitement conservateur en cas d'HPP	87%	86%				84%	86%		85%	79%
Q18	Protocoles explicites dans les établissements de santé pour la prévention et le traitement de l'HPP	80%	79%				76%	79%		75%	69%
Q19	Protocoles explicites pour l'orientation des femmes vers un niveau de soins plus élevé pour le traitement de l'HPP	79 %	78%				73%	79%		73%	67%
Q20	Simulations du traitement de l'HPP pour les programmes de formation initiale et de formation en cours d'emploi	69%	70%				66%	71%		66%	61%

Le score représente le niveau global de consensus. Par exemple, il existe un consensus général (82 %) sur le fait que les agents de santé doivent être formés et expérimentés pour administrer des injections d'ocytocine dans le cadre de la prévention et du traitement de l'HPP ; en revanche, il existe un consensus limité (39 %) sur le fait que les agents de santé doivent être formés et expérimentés pour effectuer une embolisation de l'artère utérine pour le traitement de l'HPP réfractaire.

For more information, please contact:

Department of Sexual and Reproductive Health and Research
World Health Organization
Geneva
Switzerland
Email: srhmph@who.int

